



Optimal
Untuk
Negeri



optimal

Buku Referensi

KEPERAWATAN MATERNITAS

Asuhan Klinis Komprehensif Pra Konsepsi hingga Nifas

Ernawati • Handayani • Sri Djuwitaningsih
Megayana Yessy Maretta • Regina Ona Adesta • Asmarita Jasda



BUKU REFERENSI KEPERAWATAN MATERNITAS: ASUHAN KLINIS KOMPREHENSIF PRA KONSEPSI HINGGA NIFAS

Penulis:

Ernawati, S.Kep., Ns., M.Kes., M.Kep.

Handayani, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat.

Dr. Ns. Sri Djuwitaningsih, S.Kp., M.Kes., Sp.Mat.

Megayana Yessy Maretta, SST., M.Keb.

Regina Ona Adesta, S.Kep., Ns., M.Kep.

Asmarita Jasda, S.Kep., M.Si.Med.



Buku Referensi Keperawatan Maternitas: Asuhan Klinis Komprehensif Pra Konsepsi hingga Nifas

Penulis:

Ernawati, S.Kep., Ns., M.Kes., M.Kep.
Handayani, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat.
Dr. Ns. Sri Djuwitaningsih, S.Kp., M.Kes., Sp.Mat.
Megayana Yessy Mareta, SST., M.Keb.
Regina Ona Adesta, S.Kep., Ns., M.Kep.
Asmarita Jasda, S.Kep., M.Si.Med.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7756-05-3

Cetakan Pertama : Mei, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku referensi yang berjudul “Keperawatan Maternitas: Asuhan Klinis Komprehensif Pra Konsepsi hingga Nifas” ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan ilmu keperawatan, khususnya pada bidang keperawatan maternitas yang memiliki peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak.

Keperawatan maternitas merupakan salah satu bidang praktik keperawatan yang menitikberatkan pada pemberian asuhan holistik kepada perempuan sepanjang siklus reproduksi, dimulai dari masa pra konsepsi, kehamilan, persalinan, hingga masa nifas. Perjalanan tersebut bukan hanya melibatkan perubahan fisiologis, tetapi juga aspek psikologis, sosial, dan budaya yang memerlukan pendekatan komprehensif dan berbasis bukti. Oleh karena itu, tenaga kesehatan, khususnya perawat, dituntut untuk memiliki pengetahuan yang mendalam, keterampilan klinis yang mumpuni, serta sikap profesional dalam memberikan pelayanan yang aman, efektif, dan berpusat pada pasien.

Buku ini hadir sebagai sumber referensi yang dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai konsep dasar dan praktik klinis dalam keperawatan maternitas. Materi yang disajikan mencakup berbagai topik penting, mulai dari persiapan kehamilan (pra konsepsi), perubahan fisiologis dan psikologis selama kehamilan, proses persalinan, hingga perawatan ibu pada masa nifas. Selain itu, buku ini juga membahas berbagai kondisi patologis yang mungkin terjadi serta pendekatan asuhan keperawatan yang sesuai, dengan mengacu pada prinsip evidence-based practice.

Penyusunan buku ini bertujuan untuk membantu mahasiswa keperawatan, praktisi kesehatan, serta tenaga pendidik dalam memahami dan mengaplikasikan konsep keperawatan maternitas secara komprehensif. Diharapkan buku ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu, serta berkontribusi dalam menurunkan angka morbiditas dan mortalitas maternal.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan buku ini.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas dan menjadi salah satu referensi yang mendukung peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan keperawatan maternitas yang berkualitas, humanis, dan profesional.

Penulis

Mei, 2026

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I KONSEP DASAR KEPERAWATAN MATERNITAS (CONTINUUM OF CARE, KESELAMATAN PASIEN, ETIKA, BUDAYA DAN KOMUNIKASI TERAPEUTIK)

1	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Konsep Continuum of Care dalam Keperawatan Maternitas	3
C. Konsep Keselamatan Pasien dalam Keperawatan Maternitas.....	6
D. Konsep Etika dalam Keperawatan Maternitas.....	8
E. Konsep Budaya dalam Keperawatan Maternitas.....	9
F. Konsep Komunikasi Terapeutik dalam Keperawatan Maternitas.....	11
G. Penutup	13
Referensi.....	15

BAB II PENGKAJIAN MATERNITAS KOMPREHENSIF (ANAMNESIS, PEMERIKSAAN FISIK, INTERPRETASI TANDA VITAL, PENILAIAN NYERI, DAN SKRINING RISIKO)

21	21
A. Pendahuluan.....	21
B. Anamnesis	22
C. Pemeriksaan Fisik Maternitas Komprehensif	26
D. Interpretasi Tanda-Tanda Vital (TTV).....	28
E. Penilaian Nyeri Maternitas	28
F. Pemeriksaan Penunjang (Laboratorium & Diagnostik).....	32
G. Skrining Risiko Maternitas.....	33
H. Penutup	35
Referensi.....	36

BAB III ASUHAN KEPERAWATAN PRAKONSEPSI DAN ANTENATAL

37	37
A. Pendahuluan.....	37
B. Gizi pada Masa Prakonsepsi dan Antenatal.....	42
C. Imunisasi	49
D. Perencanaan Kehamilan	52

E. Ketidaknyamanan Kehamilan	56
F. Edukasi Prakonsepsi dan Kehamilan.....	58
G. Penutup	59
Referensi.....	60
BAB IV ASUHAN KEPERAWATAN INTRANATAL.....	67
A. Pendahuluan.....	67
B. Pemantauan Kemajuan Persalinan	67
B. Dukungan Nonfarmakologis	76
C. Manajemen Nyeri Persalinan.....	79
D. Tahapan Persalinan	82
E. Kesiapsiagaan Komplikasi.....	83
F. Keselamatan Ibu dan Janin.....	85
G. Asuhan Keperawatan Intra Natal	87
H. Penutup	92
Referensi.....	93
 BAB V ASUHAN KEPERAWATAN POSTPARTUM DAN LAKTASI (PEMULIHAN NIFAS, PERAWATAN PERINEUM, INVOLUSI, PENCEGAHAN INFEKSI, DUKUNGAN MENYUSUI, DAN BONDING ATTACHMENT)	95
A. Pendahuluan.....	95
C. Pemulihan Masa Nifas.....	98
D. Perawatan Perineum.....	100
E. Proses Involusi Uterus.....	101
F. Bonding Attachment Ibu Dan Bayi.....	103
G. Peran perawat dalam asuhan postpartum dan laktasi.....	104
H. Penutup	106
Referensi.....	106
 BAB VI KEGAWATDARURATAN OBSTETRI UNTUK PERAWAT (PERDARAHAN ANTEPARTUM/POSTPARTUM, PREEKLAMPSIA/EKLAMPSIA, SEPSIS, EMBOLI, SYOK, DAN RUJUKAN AMAN	109
A. Pendahuluan.....	109
B. Perdarahan Antepartum Dan Postpartum	110
C. Preklamsia Dan Eklamsia.....	112

D. Sepsis Obstetri	114
E. Emboli Dalam Kehamilan	115
F. Syok Pada Kegawatdaruratan Obstetri	117
G. Rujukan Aman Dalam Kegawatdaruratan Obstetri.....	118
H. Penutup	120
Referensi.....	121

BAB VII ASUHAN KEPERAWATAN NEONATUS DASAR TERKAIT

MATERNITAS.....	123
A. Pendahuluan.....	123
B. Perawatan Bayi Baru Lahir	124
C. Inisiasi Penyusu Dini (IMD)	125
D. Pencegahan Hipotermia.....	126
E. Skrining Awal.....	128
F. Edukasi Perawatan Bayi di Rumah.....	128
G. Penutup	129
Referensi.....	130

PROFIL PENULIS	133
-----------------------------	------------

BAB I

KONSEP DASAR KEPERAWATAN MATERNITAS (CONTINUUM OF CARE, KESELAMATAN PASIEN, ETIKA, BUDAYA DAN KOMUNIKASI TERAPEUTIK)

A. Pendahuluan

Keperawatan maternitas merupakan salah satu cabang ilmu keperawatan yang memiliki kompleksitas tinggi karena melibatkan dua individu sekaligus, yaitu ibu dan bayi, dalam satu kesatuan pelayanan kesehatan. Pelayanan yang diberikan tidak hanya berorientasi pada kondisi fisiologis, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, budaya, dan spiritual yang saling berinteraksi sepanjang siklus reproduksi Perempuan (Bernardino, 2022). Oleh karena itu, pendekatan dalam keperawatan maternitas tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus bersifat komprehensif, berkelanjutan, dan berpusat pada kebutuhan individu. Pendekatan holistik ini didukung oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa asuhan maternitas berbasis holistik berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup ibu dan luaran neonatal (Sukmawati & Alfiani, 2025).

Dalam beberapa dekade terakhir, pendekatan pelayanan kesehatan ibu mengalami pergeseran paradigma dari model kuratif menuju model promotif dan preventif yang terintegrasi. Salah satu pendekatan yang banyak direkomendasikan adalah *continuum of care*, yaitu pelayanan kesehatan yang diberikan secara berkesinambungan sejak sebelum kehamilan hingga masa nifas dan perawatan bayi baru lahir. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan kualitas layanan serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi secara signifikan (World Health Organization, 2025). Studi berbasis data longitudinal di negara berkembang menunjukkan bahwa penerapan *continuum of care* secara konsisten dapat menurunkan risiko komplikasi kehamilan hingga 30% dan meningkatkan kunjungan antenatal secara bermakna (Id et al., 2024). Penelitian di Indonesia menemukan bahwa ibu yang mendapatkan pelayanan berkelanjutan memiliki tingkat kepatuhan perawatan kehamilan dan nifas yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak (Rammohan, Goli & Chu, 2024).

Selain kesinambungan pelayanan, aspek keselamatan pasien menjadi perhatian utama dalam praktik keperawatan maternitas. Tingginya risiko komplikasi

obstetri menuntut tenaga kesehatan untuk menerapkan prinsip-prinsip keselamatan pasien secara konsisten. Kesalahan dalam pelayanan, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis, dapat berdampak fatal terhadap ibu dan janin. Oleh karena itu, integrasi sistem keselamatan pasien dalam setiap tindakan keperawatan menjadi suatu keharusan (Biquet, 2020). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa implementasi standar keselamatan pasien, seperti penggunaan *clinical pathway* dan *early warning system*, secara signifikan menurunkan kejadian adverse events pada ibu bersalin (World Health Organization, 2021). Selain itu, pelatihan keselamatan pasien berbasis simulasi terbukti meningkatkan kompetensi klinis perawat dalam menangani kegawatdaruratan obstetri (Af et al., 2020).

Di sisi lain, praktik keperawatan maternitas juga tidak terlepas dari dimensi etika dan budaya. Perawat sering dihadapkan pada situasi yang melibatkan nilai, keyakinan, dan preferensi pasien yang beragam. Pengambilan keputusan klinis tidak hanya didasarkan pada pertimbangan medis, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip etika serta sensitivitas budaya. Pendekatan yang tidak memperhatikan aspek ini berpotensi menimbulkan konflik dan menurunkan kualitas pelayanan (Beauchamp & Childress, 2019). Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *culturally competent care* dalam keperawatan maternitas dapat meningkatkan kepuasan pasien serta kepercayaan terhadap tenaga kesehatan (Shorey, Ng & Downe, 2021). Di Indonesia, integrasi nilai budaya lokal dalam asuhan kehamilan terbukti meningkatkan penerimaan intervensi kesehatan, khususnya pada komunitas dengan kepercayaan tradisional yang kuat (Sukmawati & Alfiani, 2025).

Komunikasi terapeutik menjadi elemen penting yang menjembatani seluruh aspek tersebut. Melalui komunikasi yang efektif, perawat dapat membangun hubungan saling percaya, memahami kebutuhan pasien secara mendalam, serta memberikan edukasi yang tepat. Dalam konteks maternitas, komunikasi yang baik terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan ibu dalam menjalani perawatan serta keberhasilan intervensi kesehatan (Silverman et al., 2022). Penelitian terkini menunjukkan bahwa intervensi komunikasi berbasis edukasi dan konseling mampu meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif serta menurunkan tingkat kecemasan ibu postpartum (Pratiwi et al., 2021). Selain itu, penggunaan pendekatan komunikasi berbasis keluarga (*family-centered care*) juga terbukti meningkatkan dukungan sosial ibu selama masa kehamilan dan nifas (Pratiwi et al., 2021).

Dengan demikian, pemahaman mengenai konsep dasar keperawatan maternitas menjadi landasan penting bagi perawat dalam memberikan asuhan yang berkualitas. Integrasi antara *continuum of care*, keselamatan pasien, etika, budaya, dan komunikasi terapeutik yang berbasis evidence-based practice menjadi kunci dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak. Bab ini akan menguraikan

secara mendalam mengenai konsep-konsep tersebut sebagai pilar utama dalam praktik keperawatan maternitas yang profesional dan berorientasi pada keselamatan pasien.

B. Konsep Continuum of Care dalam Keperawatan Maternitas

Continuum of care merupakan pendekatan dalam pelayanan kesehatan yang menekankan kesinambungan asuhan sepanjang siklus kehidupan, khususnya dalam konteks kesehatan ibu dan anak. Dalam keperawatan maternitas, pendekatan ini mencakup seluruh fase reproduksi perempuan, mulai dari pra-konsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, hingga perawatan bayi baru lahir. Pendekatan ini berkembang sebagai respons terhadap masih tingginya angka kematian ibu dan bayi yang berkaitan dengan keterlambatan dalam pengambilan keputusan, keterlambatan mencapai fasilitas kesehatan, serta keterlambatan dalam memperoleh pelayanan yang adekuat (World Health Organization, 2022) menekankan kesinambungan waktu, pendekatan ini juga menitikberatkan pada kesinambungan tempat pelayanan yang terintegrasi dari tingkat keluarga, komunitas, hingga fasilitas rujukan, sehingga mampu meminimalkan kesenjangan pelayanan kesehatan (*missed opportunities of care*) (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Secara empiris, pendekatan *continuum of care* terbukti memberikan dampak positif terhadap luaran kesehatan maternal dan neonatal. Analisis global menunjukkan bahwa integrasi pelayanan kesehatan secara berkesinambungan dari masa pra-konsepsi hingga periode neonatal mampu menurunkan angka kematian ibu dan bayi secara signifikan (Kerber, et al, 2007). Temuan ini sejalan dengan penelitian di Indonesia yang menyatakan bahwa perempuan yang menerima pelayanan kesehatan secara berkelanjutan memiliki peluang lebih besar untuk mengalami persalinan yang aman dibandingkan dengan mereka yang hanya menerima pelayanan secara parsial (Rammohan, Goli & Chu, 2024).

Pendekatan *continuum of care* dalam keperawatan maternitas berlandaskan pada prinsip pelayanan yang berpusat pada perempuan (*woman-centered care*), di mana perempuan diposisikan sebagai subjek utama yang memiliki hak dalam pengambilan keputusan terkait kesehatannya. Model pelayanan ini terbukti mampu meningkatkan pengalaman persalinan serta menurunkan intervensi medis yang tidak diperlukan, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Turienzo, et al. (2024). Selain itu, pendekatan ini juga menekankan pentingnya pelayanan yang berbasis pada kebutuhan individu, mengingat setiap perempuan memiliki kondisi biologis, psikologis, dan sosial yang berbeda. Pendekatan individual ini memungkinkan tenaga kesehatan untuk memberikan intervensi yang lebih tepat sasaran dan efektif,

yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan kesehatan maternal (Marthias et al., 2025).

Prinsip integrasi dan kesinambungan pelayanan juga menjadi landasan utama dalam pendekatan ini, di mana setiap fase kehidupan reproduksi perempuan harus saling terhubung dalam suatu sistem pelayanan yang terkoordinasi (Turienzo et al., 2024). Fragmentasi layanan terbukti meningkatkan risiko komplikasi, sehingga integrasi layanan menjadi sangat penting dalam meningkatkan keselamatan ibu dan bayi. Laporan UNICEF (2021) menunjukkan bahwa integrasi pelayanan kesehatan maternal dan neonatal mampu menurunkan angka kematian neonatal secara signifikan. Dalam implementasinya, pendekatan ini juga memerlukan kolaborasi interprofesional yang kuat antara perawat, bidan, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang efektif serta pengambilan keputusan klinis yang lebih tepat. Seluruh intervensi yang dilakukan dalam kerangka *continuum of care* harus berbasis pada *evidence-based practice* guna menjamin efektivitas dan keamanan pelayanan yang diberikan.

Implementasi *continuum of care* dalam keperawatan maternitas dilakukan melalui tahapan yang saling berkesinambungan. Pada tahap pra-konsepsi, pelayanan difokuskan pada upaya mempersiapkan kondisi kesehatan perempuan sebelum kehamilan melalui optimalisasi status gizi, suplementasi asam folat, serta pengendalian penyakit kronis. Intervensi pada tahap ini terbukti memiliki dampak signifikan dalam menurunkan risiko komplikasi kehamilan, termasuk bayi berat lahir rendah dan kelahiran premature (Stephenson et al., 2021).

Selanjutnya, pada tahap kehamilan, pelayanan antenatal berperan penting dalam memantau kesehatan ibu dan janin serta mendeteksi dini komplikasi yang mungkin terjadi. World Health Organization (2025) merekomendasikan minimal delapan kali kunjungan antenatal untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menurunkan risiko komplikasi. Keberlanjutan pelayanan antenatal juga terbukti meningkatkan kepatuhan ibu terhadap kunjungan kesehatan serta penggunaan fasilitas kesehatan saat persalinan (Rammohan, Goli & Chu, 2024).

Pada fase persalinan, pelayanan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi menjadi sangat penting mengingat periode ini merupakan fase kritis dalam siklus reproduksi perempuan. Dukungan kontinu selama persalinan terbukti memberikan dampak positif terhadap pengalaman ibu serta menurunkan intervensi medis yang tidak diperlukan. Meta-analisis oleh Bohren, et al. (2020) menunjukkan bahwa perempuan yang mendapatkan dukungan berkelanjutan selama persalinan memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi serta risiko intervensi medis yang lebih rendah.

Setelah persalinan, masa nifas merupakan periode pemulihan yang tidak kalah penting dan masih memiliki risiko tinggi terhadap komplikasi fisik maupun

psikologis. Pelayanan nifas yang komprehensif mencakup pemantauan kondisi ibu, dukungan dalam proses menyusui, serta skrining terhadap gangguan kesehatan mental seperti depresi postpartum (Bohren, et al., 2017). Penelitian oleh Shorey S et al. (2021) menunjukkan bahwa intervensi psikologis yang diberikan pada masa nifas efektif dalam menurunkan kejadian depresi postpartum. Selain itu, dukungan yang diberikan pada masa ini juga berperan penting dalam meningkatkan keberhasilan pemberian ASI eksklusif, sebagaimana ditunjukkan oleh Rollins NC et al. (2021).

Pendekatan *continuum of care* tidak hanya berfokus pada ibu, tetapi juga mencakup bayi baru lahir sebagai satu kesatuan dalam pelayanan Kesehatan (Rollins et al., 2023). Perawatan bayi baru lahir meliputi inisiasi menyusui dini, pemantauan kondisi fisiologis, serta pemberian imunisasi dasar. Integrasi pelayanan antara ibu dan bayi terbukti meningkatkan keberlangsungan perawatan serta menurunkan angka kematian neonatal (Marthias et al., 2025).

Dalam keseluruhan proses tersebut, perawat memiliki peran yang sangat strategis dan multidimensional. Perawat tidak hanya bertindak sebagai pemberi asuhan langsung, tetapi juga sebagai edukator yang meningkatkan literasi kesehatan ibu, sebagai koordinator layanan yang memastikan kesinambungan pelayanan, serta sebagai advokat yang memperjuangkan hak-hak pasien. Model pelayanan berbasis kontinuitas yang melibatkan tenaga kesehatan secara konsisten terbukti mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien (Turienzo et al., 2024).

Meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi *continuum of care* masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di negara berkembang. Keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan, kurangnya koordinasi antar layanan, serta rendahnya literasi kesehatan masyarakat menjadi hambatan utama dalam penerapan pendekatan ini (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022). Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, pengembangan kebijakan yang mendukung integrasi layanan, serta pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kesehatan ibu dan anak.

Secara keseluruhan, *continuum of care* dalam keperawatan maternitas merupakan pendekatan komprehensif berbasis bukti yang menekankan kesinambungan pelayanan sepanjang siklus reproduksi perempuan. Implementasi yang optimal terbukti mampu meningkatkan kualitas asuhan serta menurunkan morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi secara signifikan (World Health Organization, 2025; Rammohan, Goli & Chu, 2024). Perawat memegang peran kunci dalam keberhasilan pendekatan ini melalui pelayanan yang terintegrasi, berpusat pada pasien, dan berbasis *evidence-based practice*.

C. Konsep Keselamatan Pasien dalam Keperawatan Maternitas

Konsep keselamatan pasien dalam keperawatan maternitas tidak hanya berhenti pada pemahaman prinsip, tetapi harus diterjemahkan ke dalam tahapan operasional yang sistematis, terintegrasi, dan berbasis bukti. Pendekatan ini sejalan dengan kerangka keselamatan pasien yang dikembangkan oleh World Health Organization yang menekankan pentingnya sistem yang proaktif, sistemik, dan berorientasi pada pencegahan, bukan sekadar respons terhadap insiden (WHO, 2022). Laporan global terbaru menunjukkan bahwa sekitar satu dari sepuluh pasien mengalami kejadian tidak diharapkan dalam pelayanan kesehatan, dan hampir 50% kejadian tersebut dapat dicegah melalui sistem keselamatan yang efektif (WHO, 2022).

Secara operasional, tahapan pertama adalah identifikasi dan asesmen risiko secara komprehensif sejak awal kontak pelayanan. Pada fase antenatal, perawat melakukan skrining risiko berbasis standar untuk mendeteksi kondisi seperti preeklamsia, anemia, infeksi, serta riwayat obstetri berisiko tinggi. Deteksi dini gangguan hipertensi dalam kehamilan terbukti menurunkan risiko komplikasi maternal berat secara signifikan (Elorriaga et al., 2025). Pendekatan skrining sistematis ini diperkuat oleh rekomendasi Society for Maternal-Fetal Medicine yang menekankan penggunaan checklist triase untuk meningkatkan deteksi dini komplikasi kehamilan (André et al., 2025). Pada fase intrapartum, asesmen dilanjutkan melalui pemantauan kemajuan persalinan menggunakan partograf serta observasi ketat terhadap tanda bahaya seperti perdarahan dan fetal distress, yang merupakan penyebab utama kematian maternal dan neonatal yang sebenarnya dapat dicegah (WHO, 2023).

Tahapan kedua adalah perencanaan asuhan berbasis risiko (*risk-based care planning*). Setelah risiko diidentifikasi, perawat menyusun rencana asuhan individual yang mencakup strategi pencegahan, kesiapsiagaan terhadap komplikasi, serta sistem rujukan yang tepat. Pendekatan ini terbukti meningkatkan kualitas pelayanan maternitas dan menurunkan morbiditas maternal dan neonatal (Kozhimannil et al., 2020). Selain itu, bukti terbaru menunjukkan bahwa kesenjangan dalam kualitas perencanaan asuhan masih menjadi faktor utama tingginya komplikasi maternitas secara global (Tunçalp et al., 2025).

Tahapan ketiga adalah implementasi intervensi keselamatan pasien berbasis standar dan protokol klinis. Pada tahap ini, perawat menerapkan prinsip keselamatan pasien seperti enam benar dalam pemberian obat, pencegahan infeksi, serta penggunaan alat bantu klinis berbasis bukti. Implementasi *WHO Safe Childbirth Checklist* terbukti meningkatkan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap praktik esensial dan berkontribusi pada penurunan komplikasi maternal dan

neonatal (Molina et al., 2021). Bukti terbaru dari meta-analisis menunjukkan bahwa penggunaan checklist ini secara signifikan meningkatkan praktik berbasis bukti dan berkontribusi terhadap penurunan stillbirth serta komplikasi persalinan (Kaplan et al., 2026). Selain itu, strategi implementasi checklist berbasis sistem terbukti meningkatkan kualitas keselamatan layanan secara konsisten di berbagai setting (Elorriaga et al., 2025).

Tahapan keempat adalah komunikasi efektif dan kolaborasi interprofesional. Dalam pelayanan maternitas yang kompleks, komunikasi menjadi faktor kunci dalam mencegah kesalahan medis. Penggunaan komunikasi terstruktur seperti SBAR terbukti meningkatkan akurasi informasi klinis dan menurunkan risiko kesalahan (André et al., 2025). Selain itu, pendekatan sistemik dalam keselamatan pasien menekankan pentingnya kerja tim dan koordinasi antar tenaga kesehatan dalam meningkatkan outcome maternal dan neonatal (Molina et al., 2021).

Tahapan kelima adalah monitoring, evaluasi, dan pelaporan insiden keselamatan pasien. Perawat melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap kondisi ibu dan bayi serta mengevaluasi efektivitas intervensi yang diberikan. Sistem pelaporan insiden, termasuk kejadian nyaris cedera (*near miss*), merupakan bagian penting dalam pembelajaran organisasi dan peningkatan mutu layanan. Laporan global WHO menegaskan bahwa sistem pelaporan yang efektif merupakan komponen inti dalam menurunkan kejadian adverse events di fasilitas kesehatan (WHO, 2025).

Tahapan terakhir adalah penguatan budaya keselamatan pasien (*patient safety culture*). Budaya keselamatan mencakup komitmen organisasi, pelatihan berkelanjutan, serta kepemimpinan yang mendukung praktik aman. Studi global menunjukkan bahwa rendahnya kualitas pelayanan dan lemahnya budaya keselamatan berkontribusi terhadap tingginya angka kematian maternal di berbagai negara (Tunçalp et al., 2025). Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa penguatan budaya keselamatan pasien secara sistemik berkaitan dengan peningkatan kepatuhan praktik klinis dan penurunan komplikasi maternal serta neonatal (Kaplan et al., 2026).

Dengan demikian, keselamatan pasien dalam keperawatan maternitas merupakan proses berkelanjutan yang dimulai dari identifikasi risiko, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi dan pembentukan budaya keselamatan. Integrasi pendekatan berbasis sistem dan evidence terkini terbukti mampu meningkatkan kualitas pelayanan serta menurunkan komplikasi obstetri secara signifikan (Elorriaga et al., 2025).

D. Konsep Etika dalam Keperawatan Maternitas

Konsep etika dalam keperawatan maternitas tidak hanya berhenti pada pemahaman prinsip-prinsip bioetika seperti otonomi, beneficence, non-maleficence, dan keadilan, tetapi juga menuntut kemampuan implementasi yang kontekstual, reflektif, dan berbasis bukti. Dalam praktik klinis, perawat maternitas menghadapi kompleksitas karena keputusan yang diambil sering kali berdampak pada dua individu sekaligus, yaitu ibu dan janin. Oleh karena itu, pendekatan etik harus bersifat komprehensif, mempertimbangkan dimensi klinis, psikososial, budaya, dan sistem pelayanan kesehatan.

Dalam implementasinya, terdapat sejumlah hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, pemenuhan informed consent yang berkualitas menjadi aspek krusial dalam menjamin otonomi pasien. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tantangan dalam informed consent pada perinatal care tidak hanya terkait pemahaman informasi, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika komunikasi, tekanan situasional, dan relasi kuasa antara tenaga kesehatan dan pasien (Kokkosi et al., 2025). Hal ini menegaskan bahwa perawat tidak hanya berperan sebagai pemberi informasi, tetapi juga sebagai fasilitator pengambilan keputusan yang sadar dan bermakna.

Kedua, penerapan respectful maternity care (RMC) sebagai bentuk konkret dari prinsip beneficence dan non-maleficence menjadi semakin ditekankan dalam praktik modern. Studi intervensi terbaru menunjukkan bahwa pendekatan berbasis penghormatan terhadap pasien mampu menurunkan kejadian mistreatment dan meningkatkan pengalaman persalinan secara signifikan (Ikezoe et al., 2025). Selain itu, systematic review terbaru juga menegaskan bahwa implementasi RMC sangat dipengaruhi oleh kompetensi interpersonal tenaga kesehatan, nilai profesional, serta dukungan sistem organisasi (Ikezoe et al., 2025).

Ketiga, aspek sensitivitas budaya dan keadilan menjadi komponen penting dalam praktik etik maternitas. Penelitian global terbaru menunjukkan bahwa etika kebidanan modern tidak hanya berakar pada prinsip bioetika klasik, tetapi juga pada konsep relational ethics dan reproductive justice yang menekankan kesetaraan akses dan penghormatan terhadap pengalaman perempuan (Buchanan et al., 2025). Hal ini memperluas makna keadilan tidak hanya sebagai distribusi layanan, tetapi juga sebagai keadilan dalam pengalaman pelayanan.

Keempat, pentingnya lingkungan pelayanan yang aman secara psikologis dan etis juga menjadi perhatian dalam evidence terbaru. Studi tahun 2025 menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk, budaya organisasi yang tidak suportif, serta trauma tenaga kesehatan dapat meningkatkan risiko tindakan tidak etis dan menurunkan kualitas asuhan maternitas (Javornická et al., 2025). Dengan demikian, etika tidak

hanya menjadi tanggung jawab individu perawat, tetapi juga merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan.

Dalam menghadapi dilema etik, diperlukan langkah-langkah operasional yang sistematis. Proses ini dimulai dengan identifikasi masalah etik, termasuk konflik nilai yang terjadi antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data komprehensif, baik data klinis maupun preferensi pasien. Tahap berikutnya adalah analisis etik menggunakan prinsip bioetika, di mana berbagai alternatif tindakan dipertimbangkan berdasarkan manfaat, risiko, dan nilai yang terlibat.

Pengambilan keputusan kemudian dilakukan melalui pendekatan kolaboratif (shared decision-making) dengan melibatkan pasien dan tim interprofesional. Evidence terbaru menunjukkan bahwa pendekatan ini meningkatkan kualitas keputusan klinis sekaligus memperkuat otonomi pasien. Selain itu, pendekatan seperti Moral Case Deliberation (MCD) terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam menyelesaikan dilema etik serta meningkatkan praktik respectful maternity care (Samsami, 2025).

Tahap akhir adalah evaluasi dan refleksi etik, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas praktik di masa depan serta mengurangi kejadian distress moral pada tenaga kesehatan. Proses refleksi ini juga penting dalam membangun budaya etik yang berkelanjutan dalam pelayanan maternitas.

Dengan demikian, praktik etika dalam keperawatan maternitas harus dipahami sebagai proses dinamis yang mengintegrasikan prinsip bioetika, komunikasi efektif, sensitivitas budaya, serta dukungan sistem organisasi. Evidence terbaru (2024–2026) secara konsisten menunjukkan bahwa penguatan praktik etik tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga berdampak langsung pada keselamatan ibu dan bayi serta pengalaman persalinan yang lebih positif.

E. Konsep Budaya dalam Keperawatan Maternitas

Konsep budaya dalam keperawatan maternitas tidak hanya menuntut pemahaman teoritis, tetapi juga kemampuan operasional perawat dalam mengintegrasikan nilai budaya pasien dengan prinsip keselamatan dan praktik berbasis bukti. Budaya membentuk cara individu memaknai kehamilan, persalinan, serta perawatan ibu dan bayi, sehingga setiap intervensi keperawatan harus mempertimbangkan konteks sosial dan kepercayaan yang melatarbelakanginya. Dalam kerangka *cultural competence*, sebagaimana dikembangkan oleh Josepha Campinha-Bacote, kompetensi budaya merupakan proses dinamis yang mencakup kesadaran, pengetahuan, keterampilan, interaksi, dan keinginan budaya.

Dalam praktik keperawatan maternitas, terdapat beberapa aspek krusial yang perlu diperhatikan oleh perawat. Pertama, asesmen budaya yang komprehensif menjadi fondasi utama dalam memberikan asuhan yang tepat. Asesmen ini mencakup eksplorasi nilai, kepercayaan, praktik tradisional, serta peran keluarga dalam pengambilan keputusan. Studi *scoping review* terbaru menunjukkan bahwa kurangnya kemampuan tenaga kesehatan dalam memahami budaya pasien berdampak pada rendahnya kualitas komunikasi dan hubungan terapeutik, yang pada akhirnya menghambat efektivitas pelayanan maternitas (Dalmaijer et al., 2025).

Kedua, perawat perlu menghindari etnosentrisme dan mengedepankan pendekatan *culturally responsive care*. Penelitian tahun 2026 menunjukkan bahwa kompetensi budaya berhubungan dengan peningkatan kepercayaan pasien, perilaku kesehatan yang lebih baik, serta luaran maternal seperti keberhasilan menyusui dan kepuasan pelayanan (Tsai et al., 2015). Hal ini menegaskan bahwa pendekatan budaya bukan sekadar aspek etis, tetapi merupakan determinan klinis yang signifikan.

Ketiga, komunikasi terapeutik berbasis budaya menjadi strategi inti dalam praktik. Hambatan komunikasi sering kali menjadi penyebab utama kegagalan intervensi. Penelitian tahun 2025 dalam konteks obstetric nursing menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi yang sensitif budaya secara signifikan meningkatkan kepuasan ibu dan kualitas pengalaman persalinan (Melanson, 2025). Selain itu, penelitian di Indonesia menegaskan bahwa aspek komunikasi dan penghormatan terhadap nilai budaya masih menjadi kelemahan utama dalam pelayanan maternitas inklusif (Amalia et al., 2025).

Keempat, perawat harus mampu melakukan klasifikasi praktik budaya menjadi tiga kategori: praktik yang mendukung kesehatan, praktik yang netral, dan praktik yang berisiko. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *culturally congruent care*, di mana praktik budaya yang tidak membahayakan dapat dipertahankan, sedangkan praktik yang berisiko perlu dimodifikasi melalui edukasi berbasis bukti. Penelitian terbaru tahun 2026 menunjukkan bahwa integrasi praktik tradisional dengan pelayanan medis modern secara sensitif budaya dapat meningkatkan keberhasilan intervensi kesehatan maternal di komunitas lokal (Meihartati & Abiyoga, 2026).

Secara operasional, pendekatan perawat dalam menyelesaikan konflik budaya dapat dilakukan melalui tahapan sistematis. Tahap pertama adalah membangun hubungan saling percaya (*trust building*), yang menjadi dasar keberhasilan intervensi. Bukti dari *systematic review* Scopus Q1 menunjukkan bahwa intervensi berbasis peningkatan kompetensi budaya secara signifikan meningkatkan kualitas hubungan terapeutik dan outcome pasien (Rahagia & Nurhanifah, 2025).

Tahap kedua adalah eksplorasi makna budaya (*cultural exploration*), yaitu menggali alasan di balik praktik yang diyakini pasien tanpa memberikan penilaian. Tahap ini penting untuk memahami dimensi spiritual, sosial, dan historis dari praktik tersebut. Tahap ketiga adalah negosiasi budaya (*cultural negotiation*), di mana perawat menyampaikan risiko secara ilmiah dan menawarkan alternatif yang lebih aman tanpa menghilangkan nilai budaya pasien.

Tahap keempat adalah *shared decision making*, yaitu pengambilan keputusan bersama antara perawat, pasien, dan keluarga. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan terhadap intervensi kesehatan maternal, terutama pada populasi dengan latar belakang budaya kuat (Dalmajier et al., 2025). Tahap terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut untuk memastikan bahwa intervensi yang disepakati memberikan dampak positif terhadap kesehatan ibu dan bayi.

Dengan demikian, penerapan konsep budaya dalam keperawatan maternitas harus dipahami sebagai pendekatan klinis berbasis bukti (*evidence-based cultural care*), bukan sekadar toleransi terhadap perbedaan. Perawat dituntut untuk mampu mengintegrasikan aspek budaya, komunikasi terapeutik, dan keselamatan pasien dalam satu kesatuan praktik profesional. Pendekatan ini terbukti secara empiris mampu meningkatkan kualitas pelayanan, kepuasan pasien, serta luaran kesehatan maternal dan neonatal secara signifikan.

F. Konsep Komunikasi Terapeutik dalam Keperawatan Maternitas

Komunikasi terapeutik merupakan salah satu keterampilan inti dalam praktik keperawatan maternitas yang tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai intervensi klinis yang berdampak langsung terhadap kualitas asuhan dan keselamatan ibu serta bayi. Dalam konteks maternitas, komunikasi terapeutik menjadi semakin kompleks karena melibatkan kondisi fisiologis, psikologis, sosial, dan budaya yang saling berinteraksi sepanjang periode kehamilan hingga nifas.

Dalam praktiknya, komunikasi terapeutik harus memperhatikan aspek emosional ibu. Perubahan hormonal selama kehamilan sering memicu kecemasan, ketakutan, dan ketidakpastian. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa komunikasi yang empatik, suportif, dan berbasis hubungan interpersonal mampu menurunkan kecemasan serta meningkatkan kepercayaan ibu terhadap tenaga kesehatan (Panjarwanto et al. 2025). Temuan ini diperkuat oleh studi kuantitatif tahun 2024 yang menunjukkan adanya hubungan signifikan antara komunikasi terapeutik bidan dengan tingkat kepuasan ibu hamil dalam pelayanan antenatal ($p < 0,05$), yang menegaskan bahwa kualitas komunikasi berkontribusi langsung terhadap pengalaman pasien (Care, 2025).

Selain aspek emosional, sensitivitas budaya menjadi komponen penting dalam komunikasi terapeutik maternitas. Nilai, kepercayaan, dan praktik tradisional sering kali memengaruhi keputusan ibu terkait kehamilan dan persalinan. Penelitian dalam jurnal *BMC Pregnancy and Childbirth* tahun 2025 menunjukkan bahwa komunikasi yang menghargai perspektif ibu dan melibatkan dialog dua arah meningkatkan kepercayaan (self-entrustment) serta kualitas hubungan antara ibu dan tenaga kesehatan (Yeganeh et al., 2025). Hal ini menegaskan bahwa pendekatan komunikasi tidak dapat bersifat otoriter, melainkan harus berbasis kemitraan.

Lebih lanjut, keterlibatan keluarga dalam komunikasi juga merupakan faktor penting dalam konteks maternitas, terutama di masyarakat kolektif. Evidence terbaru menunjukkan bahwa komunikasi yang melibatkan keluarga dapat memperkuat dukungan sosial, meningkatkan kepatuhan ibu terhadap pemeriksaan antenatal, serta memperbaiki outcome kesehatan ibu dan janin (Panjarwanto et al., 2025).

Dalam praktik operasional, komunikasi terapeutik juga harus diarahkan untuk menangani situasi ketika pasien menunjukkan perilaku atau keputusan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keperawatan maternitas, seperti penolakan intervensi medis atau kepercayaan terhadap mitos yang berisiko. Pendekatan yang digunakan harus sistematis dan berbasis evidence.

Tahap pertama adalah melakukan asesmen komunikasi secara komprehensif. Perawat perlu mengeksplorasi faktor yang mendasari perilaku pasien, termasuk tingkat pengetahuan, pengalaman sebelumnya, serta pengaruh budaya dan lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan model komunikasi terapeutik yang menekankan eksplorasi perspektif pasien sebagai dasar intervensi yang efektif (Sharma dan Gupta, 2023).

Tahap kedua adalah membangun hubungan saling percaya melalui komunikasi empatik dan non-judgmental. Studi terbaru tahun 2026 menunjukkan bahwa pendekatan terapeutik yang mengintegrasikan empati dan dukungan emosional secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan serta persepsi positif ibu terhadap asuhan yang diberikan (Sahalia dan Cakrawati, 2026).

Tahap ketiga adalah memberikan edukasi berbasis bukti secara bertahap dan kontekstual. Komunikasi harus menggunakan bahasa sederhana, interaktif, dan memastikan pemahaman pasien. Penelitian tahun 2025 menunjukkan bahwa komunikasi terapeutik memiliki hubungan signifikan dengan keberhasilan edukasi kesehatan dalam pelayanan kebidanan ($p = 0,003$), yang menegaskan pentingnya komunikasi sebagai alat edukatif (Sari, 2024).

Tahap keempat adalah melakukan negosiasi dan shared decision making. Perawat perlu mengintegrasikan nilai profesional dengan preferensi pasien dan

keluarga. Pendekatan ini terbukti meningkatkan kepatuhan pasien serta mengurangi resistensi terhadap intervensi Kesehatan (Shields et al. 2020).

Tahap terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut komunikasi. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa pasien memahami informasi yang diberikan dan mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Studi terbaru juga menunjukkan bahwa komunikasi terapeutik yang dilakukan secara berkelanjutan dapat meningkatkan self-efficacy ibu serta kemampuan adaptasi terhadap kehamilan (Putri et al., 2025).

Dengan demikian, komunikasi terapeutik dalam keperawatan maternitas merupakan proses yang kompleks, dinamis, dan berbasis hubungan interpersonal yang kuat. Integrasi antara empati, sensitivitas budaya, keterlibatan keluarga, serta pendekatan berbasis bukti ilmiah terbukti mampu meningkatkan kualitas asuhan, kepuasan pasien, serta outcome kesehatan ibu dan bayi secara signifikan.

G. Penutup

Keperawatan maternitas merupakan praktik profesional yang menuntut integrasi berbagai dimensi dalam satu kesatuan pelayanan yang utuh dan berkesinambungan. Kompleksitas asuhan yang melibatkan ibu dan bayi sebagai dua individu yang saling terkait menjadikan pendekatan parsial tidak lagi relevan. Sebaliknya, diperlukan pendekatan komprehensif yang mampu mengakomodasi aspek fisiologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual secara simultan. Dalam konteks ini, konsep *continuum of care* hadir sebagai kerangka utama yang memastikan kesinambungan pelayanan sejak pra-konsepsi hingga masa nifas dan perawatan bayi baru lahir, sehingga mampu meminimalkan kesenjangan pelayanan serta meningkatkan kualitas luaran kesehatan maternal dan neonatal.

Di sisi lain, keselamatan pasien menjadi fondasi yang tidak dapat dipisahkan dari setiap tahapan asuhan keperawatan maternitas. Penerapan prinsip patient safety secara sistematis, mulai dari identifikasi risiko, perencanaan berbasis risiko, implementasi intervensi standar, komunikasi efektif, hingga evaluasi dan penguatan budaya keselamatan merupakan upaya strategis dalam menurunkan kejadian komplikasi dan adverse events. Pendekatan ini menegaskan bahwa kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh kompetensi individu perawat, tetapi juga oleh sistem dan budaya organisasi yang mendukung praktik yang aman dan berbasis bukti.

Lebih lanjut, dimensi etika dan budaya memberikan kedalaman makna dalam praktik keperawatan maternitas. Pengambilan keputusan klinis tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan medis, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai, keyakinan, serta preferensi pasien dan keluarganya. Implementasi prinsip bioetika

melalui pendekatan yang kontekstual, disertai sensitivitas budaya yang tinggi, memungkinkan terciptanya pelayanan yang adil, menghargai martabat pasien, serta meningkatkan kepercayaan terhadap tenaga kesehatan. Dalam hal ini, perawat berperan sebagai advokat sekaligus mediator yang menjembatani kebutuhan klinis dengan nilai-nilai yang dianut pasien.

Seluruh aspek tersebut tidak dapat berjalan optimal tanpa didukung oleh komunikasi terapeutik yang efektif. Komunikasi dalam keperawatan maternitas bukan sekadar sarana pertukaran informasi, melainkan merupakan intervensi klinis yang berperan dalam membangun hubungan saling percaya, menurunkan kecemasan, serta meningkatkan kepatuhan dan partisipasi aktif pasien. Pendekatan komunikasi yang empatik, berbasis budaya, serta melibatkan keluarga terbukti mampu memperkuat kualitas asuhan dan mendukung keberhasilan intervensi kesehatan secara menyeluruh.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik keperawatan maternitas yang profesional harus dibangun di atas integrasi lima pilar utama, yaitu *continuum of care*, keselamatan pasien, etika, budaya, dan komunikasi terapeutik. Kelima pilar ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain dalam menghasilkan asuhan yang holistik, aman, dan berpusat pada pasien. Implementasi yang konsisten dan berbasis *evidence-based practice* akan menjadi kunci dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, sekaligus menjawab tantangan pelayanan maternitas di masa kini dan masa yang akan datang.

Referensi

- Af, F., Fr, B., Bwj, M., & Sg, O. (2020). Multi-professional simulation-based team training in obstetric emergencies for improving patient outcomes and trainees' performance (Review). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD011545.pub2>. www.cochranelibrary.com
- Amalia, R., Salim, L. A., Indriani, D., & Mustamu, A. C. (2025). Comparative analysis of diploma and undergraduate midwifery students' perceptions of inclusive maternity care in Indonesia, 2024 – 2025. 14(4), 293–299.
- André, Z., Semrau, K. E. A., Maria, T., Souza, S. De, Freitas, M. R. De, Olívia, C., Oliveira, P. De, Westgard, C. M., Mita, C., Tuller, D. E., Meneses, K. De, Freitas, S., & Molina, R. L. (2025). Implementation strategies for the WHO Safe Childbirth Checklist: a scoping review. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2025-112114>
- Authorization, H. A. L. (2020). Patient safety in medical humanitarian action: medical error To cite this version: HAL Id: tel-02884986 PATIENT SAFETY IN MEDICAL HUMANITARIAN ACTION. Medical error prevention and management.
- Beauchamp, T., & Childress, J. (2019). Principles of Biomedical Ethics: Marking Its Fortieth Anniversary. *The American journal of bioethics: AJOB*, 19(11), 9–12. <https://doi.org/10.1080/15265161.2019.1665402>
- Bernardino, E. (2022). Strengths-based Nursing and Healthcare in maternities: rethinking practices and continuity of care *. 1–6.
- Buchanan, K., Bayes, S., Newnham, E., Kirkham, M., & Nieuwenhuijze, M. (2025). Global perspectives of midwifery ethics: Crucial features for practice via an international Delphi study. *Midwifery*, 149(August), 104582. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2025.104582>
- Care, A. (2025). JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian Therapeutic Communication in Enhancing Pregnant Women' s Trust in. 4(10), 10114–10132.
- Dalmajir, M., Emmens, N., Jonge, A. De, Visser, S. S., & Feijen, E. I. (2025). Cultural competence of maternity care professionals caring for majority population of women with a low socioeconomic position: a scoping review. *Discover Public Health*. <https://doi.org/10.1186/s12982-025-00473-1>
- Eduhealth, J., Kebidanan, A., Husada, K., & Info, A. (2025). The Relationship Between Therapeutic Communication and Pain Intensity of First Stage Labor at Hj. Erlianawati Clinic in 2024. 16(02), 894–901. <https://doi.org/10.54209/eduhealth.v16i02>
- Elorriaga, M. F.-, Fifield, J., Semrau, K. E. A., Lipsitz, S., Tuller, D. E., Mita, C., Cho, C., Scott, H., Dhingra-, A. T. N., Allisyn, K., & Rose, M. (2025). Impact of the WHO safe Konsep Dasar Keperawatan Maternitas (Continuum Of Care, Keselamatan Pasien, Etika, Budaya Dan Komunikasi Terapeutik)

- childbirth checklist on birth attendant behavior and maternal- - newborn outcomes: A systematic review and meta- - analysis. January, 984–998. <https://doi.org/10.1002/ijgo.16123>
- Id, R. A., Gebre, S., Demelash, M., Belachew, T., Mohammed, A., Musema, A., & Sultan, M. (2024). The continuum of care for maternal health in Africa: A systematic review and meta-analysis. 1–17. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0305780>
- Ikezoe, H., Horiuchi, S., & Girón, M. (2025). Effectiveness of a respectful maternity care program in a Guatemalan indigenous region rural hospital: a quasi- experimental study. November, 1–11. <https://doi.org/10.3389/fgwh.2025.1640952>
- Javornická, D., Mari, S., Folkvord, E., Jaeken, A., & Krčmeryová, T. (2025). Exploring safety aspects of maternity care through the lens of midwifery students ' clinical experiences in Belgium , Czech republic , Estonia , Norway , Slovakia : A qualitative study.
- Kaplan, L. C., Delaney, M. M., Roddewig, P., Singh, S., Molina, R. L., Diba, F., Tuller, D. E., Bobanski, L., Hashmi, A., Marthoenis, M., Richert, K., Ichsan, I., Singh, V. P., Muhsin, M., Kumar, V., Sofyan, H., Vollmer, S., & Semrau, K. E. A. (2026). The World Health Organization Safe Childbirth Checklist on Essential Birth Practices and Perinatal Mortality: A Meta-Analysis. *JAMA Network Open*, 9(2), e2558269–e2558269. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2025.58269>
- Kaplan, L. C., et al. (2026). The WHO Safe Childbirth Checklist on essential birth practices and perinatal mortality: A meta-analysis. *JAMA Network Open*, 9(2), e2558269. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2025.58269>
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). Pedoman pelayanan kesehatan ibu dan anak.
- Kerber, K. J., de Graft-Johnson, J. E., Bhutta, Z. A., Okong, P., Starrs, A., & Lawn, J. E. (2007). Continuum of care for maternal, newborn, and child health: from slogan to service delivery. *Lancet* (London, England), 370(9595), 1358–1369. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(07\)61578-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61578-5)
- Kesehatan, J. I. (2026). Barongko Barongko. 4(3), 1020–1029.
- Kokkosi, E., Stavros, S., Moustakli, E., Vedam, S., Potiris, A., & Gourounti, K. (n.d.). Informed Consent in Perinatal Care: Challenges and Best Practices in Obstetric and Midwifery-Led Models Informed Consent in Perinatal Care: Challenges and Best. 0–21.
- Ma, B., Gj, H., Sakala, C., Rk, F., Cuthbert, A., Ma, B., Gj, H., Sakala, C., Rk, F., & Cuthbert, A. (2017). Continuous support for women during childbirth (Review). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD003766.pub6.www.cochranelibrary.com>

- Marthias, T., Anindya, K., Saputri, N. S., Putri, L. P., Atun, R., & Lee, J. T. (2025). Effective coverage for reproductive , maternal , neonatal and newborn health : an analysis of geographical and socioeconomic inequalities in 39 low- income countries. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2024-016549>
- Meihartati, T., & Abiyoga, A. (2026). Original Article Cultural Beliefs and Pregnancy Care among the Dayak Kenyah Community in East Kutai , Indonesia : An Ethnographic Study Implications for Practice : Implications for Practice : 8(1), 116–135.
- Melanson, K. (2025). satisfaction . 8(1), 1–2. <https://doi.org/10.35841/AAICCN-8.1.252>
- Molina, R. L., Bobanski, L., Dhingra-kumar, N., Moran, A. C., Taha, A., Kumar, S., & Semrau, K. E. A. (2021). Comment The WHO safe childbirth checklist after 5 years : future directions for improving outcomes. *The Lancet Global Health*, 10(3), e324–e325. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(21\)00556-8](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(21)00556-8)
- Pratiwi, D. M., Rejeki, S., & Juniarto, A. Z. (2021). Interventions to Reduce Anxiety in Postpartum Mother. 18. <https://doi.org/10.26714/mki.4.1.2021.62-71>
- Putri, D., Suharyanti, S., & Putri, E. E. (2025). Midwives ' therapeutic communication to treat antenatal depression. 10(1), 65–82.
- Rahagia, R., & Nurhanifah, D. (2025). Relationship of nurse therapeutic communication to inpatient satisfaction. 14(1), 27–35.
- Rammohan, A., Goli, S., & Chu, H. (2024). Continuum of care in maternal and child health in Indonesia. *Primary health care research & development*, 25, e17. <https://doi.org/10.1017/S1463423624000094>
- Riris Diana Rachmayanti, Rian Diana, Faisal Anwar, Ali Khomsan, Hadi Riyadi, Dyan Fajar Christiani, Rendra Kusuma, Pulung Siswantara, Muthmainnah Muthmainnah, Febrianti Qisti Arrum Bayumi, & Aninditya Ardhana Riswari. (2023). Culture, traditional beliefs and practices during pregnancy among the Madurese tribe in Indonesia. *British Journal of Midwifery*, 31(3). <https://doi.org/10.12968/bjom.2023.31.3.148>
- Rollins, N., Piwoz, E., Baker, P., Kingston, G., Mabaso, K. M., McCoy, D., Augusto, P., & Neves, R. (2023). Breastfeeding 2 Marketing of commercial milk formula : a system to capture parents , communities , science , and policy. 401. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(22\)01931-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01931-6)
- Safe, W. H. O., Checklist, C., & Guide, I. (n.d.). WHO Safe Childbirth Checklist Implementation Guide.

- Samsami, K. (2025). Effect of moral case deliberation on midwives ' knowledge and practice regarding respectful maternity care. 32(1), 222–235. <https://doi.org/10.1177/09697330241248736>
- Sari, A. K. (2024). HOW DOES THE THERAPEUTIC COMMUNICATION OF MIDWIVES AFFECT THE SATISFACTION OF PREGNANT MOTHERS IN RECEIVING ANTENATAL CARE (ANC) SERVICES. 8(1).
- Sharma NP, Gupta V (2023). Therapeutic Communication. [Updated 2023 Aug 2]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2026 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK567775/?utm>
- Shields, L. E., et al. (2020). Structured communication and patient safety in obstetrics. American Journal of Obstetrics & Gynecology, 223(1), 110.e1–110.e7. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2020.02.012>
- Shorey, S., Ng, E. D., & Downe, S. (2021). Cultural competence and experiences of maternity health care providers on care for migrant women: A qualitative meta-synthesis. Birth (Berkeley, Calif.), 48(4), 458–469. <https://doi.org/10.1111/birt.12581>
- Silverman, J., Kurtz, S. & Draper, J. (2013). Skills for communicating with patients (3rd ed.). CRC Press.
- Stephenson, J., Schoenaker, D. A. J. M., Hinton, W., Poston, L., & Barker, M. (2021). Clinical Practice A wake-up call for preconception health : a clinical review. May, 233–236.
- Sukmawati, E., & Alfiani, T. (2025). Holistic Approaches During Pregnancy and Their Implications for Midwifery Practice. 5.
- Tsai, T., Huang, S., & Lee, S. D. (2015). Tzu-I Tsai, Shu-Her Huang, and Shouu-Yih D. Lee 2. 10(6), 334–340. <https://doi.org/10.1089/bfm.2015.0005>
- Tunçalp, Ö., et al. (2025). Building a sustainable model for global maternal health. BMJ, 389, r1011. <https://doi.org/10.1136/bmj.r1011>
- Turienzo, F., Lv, J., & Ah, S. (2024). Sandall J, Fernandez Turienzo C, Devane D, Soltani H, Gillespie P, Gates S, Jones LV, Shennan AH, Rayment-Jones H. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004667.pub6.www.cochranelibrary.com>
- UNICEF. (2021). Maternal and newborn health coverage report.
- World Health Organization. (2021). World patient safety day 2021–2022: Goals—Safe maternal and newborn care. World Health Organization.

- World Health Organization. (2022). WHO recommendations on maternal and newborn care.
- World Health Organization. (2025). WHO recommendations on maternal health: Guidelines approved by the WHO Guidelines Review Committee (2nd ed.). World Health Organization.
- World Health Organization. (2025). Antenatal care recommendations for a positive pregnancy experience Maternal and fetal assessment update: imaging ultrasound before 24 weeks of pregnancy.
- Yeganeh, Z., Javadnoori, M., Abbaspoor, Z., Ebadi, A., & Montazeri, S. (2025). "Inspiring mothers' self-entrustment to midwives." midwives' and mothers' perceptions of effective communication in the maternity ward: a qualitative study.

BAB II

PENGKAJIAN MATERNITAS KOMPREHENSIF (ANAMNESIS, PEMERIKSAAN FISIK, INTERPRETASI TANDA VITAL, PENILAIAN NYERI, DAN SKRINING RISIKO)

A. Pendahuluan

Pengkajian maternitas komprehensif merupakan fondasi utama dalam asuhan kebidanan dan keperawatan yang bertujuan untuk memastikan transisi reproduksi yang aman dan berkualitas. Di tengah tantangan global untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), pengkajian yang sistematis sejak masa pra-konsepsi hingga nifas menjadi instrumen skrining primer yang tidak dapat ditawar. Pengkajian yang efektif tidak hanya berfokus pada parameter klinis-fisiologis, tetapi juga mengintegrasikan dimensi psikososial, budaya, dan emosional yang secara signifikan mempengaruhi hasil kesehatan (Lowdermilk et al., 2023). Kegagalan dalam melakukan pengkajian yang mendalam sering kali menjadi akar penyebab keterlambatan dalam mengenali tanda bahaya, yang merupakan kontributor utama dalam kasus kegawatdaruratan obstetri (Cunningham et al., 2022).

Dalam era *Evidence-Based Practice* (EBP), pengkajian maternitas kini bertransformasi menjadi pendekatan yang lebih personal dan holistik. Integrasi instrumen skrining tervalidasi, seperti *Edinburgh Postnatal Depression Scale* (EPDS) untuk kesehatan mental dan penilaian risiko berbasis budaya, memungkinkan praktisi untuk memberikan asuhan yang berpusat pada perempuan (*woman-centered care*). Hal ini sejalan dengan rekomendasi terbaru dari *World Health Organization* (WHO) yang menekankan pentingnya asuhan antenatal dan postnatal yang berkualitas untuk memberikan pengalaman kehamilan dan persalinan yang positif (WHO, 2016; King et al., 2019). Dengan demikian, penguasaan teknik pengkajian yang komprehensif bagi perawat bukan hanya tentang kompetensi teknis, melainkan perwujudan tanggung jawab etik dan profesional dalam melindungi kesejahteraan ibu dan janin secara berkelanjutan.

B. Anamnesis

Anamnesis bukan sekadar pengumpulan data, melainkan proses komunikasi terapeutik untuk mengidentifikasi faktor risiko, riwayat kesehatan, dan kesiapan psikososial. Dalam asuhan berkelanjutan (*Continuity of Care*) untuk keperawatan maternitas, lingkup anamnesis meliputi:

1. Anamnesis Pra-Konsepsi

Fokus pada optimalisasi kesehatan sebelum terjadi kehamilan untuk mencegah kecacatan janin dan komplikasi maternal.

- a. Riwayat Genetik & Reproduksi: Adanya penyakit hereditas, riwayat infertilitas, atau keguguran berulang.
- b. Status Nutrisi & Suplementasi: Skrining defisiensi asam folat (pencegahan *Neural Tube Defects*), status anemia, dan indeks massa tubuh (IMT).
- c. Skrining Gaya Hidup: Paparan polutan lingkungan, konsumsi obat-obatan (teratogenik), merokok, atau alkohol.
- d. Kesiapan Psikososial: Kesiapan finansial, dukungan pasangan, dan kesehatan mental.

2. Anamnesis Kehamilan (Antenatal Care - ANC)

Menggunakan pendekatan *re-focused* ANC yang lebih mendalam pada setiap trimester.

- a. Identitas & Keluhan Utama: Menanyakan ketidaknyamanan sesuai usia gestasi (misal: emesis di trimester I, edema di trimester III).
- b. Riwayat Menstruasi: HPHT yang akurat untuk menentukan perkiraan tanggal persalinan menggunakan rumus Naegele atau Parikh yang telah disesuaikan.
- c. Riwayat Kehamilan/Persalinan Lalu (*Gravida, Para, Abortus/G-P-A*): Detail mengenai komplikasi sebelumnya seperti Preeklampsia, Perdarahan Postpartum, atau berat badan lahir rendah (BBLR).
- d. Tanda Bahaya Kehamilan: Skrining sistematis terhadap gangguan penglihatan, nyeri epigastrium, dan penurunan gerakan janin (setelah 20 minggu).

3. Anamnesis Persalinan (Intranatal)

Bersifat cepat, fokus, dan bertujuan untuk menentukan manajemen persalinan.

- a. Evaluasi Kontraksi: frekuensi, durasi, dan intensitas (mengidentifikasi fase laten vs aktif).
- b. Status Ketuban: Waktu pecah ketuban, warna, dan bau (skrining risiko infeksi/korioamnionitis).
- c. Pengeluaran Pervaginam: Membedakan antara *bloody show* normal dengan perdarahan patologis (solusio plasenta/plasenta previa).

- d. Riwayat Alergi & Diet Terakhir: Sangat penting jika diperlukan tindakan anestesi atau intervensi bedah darurat.

4. Anamnesis Masa Nifas (Postnatal Care - PNC)

Fokus pada involusi uterus, laktasi, dan pemulihan emosional.

- Evaluasi Involusi & Lochia: Karakteristik lochia (rubra, serosa, alba) dan pola pengeluarannya.
- Keberhasilan Laktasi: Teknik menyusui, nyeri puting, dan tanda kecukupan ASI pada bayi.
- Skrining Kesehatan Mental Postpartum: Menggunakan instrumen seperti EPDS untuk mendeteksi *baby blues* atau depresi postpartum secara dini.
- Rencana Kontrasepsi Pasca Persalinan: Diskusi mengenai metode KB yang tidak mengganggu produksi ASI.

Berdasarkan ke-4 fase di atas, hal penting yang menjadi fokus utama dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.2 Fokus Utama dalam Anamnesa Berdasarkan Fase Kehidupan

Fase	Fokus Utama	Rasional Klinis (Update)
Pra-Konsepsi	Skrining Penyakit Kronis	Mencegah eksaserbasi penyakit saat hamil (misal: Diabetes Mellitus, Hipertensi).
Kehamilan	Gerak Janin (<i>Fetal Kick Counts</i>)	Indikator kesejahteraan janin secara mandiri oleh ibu.
Persalinan	Pola Nyeri & Kelelahan	Menentukan kebutuhan manajemen nyeri non-farmakologis/farmakologis.
Nifas	Fungsi Eliminasi (Miksi/Defekasi)	Deteksi dini trauma kandung kemih atau gangguan dasar panggul.

5. Pengkajian Budaya dalam Maternitas (Cultural Assessment)

Dalam konteks Indonesia, kepercayaan dan praktik budaya sering kali menjadi penentu utama perilaku kesehatan ibu. Perawat perlu dilatih untuk melakukan anamnesa tanpa menghakimi (*non-judgmental*). Lingkup pengkajian budaya meliputi:

- Pola Kebiasaan dan Tabu Makanan: Menanyakan apakah ada pantangan makanan tertentu selama hamil atau nifas (misalnya larangan makan ikan atau buah tertentu) yang dapat berdampak pada status gizi.

- b. Praktik Persalinan Tradisional: Menanyakan rencana tempat bersalin dan pendamping. Apakah keluarga berencana melibatkan dukun bayi atau menggunakan ramuan/jamu tertentu (misal: rumput fatimah yang berisiko menyebabkan kontraksi abnormal).
- c. Dukungan Keluarga dan Pengambil Keputusan: Mengidentifikasi siapa pemegang keputusan utama dalam keluarga (Suami, Ibu Kandung, atau Mertua). Hal ini krusial dalam situasi gawat darurat maternitas.
- d. Upacara Adat: Menanyakan rencana upacara adat yang melibatkan fisik ibu atau bayi (misal: pijat perut/urut yang berisiko pada kehamilan).

6. Skrining Kesehatan Mental: *Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)*

EPDS adalah instrumen tervalidasi secara internasional untuk mendeteksi risiko depresi pada masa perinatal (hamil dan nifas). Anamnesa ini sebaiknya dilakukan dalam suasana privasi yang terjaga.

Prosedur Anamnesa EPDS:

Ibu diminta untuk menjawab berdasarkan apa yang ia rasakan dalam 7 hari terakhir.

Tabel 2.3 *Skrining Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)*

No	Pernyataan (Selama 7 hari terakhir)	Pilihan Jawaban	Skor
1	Saya mampu tertawa dan melihat sisi lucu dari segala hal	Sama seperti biasanya	0
		Tidak terlalu sering	1
		Jelas tidak terlalu sering	2
		Tidak bisa sama sekali	3
2	Saya menatap masa depan dengan perasaan senang/antusias	Sama seperti biasanya	0
		Agak kurang dari biasanya	1
		Jelas kurang dari biasanya	2
		Hampir tidak sama sekali	3
3	Saya menyalahkan diri sendiri secara tidak perlu saat segala sesuatu berjalan salah	Ya, sering kali	3
		Ya, kadang-kadang	2
		Tidak terlalu sering	1
		Tidak, tidak pernah	0
4	Saya merasa cemas atau khawatir tanpa alasan yang jelas	Tidak, tidak sama sekali	0
		Hampir tidak pernah	1
		Ya, kadang-kadang	2
		Ya, sangat sering	3
5	Saya merasa takut atau panik tanpa alasan yang sangat jelas	Ya, cukup sering	3
		Ya, kadang-kadang	2
		Tidak, tidak sering	1

No	Pernyataan (Selama 7 hari terakhir)	Pilihan Jawaban	Skor
		Tidak, tidak sama sekali	0
6	Saya merasa segala sesuatu menumpuk dan sulit diatasi	Ya, sering kali saya tidak bisa mengatasinya	3
		Ya, kadang saya tidak bisa mengatasinya	2
		Tidak, hampir selalu bisa mengatasi	1
		Tidak, saya selalu bisa mengatasi	0
7	Saya merasa tidak bahagia sehingga sulit untuk tidur	Ya, sering kali	3
		Ya, kadang-kadang	2
		Tidak terlalu sering	1
		Tidak, tidak sama sekali	0
8	Saya merasa sedih atau sangat menderita	Ya, setiap saat	3
		Ya, cukup sering	2
		Tidak terlalu sering	1
		Tidak, tidak pernah	0
9	Saya merasa sangat tidak bahagia sehingga menangis	Ya, hampir setiap saat	3
		Ya, cukup sering	2
		Hanya sesekali	1
		Tidak, tidak pernah	0
10	Pikiran untuk menyakiti diri sendiri pernah muncul	Ya, cukup sering	3
		Kadang-kadang	2
		Hampir tidak pernah	1
		Tidak pernah	0

Interpretasi Klinis:

Skor 0-9 : Menunjukkan kemungkinan kecil adanya depresi.

Skor 10-12 : Kemungkinan menderita depresi (perlu pemantauan ulang).

Skor ≥ 13 : Kemungkinan besar menderita depresi postpartum (perlu rujukan segera ke profesional kesehatan mental).

Catatan Kritis:

Jika pada pertanyaan nomor 10 skornya bukan 0, maka diperlukan intervensi segera meskipun total skor rendah.

Tabel 2.4 Referensi: Tambahan Aspek Biopsikososial

Fase	Fokus Tambahan	Rasional Klinis / Evidence-Based
Hamil & Nifas	Pengkajian Budaya	Menyelaraskan asuhan medis dengan kearifan lokal agar ibu patuh terhadap terapi (Kesesuaian Budaya).
Postpartum	Skrining EPDS	Deteksi dini depresi dapat mencegah kegagalan <i>bonding</i> ibu-bayi dan risiko psikosis postpartum.
Pra-Konsepsi	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Skrining sensitif karena KDRT sering kali meningkat saat terjadi kehamilan.

C. Pemeriksaan Fisik Maternitas Komprehensif

Pemeriksaan fisik pada klien maternitas bertujuan untuk menilai adaptasi fisiologis terhadap kehamilan, mendeteksi penyimpangan secara dini, dan memantau kesejahteraan janin serta ibu (Lowdermilk et al., 2023).

1. Pemeriksaan Fisik Pra-Konsepsi

Fokus pada status kesehatan sistemik yang dapat mempengaruhi kehamilan.

- Tanda-Tanda Vital & Antropometri: Pengukuran tekanan darah untuk dasar (baseline) dan IMT (Indeks Massa Tubuh). IMT yang ekstrem (terlalu rendah atau obesitas) berkaitan dengan risiko infertilitas dan komplikasi kehamilan (ACOG, 2020).
- Pemeriksaan Kelenjar Tiroid: Palpasi kelenjar tiroid untuk mendeteksi hipo/hipertiroidisme yang dapat menyebabkan gangguan perkembangan otak janin.
- Pemeriksaan Sistem Reproduksi: Pemeriksaan spekulum dan bimanual untuk mendeteksi anomali uterus atau massa adneksa (King et al., 2019).

2. Pemeriksaan Fisik Kehamilan (Antenatal)

- Pemeriksaan Payudara: Menilai kesiapan laktasi, kebersihan puting, dan adanya massa. Penonjolan puting (puting datar/masuk) perlu diidentifikasi sejak dini (WHO, 2016).
- Pemeriksaan Abdomen (Maneuver Leopold):

- 1) Leopold I: Menentukan TFU dan bagian janin di fundus.
 - 2) Leopold II: Menentukan letak punggung janin.
 - 3) Leopold III: Menentukan bagian terbawah janin.
 - 4) Leopold IV: Menentukan sejauh mana bagian terbawah masuk PAP (hanya pada trimester III).
- c. Auskultasi Denyut Jantung Janin (DJJ): Menggunakan Doppler atau Leanec. Batas normal 120-160 kali/menit (Cunningham et al., 2022).
 - d. Batas normal 120-160 kali/menit (Cunningham et al., 2022).
 - e. Ekstremitas: Pemeriksaan edema dependen dan refleksi patella (refleks yang menurun dapat mengindikasikan masalah neurologis atau efek samping terapi magnesium sulfat pada preeklamsia).

3. Pemeriksaan Fisik Persalinan (Intranatal)

Fokus pada kemajuan persalinan dan respon janin terhadap kontraksi.

- a. Pemeriksaan Dalam (*Vaginal Examination*): Menilai pembukaan serviks, penipisan (*effacement*), presentasi, dan penurunan kepala (Station) berdasarkan bidang Hodge (Cunningham et al., 2022).
- b. Pemantauan Kontraksi: Menilai frekuensi, durasi, dan intensitas kontraksi per 10 menit.
- c. Penilaian Cairan Ketuban: Mengidentifikasi warna (jernih, mekonium, atau darah) dan bau setelah ketuban pecah.

4. Pemeriksaan Fisik Masa Nifas (Postnatal)

Menggunakan sistematika "BUBBLE-HE" yang merupakan standar emas dalam asuhan nifas (Lowdermilk et al., 2023):

Tabel 2.5 Sistematika "BUBBLE-HE"

SINGKATAN		DESKRIPSI
B	Breasts	Konsistensi (lunak, mengisi, atau bendungan), integritas puting.
U	Uterus	Lokasi fundus (harus di tengah) dan konsistensi (harus keras/berkontraksi).
B	Bladder	Kemampuan berkemih spontan (mencegah atonia uteri akibat kandung kemih penuh)
B	Bowel	Bising usus dan pola defekasi.
L	Lochia	Karakteristik warna (Rubra, Sanguinolenta, Serosa, Alba) dan jumlah.
E	Episiotomy/ Laceration	Menilai tanda-tanda REEDA (Redness, Edema, Ecchymosis, Discharge,
H	Homan's	Sign/Extremities): Deteksi dini Trombosis Vena Dalam (DVT).

E	Emotional	Status): Menilai adaptasi psikologis dan bonding ibu-bayi.
----------	-----------	--

D. Interpretasi Tanda-Tanda Vital (TTV)

Interpretasi TTV pada maternitas harus mempertimbangkan perubahan fisiologis normal (misal: peningkatan volume darah yang dapat menurunkan tekanan darah di trimester II).

Tabel 2.6 Interpretasi Tanda-tanda Vital

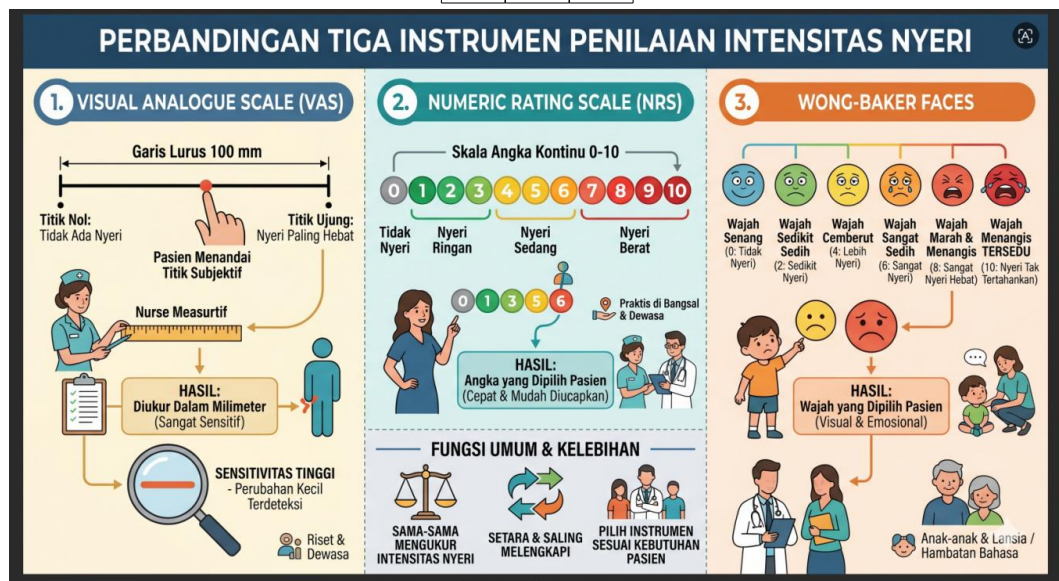
Parameter	Rentang Normal	Interpretasi Klinis (Update)
Tekanan Darah	110/70-120/80 mmHg	Peningkatan Sitolik ≥ 140 mmHg atau Diastolik ≥ 90 mmHg adalah indikasi Preeklamsia (ACOG, 2020).
Nadi	60 - 100 permenit	Cenderung naik 10-15 bpm selama hamil. Takikardia pada nifas bisa menandakan perdarahan atau infeksi.
Pernapasan	16 - 24 x/menit	Takipnea dapat mengindikasikan edema paru (komplikasi preeklamsia) atau emboli (Cunningham et al., 2022).
Suhu	36.5-37.5 ⁰ C	Suhu $\geq 38^0$ C pada nifas setelah 24 jam pertama menandakan infeksi/sepsis nifas.

E. Penilaian Nyeri Maternitas

Nyeri maternitas memiliki karakteristik unik karena melibatkan proses fisiologis (normal) sekaligus risiko patologis (komplikasi). Penilaian yang akurat sangat penting untuk menentukan intervensi yang tepat (Lowdermilk (2023). Instrumen yang tepat dibutuhkan untuk mengidentifikasi nyeri. Instrumen yang dapat digunakan sebagai berikut:

1. Instrumen Intensitas Nyeri (NRS & VAS)

Instrumen penilaian intensitas nyeri adalah alat ukur yang digunakan tenaga kesehatan untuk mengevaluasi tingkat keparahan nyeri pada ibu secara subjektif maupun objektif. Skala utama yang sering digunakan adalah Numeric Rating Scale (NRS), Visual Analog Scale (VAS), Wong-Baker Faces Pain Rating Scale. Untuk membedakan ketiganya dapat dilihat pada gambar 1. (**Davidson, London & Ladewig, ,2020**)



Gambar 2.1 Perbandingan Tiga Instrumen Penilaian Nyeri

Dalam kondisi perinatal (saat hamil hingga nifas), pemilihan instrumen ini sangat bergantung pada kondisi ibu. Mari kita diskusikan cara menginterpretasikan hasilnya agar intervensi yang diberikan akurat:

a. Akurasi vs Kecepatan (NRS di Ruang Nifas)

Meskipun VAS (Visual Analogue Scale) sangat akurat karena sifatnya yang kontinu (misal: 5,2 cm), dalam kondisi klinis seperti pemantauan *afterpain* (mules setelah melahirkan), NRS (Numeric Rating Scale) lebih populer karena:

- 1) Efisiensi Waktu: Bidan bisa bertanya secara lisan, "Ibu, dari angka 0 sampai 10, berapa rasa mulesnya?" tanpa harus membawa kertas dan penggaris.
- 2) Kondisi Fisik Ibu: Ibu nifas seringkali masih lelah, sedang menyusui, atau dalam posisi berbaring yang menyulitkan untuk menandai garis presisi pada kertas VAS.
- 3) Standarisasi Komunikasi: Angka yang diucapkan ibu (NRS) lebih mudah dicatat langsung di rekam medis dan dipahami oleh seluruh tim kesehatan.

b. Kesesuaian Kondisi (Kapan Menggunakan Wong-Baker FACES?)

Skala Wong-Baker FACES tidak hanya untuk anak-anak. Dalam periode perinatal, skala ini sangat membantu jika:

- 1) Hambatan Bahasa/Budaya: Ibu tidak fasih menggunakan angka atau bahasa setempat.
- 2) Kondisi Kognitif/Stres Tinggi: Saat ibu mengalami nyeri hebat atau kelelahan ekstrem yang membuat konsentrasi pada angka menjadi sulit.

- 3) Visualisasi Emosional: Terkadang, ibu merasa lebih mudah mencocokkan "ekspresi" penderitaannya dengan gambar daripada menentukan angka abstrak.

c. Interpretasi Skor "6"

Skor 6 pada skala NRS atau VAS biasanya dikategorikan sebagai Nyeri Sedang (menuju Berat). Mengapa skor ini sering dianggap sebagai ambang batas untuk intervensi medis segera?

- 1) Gangguan Aktivitas: Nyeri skor 6 biasanya sudah mulai mengganggu konsentrasi, kemampuan menyusui, dan mobilisasi ibu.
- 2) Indikator Komplikasi: Pada *afterpain*, jika nyeri tetap di angka 6 meskipun sudah dilakukan teknik relaksasi, bidan harus waspada terhadap kemungkinan adanya sisa plasenta atau infeksi rahim (*endometritis*).

2. Nyeri Persalinan (Labor Pain)

Nyeri ini bersifat fisiologis akibat dilatasi serviks, iskemia korpus uteri, dan peregangan vagina/perineum.

Tabel.2.7 Aspek Penilaian Nyeri Persalinan

Aspek Penilaian	Karakteristik Klinis
Lokasi Nyeri	Nyeri menjalar dari pinggang (sacrum) menuju perut bagian bawah.
Pola	Berirama (intermiten), semakin kuat dan sering mendekati pembukaan lengkap.
Evaluasi Teknik	Menilai penurunan skor nyeri setelah dilakukan <i>Counter-pressure</i> , <i>Effleurage</i> , atau pernapasan dalam.

Catatan Penting:

- a. Penting untuk memahami bahwa pada kala I, nyeri dominan di pinggang dan perut bawah, sedangkan pada kala II, nyeri berpindah ke area perineum dan rektum karena tekanan kepala janin.
- b. Jika nyeri tidak menjalar (hanya di satu titik atau menetap tanpa kontraksi), perlu diwaspadai adanya malposisi janin atau komplikasi lain.

3. Nyeri Nifas: Afterpains (Involusi Uterus)

Nyeri yang dirasakan setelah melahirkan akibat kontraksi rahim saat kembali ke ukuran semula (Lowdermilk, 2023).

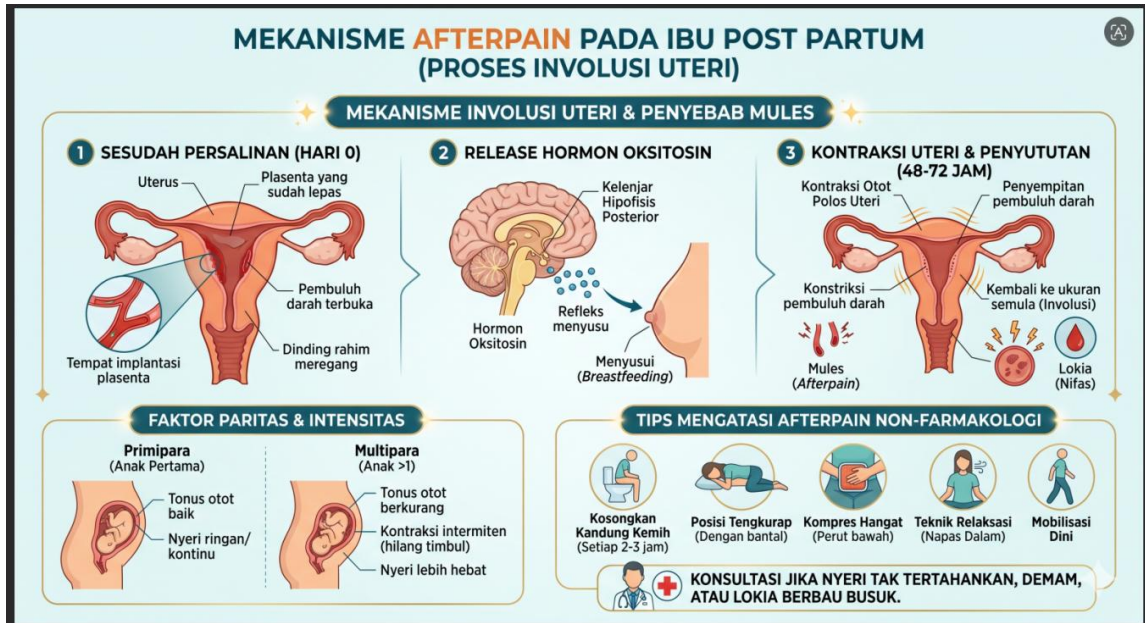
Mekanisme: Kontraksi uterus untuk mencegah perdarahan post-partum.

Faktor Prediksi: - **Multipara:** Uterus lebih sering berkontraksi/relaksasi karena otot yang kurang kencang dibandingkan primipara.

Menyusui: Isapan bayi memicu pelepasan **Oksitosin** dari pituitari posterior, memperkuat kontraksi uterus.

Durasi: Biasanya mereda dalam 3-7 hari post-partum.

Penting untuk mengedukasi ibu multipara bahwa nyeri saat menyusui adalah tanda positif bahwa rahim sedang menyusut dengan baik, meskipun terasa menyakitkan.



Gambar 2.2. Mekanisme involusi uteri

4. Nyeri Luka: Skala REEDA (Episiotomi & SC)

Digunakan untuk menilai penyembuhan luka dan mendeteksi komplikasi (Infeksi/Hematoma).

Tabel 2.8. Daftar Score REEDA

Kriteria	Skor 0	Skor 1	Skor 2	Skor 3
R (Redness/Kemerahan)	Tidak ada	Dalam 0.25 cm	Dalam 0.5 cm	> 0.5 cm
E (Edema/Bengkak)	Tidak ada	Perineal < 1 cm	Perineal 1-2 cm	Perineal > 2 cm
E (Ecchymosis/Memar)	Tidak ada	Luas 0.25 cm	Luas 0.5 - 1 cm	Luas > 1 cm
D (Discharge/Cairan)	Tidak ada	Serosa (Bening)	Serosanguinosa	Purulen (Nanah)
A (Approximation/ Penyatuan)	Tertutup rapat	Celah < 3 mm	Jarak kulit/lemak	Terbuka luas

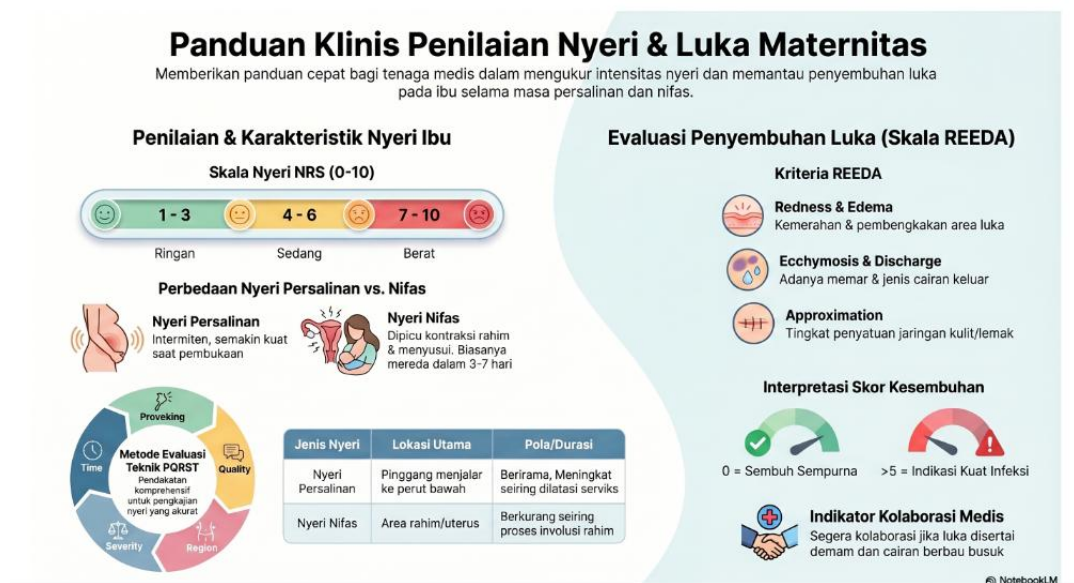
Interpretasi Skor REEDA:

Skor 0: Sembuh sempurna.

Skor >5: Indikasi kuat adanya infeksi atau kegagalan penyembuhan luka.

Catatan Penting:

- Jika skor REEDA tinggi (terutama pada *Discharge* dan *Approximation*), biasanya nyeri yang dirasakan ibu adalah nyeri patologis (infeksi).
- Selalu lakukan pengkajian nyeri secara **PQRST** (Provoking, Quality, Region, Severity, Time) untuk mendapatkan data yang komprehensif. Jika nyeri pada luka SC atau luka SC atau Episiotomi disertai demam dan cairan berbau, segera lakukan kolaborasi medis.



Gambar 2.3. Panduan Klinis Penilaian Nyeri dan Luka Maternitas

F. Pemeriksaan Penunjang (Laboratorium & Diagnostik)

Laboratorium harus dilakukan secara selektif dan sesuai tahapannya:

Fase	Jenis Pemeriksaan
Fase Pra-Konsepsi:	✓ Skrining TORCH: (Toxoplasma, Rubella, CMV, Herpes) untuk mencegah anomali kongenital. ✓ Analisis Hemoglobin: Deteksi Talasemia atau anemia defisiensi besi.
Fase Kehamilan (ANC):	Trimester I: Golongan darah/Rh (cegah inkompatibilitas), HBsAg, HIV, Sipilis (Triple Eliminasi). Trimester II/III: ✓ Protein urin (skrining preeklamsia) dan Glukosa Darah (skrining Diabetes Gestasional).

	✓ USG Obstetri: Konfirmasi usia gestasi, kesejahteraan janin, dan lokasi plasenta.
Fase Persalinan & Nifas:	Pemeriksaan Hb Postpartum: Dilakukan jika terjadi perdarahan berlebih (HPP) untuk menentukan kebutuhan transfusi.

G. Skrining Risiko Maternitas

Skrining risiko maternitas merupakan langkah proaktif untuk mengidentifikasi kemungkinan komplikasi pada ibu hamil sedini mungkin. Tujuannya adalah memastikan bahwa ibu mendapatkan tingkat perawatan yang sesuai dengan kondisi kesehatannya guna menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu serta bayi (Kemenkes, 2021).

Identifikasi dini faktor risiko merupakan determinan utama dalam mencegah komplikasi berat yang berkontribusi pada angka kematian ibu (AKI):

1. Identifikasi Risiko Berbasis Skor

Penggunaan instrumen skrining seperti Kartu Skor Poedji Rochjati (KSPR) membantu tenaga kesehatan dalam melakukan triangulasi data antara faktor usia, paritas, dan riwayat obstetri (Rochjati, 2011). Skor ini menentukan apakah pasien masuk dalam kategori Kehamilan Risiko Rendah (KRR), Tinggi (KRT), atau Sangat Tinggi (KRST) [3].

Di Indonesia, instrumen seperti **Kartu Skor Poedji Rochjati (KSPR)** sering digunakan untuk mengklasifikasikan risiko (Rochjati, 2011): Skor ini menentukan apakah pasien masuk dalam kategori Kehamilan Risiko Rendah (KRR), Tinggi (KRT), atau Sangat Tinggi (KRST):

- Kehamilan Risiko Rendah (KRR): Skor 2 (Hijau). Perawatan bisa dilakukan oleh bidan secara mandiri.
- Kehamilan Risiko Tinggi (KRT): Skor 6-10 (Kuning). Memerlukan pengawasan lebih ketat oleh bidan dan dokter.
- Kehamilan Risiko Sangat Tinggi (KRST): Skor ≥ 12 (Merah). Harus dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas spesialis lengkap.

Catatan Penting: Deteksi dini melalui alat skrining sederhana di tingkat Puskesmas sangat krusial, terutama untuk kondisi yang sering kali asimtomatik pada awalnya, seperti gangguan fungsi jantung prenatal atau hipertensi gestasional.

2. Red Flags (Tanda bahaya) Maternitas

Tenaga kesehatan harus mampu mengenali tanda-tanda bahaya yang memerlukan rujukan segera (immediate referral). Berdasarkan pedoman klinis, *red flags* mencakup (WHO, 2016; Lowdermilk, 2020 dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 2.9 RED FLAGS (Tanda Bahaya Maternitas)

Red Flag	Temuan Klinis	Potensi Diagnosis/Risiko	Tindakan Segera
Pra-Konsepsi	Tekanan Darah $\geq$ 140/90 mmHg	Hipertensi Esensial	Skrining fungsi ginjal & konsul kardiologi sebelum hamil.
	LILA $\leq$ 23.5 cm atau IMT $\leq$ 18 cm	Malnutrisi/KEK	Perbaiki nutrisi intensif sebelum konsepsi.
	Massa pada payudara/adneksa	Neoplasma/Kista	Rujukan biopsi atau USG onkologi.
Kehamilan (Antenatal)	Perdarahan pervaginam (Trimester I)	Abortus, KET, atau Mola	Cek tanda syok dan USG emergensi.
	Nyeri kepala hebat & pandangan kabur	Preeklamsia Berat (PEB)	Cek protein urin dan refleks patella.
	Gerakan janin berkurang/berhenti	Fetal Distress / IUFD	Auskultasi DJJ dan rujukan USG segera.
	Keluar cairan ketuban sebelum waktunya	KPD (Ketuban Pecah Dini)	Tes lakmus/nitrazin; risiko infeksi asenden.
Persalinan (Intranatal)	Cairan ketuban hijau kental/mekonium	Gawat Janin (Hipoksia)	Risiko sindrom aspirasi mekonium.
	Partus tak maju (Partograf melewati garis bertindak)	Distosia Persalinan	Evaluasi 3P (Power, Passenger, Passage).
	DJJ $\leq$ 110 atau $\geq$ 160 x/menit	Bradikardia/Takikardia Janin	Indikasi terminasi persalinan segera.
	Darah segar mengalir (bukan <i>bloody show</i>)	Solusio Plasenta	Risiko syok hipovolemik pada ibu dan bayi.
Masa Nifas (Postpartum)	Perdarahan masif (Ganti pembalut $\leq$ 1 jam)	HPP (Atonia Uteri/Sisa Plasenta)	Cek kontraksi uterus dan tinggi fundus.
	Demam $\geq$ 38°C dan lochia berbau busuk	Sepsis Nifas / Endometritis	Evaluasi tanda-tanda infeksi sistemik.
	Nyeri, bengkak, dan kemerahan di betis	DVT (Thrombosis Vena Dalam)	Cek Homan's Sign; risiko emboli paru.
	Pikiran menyakiti diri sendiri atau bayi	Psikosis Postpartum	Rujukan psikiatri segera (Skor EPDS $\geq$ 13).

H. Penutup

Pengkajian maternitas komprehensif merupakan proses dinamis yang mengintegrasikan seni komunikasi terapeutik dalam anamnesa dengan ketajaman klinis dalam pemeriksaan fisik serta interpretasi data penunjang. Dengan mencakup spektrum berkelanjutan dari pra-konsepsi hingga masa nifas, tenaga kesehatan dapat membangun basis data yang kuat untuk mengidentifikasi adaptasi fisiologis normal sekaligus mendeteksi penyimpangan secara dini. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada dimensi biologis, tetapi juga secara kritis mempertimbangkan aspek psikososial melalui skrining kesehatan mental (EPDS) dan sensitivitas budaya, yang secara kolektif menentukan keberhasilan asuhan yang berpusat pada perempuan (woman-centered care).

Identifikasi dini terhadap tanda-tanda bahaya (*red flags*) di setiap fase maternitas menjadi pilar utama dalam menurunkan angka morbiditas dan mortalitas maternal maupun neonatal. Pemahaman yang mendalam mengenai parameter normal dan abnormal, didukung oleh referensi berbasis bukti (evidence-based practice), membekali mahasiswa dan praktisi untuk mengambil keputusan klinis yang tepat dan etis. Keseluruhan proses pengkajian ini pada akhirnya bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen penyelamatan nyawa yang menjamin transisi aman bagi ibu dan bayi dalam siklus reproduksi.

Referensi

- ACOG. (2020). Gestational Hypertension and Preeclampsia: ACOG Practice Bulletin, Number 222. *Obstetrics & Gynecology*, 135(6).
- American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). (2020). Preconception Care. Clinical Management Guidelines for Obstetrician-Gynecologists. *Obstetrics & Gynecology*.
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Spong, C. Y. (2022). *Williams Obstetrics* (26th ed.). McGraw-Hill Education
- Davidson, M. R., London, M. L., & Ladewig, P. W. (2020). *Olds' Maternal-Newborn Nursing & Women's Health Across the Lifespan*. Pearson. (Fokus pada instrumen NRS dan penilaian kontraksi).
- James, D. K., & Steer, P. J. (2017). *High Risk Pregnancy: Management Options*. Cambridge University Press.
- Kemenkes RI. (2020). *Pedoman Pelayanan Antenatal, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir*. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
- Kemenkes RI. (2020). *Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Lowdermilk, D. L., et al. (2023). *Maternity & Women's Health Care* (13th ed.). Elsevier.
- Stewart, D. E., & Vigod, S. N. (2019). Postpartum Depression: Pathophysiology, Treatment, and Outcomes. *Annual Review of Medicine*, 70, 183-196.
- WHO. (2016). *WHO Recommendations on Antenatal Care for a Positive Pregnancy Experience*. World Health Organization.

BAB III

ASUHAN KEPERAWATAN PRAKONSEPSI DAN ANTENATAL

A. Pendahuluan

1. Pendahuluan

Promosi kesehatan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan individu dan masyarakat dalam mengendalikan determinan kesehatan. Oleh sebab itu promosi kesehatan menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan kesehatan global. Promosi kesehatan memiliki peran strategis dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) melalui pendekatan promotif dan preventif yang terintegrasi dalam sistem pelayanan kesehatan (Bhutta et al., 2013; WHO, 2016).

Di berbagai negara, terutama negara berkembang, masalah kesehatan maternal hingga saat ini masih menjadi isu prioritas global. Fakta bahwa sebagian besar komplikasi kehamilan sebenarnya dapat dicegah melalui intervensi dini yang efektif menjadi alasan pentingnya promosi kesehatan untuk dilakukan terutama pada periode sebelum terjadinya kehamilan. Dalam kerangka *life-course approach*, kesehatan ibu dan anak dipengaruhi oleh kondisi yang terjadi sejak masa prakonsepsi hingga masa dewasa. Intervensi pada periode prakonsepsi atau periode sebelum terjadi kehamilan terbukti memiliki dampak jangka panjang terhadap luaran kehamilan dan perkembangan anak, termasuk pencegahan stunting dan penyakit tidak menular di masa depan (Dean et al., 2014b; United Nations Children's Fund (UNICEF), 2019). Pendekatan promosi kesehatan memungkinkan identifikasi faktor risiko sejak sebelum kehamilan, sehingga dapat menekan kejadian komplikasi seperti anemia, preeklamsia, dan kelahiran prematur (Lassi et al., 2014; World Health Organization, 2025b). Oleh karena itu, promosi kesehatan pada fase prakonsepsi tidak dapat dipisahkan dari pelayanan antenatal.

Bab ini akan membahas secara mendalam konsep, teori, strategi, serta implementasi promosi kesehatan dalam keperawatan maternitas sebagai landasan praktik profesional.

2. Landasan Filosofis dan Paradigma Promosi Kesehatan

Transformasi paradigma kesehatan dari pendekatan kuratif menuju promotif-preventif menempatkan individu sebagai subjek aktif dalam menjaga kesehatannya, bukan sekadar objek pelayanan kesehatan (Notoatmojo, 2018; Nutbeam, 2025). Kesehatan maternal sangat dipengaruhi oleh faktor sosial seperti pendidikan, ekonomi, dan akses layanan kesehatan, sebagaimana dijelaskan dalam teori determinan sosial kesehatan oleh Michael Marmot (Marmot, 2015). Pendekatan *life-course* menekankan bahwa kondisi kesehatan pada masa dewasa dipengaruhi oleh faktor sejak sebelum konsepsi, sehingga intervensi prakonsepsi menjadi sangat penting dalam meningkatkan outcome kehamilan (Dean et al., 2014b).

3. Definisi dan Konsep Promosi Kesehatan

Promosi kesehatan didefinisikan sebagai proses enabling individu untuk meningkatkan kontrol terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan (WHO, 1987). Konsep ini mencakup edukasi, pemberdayaan, advokasi, dan kebijakan publik sebagai strategi utama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (Glanz, K., Rimer, B. K., & Viswanath, 2015).

4. Teori dan Model Promosi Kesehatan

a. Health Promotion Model (HPM)

Model ini dikembangkan oleh Nola J. Pender yang menjelaskan bahwa perilaku kesehatan dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap manfaat, hambatan, dan self-efficacy. Model ini banyak digunakan dalam intervensi keperawatan untuk meningkatkan kepatuhan ANC dan perilaku hidup sehat pada ibu hamil (Pender, Nola J.; Murdaugh, Carolyn L.; Parsons, 2015).

b. Health Belief Model (HBM)

Teori ini diperkenalkan oleh Irwin M. Rosenstock yang menyatakan bahwa perilaku kesehatan dipengaruhi oleh persepsi risiko dan manfaat tindakan kesehatan. Model ini efektif digunakan dalam edukasi imunisasi dan pencegahan anemia pada ibu hamil (Glanz, K., Rimer, B. K., & Viswanath, 2015).

c. Theory of Planned Behavior (TPB)

Dikembangkan oleh Icek Ajzen, teori ini menjelaskan bahwa perilaku ditentukan oleh niat yang dipengaruhi oleh sikap, norma sosial, dan kontrol perilaku. Dalam konteks maternal, teori ini digunakan untuk memahami keputusan penggunaan kontrasepsi dan perencanaan kehamilan (Montaño & Kasprzyk, 2015).

d. Social Cognitive Theory

Teori dari Albert Bandura menekankan pentingnya self-efficacy dan pembelajaran observasional dalam perubahan perilaku kesehatan (Bandura,

1986). Pendekatan ini relevan dalam edukasi kesehatan berbasis komunitas dan keluarga (Glanz, K., Rimer, B. K., & Viswanath, 2015).

e. Model PRECEDE-PROCEED

Model ini digunakan dalam perencanaan dan evaluasi program promosi kesehatan secara sistematis. Model ini membantu dalam identifikasi faktor predisposisi, enabling, dan reinforcing dalam perubahan perilaku kesehatan maternal (Tang et al., 2025).

5. Strategi Global Promosi Kesehatan

a. Ottawa Charter

Ottawa Charter dari World Health Organization menekankan lima strategi utama promosi kesehatan, yaitu Building Healthy Public Policy (Membangun Kebijakan Publik yang Berwawasan Kesehatan), Creating Supportive Environments (Menciptakan Lingkungan yang Mendukung), Strengthening Community Action (Memperkuat Aksi Komunitas), Developing Personal Skills (Mengembangkan Keterampilan Individu), dan Reorienting Health Services (Reorientasi Pelayanan Kesehatan) (WHO, 1987). Strategi ini menjadi dasar dalam pengembangan program kesehatan maternal di berbagai negara (Nutbeam, 2025).

b. Sustainable Development Goals (SDGs)

Promosi kesehatan maternal berkontribusi pada pencapaian SDG 3 yaitu peningkatan kesehatan dan kesejahteraan, termasuk penurunan AKI. Hal tersebut dapat dicapai melalui (United Nations Children's Fund (UNICEF), 2019):

- 1) Peningkatan akses prakonsepsi
- 2) Pelayanan antenatal berkualitas
- 3) Pencegahan anemia dan malnutrisi
- 4) Imunisasi maternal
- 5) Persalinan aman
- 6) Perencanaan keluarga

6. Promosi Kesehatan pada Masa Prakonsepsi

Promosi kesehatan pada masa prakonsepsi merupakan intervensi strategis yang bertujuan meningkatkan kesehatan perempuan sebelum terjadinya kehamilan guna menghasilkan outcome kehamilan yang optimal. Intervensi pada fase ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko komplikasi maternal dan neonatal, termasuk bayi berat lahir rendah dan prematuritas (Dean et al., 2014b; Lassi et al., 2014). Komponen utama dalam promosi kesehatan prakonsepsi yaitu: Skrining kesehatan, Edukasi gaya hidup sehat, Konseling reproduksi (Kemenkes RI, 2021; Kementerian Kesehatan RI, 2020; Lassi et al., 2014).

Pendekatan promosi kesehatan prakonsepsi berfokus pada identifikasi dan modifikasi faktor risiko yang dapat memengaruhi kehamilan, seperti status gizi, penyakit kronis, serta perilaku kesehatan. Skrining kesehatan sebelum kehamilan menjadi komponen penting dalam mendeteksi kondisi seperti anemia, diabetes, dan hipertensi yang dapat meningkatkan risiko komplikasi (Du et al., 2021). Selain itu, edukasi gaya hidup sehat menjadi bagian integral dari promosi kesehatan prakonsepsi, termasuk peningkatan asupan nutrisi, aktivitas fisik, serta penghindaran perilaku berisiko seperti merokok dan konsumsi alkohol. Intervensi ini terbukti berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan reproduksi dan kesiapan kehamilan (Dean et al., 2014b; Glanz, K., Rimer, B. K., & Viswanath, 2015). Konseling reproduksi juga memiliki peran penting dalam membantu pasangan usia subur dalam merencanakan kehamilan yang sehat, termasuk menentukan usia ideal kehamilan dan jarak antar kehamilan. Pendekatan ini didukung oleh kebijakan nasional yang dikembangkan oleh BKKBN dalam program kesehatan reproduksi (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Pendekatan berbasis komunitas seperti posyandu dan program pasangan usia subur (PUS) memungkinkan jangkauan intervensi yang lebih luas, terutama di wilayah dengan akses layanan kesehatan terbatas. Strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan literasi kesehatan dan perilaku sehat pada masyarakat (Mulati, 2020). Pendekatan berbasis komunitas seperti posyandu dan program pasangan usia subur meningkatkan jangkauan intervensi (Kemenkes RI, 2023).

7. Promosi Kesehatan pada Masa Antenatal

Promosi kesehatan pada masa antenatal merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan kesehatan ibu dan janin selama kehamilan melalui edukasi, deteksi dini, dan intervensi preventif. Pelayanan antenatal yang berkualitas berkontribusi signifikan terhadap penurunan angka kematian ibu dan bayi (WHO, 2016). Fokus utama promosi kesehatan antenatal meliputi peningkatan kepatuhan terhadap kunjungan antenatal care (ANC), pemenuhan kebutuhan nutrisi, serta deteksi dini komplikasi kehamilan. Kepatuhan ANC terbukti berkorelasi dengan peningkatan outcome kehamilan dan penurunan risiko komplikasi (Andriani et al., 2022). Edukasi mengenai tanda bahaya kehamilan menjadi komponen penting dalam promosi kesehatan antenatal, karena memungkinkan ibu untuk segera mencari pertolongan medis ketika terjadi komplikasi. Pengetahuan ini berperan dalam menurunkan keterlambatan penanganan (*delay model*) (Opus et al., 2025).

Program seperti kelas ibu hamil dan *birth preparedness and complication readiness* (BPCR) telah terbukti meningkatkan kesiapan ibu dalam menghadapi persalinan serta mengurangi risiko komplikasi (World Health Organization, 2015). Pendekatan *continuum of care* yang mengintegrasikan pelayanan dari

prakonsepsi hingga postnatal menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan maternal secara menyeluruh (Opus et al., 2025).

8. Metode dan Media Promosi Kesehatan

Metode promosi kesehatan merupakan cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan kesehatan kepada sasaran secara efektif, yang dapat dilakukan melalui pendekatan individual, kelompok, maupun massa (Notoatmodjo, 2018). Metode individual seperti konseling tatap muka memungkinkan pendekatan yang lebih personal dan spesifik sesuai dengan kebutuhan individu, sehingga efektif dalam mengubah perilaku kesehatan (Glanz, K., Rimer, B. K., & Viswanath, 2015)

Metode kelompok seperti kelas ibu hamil memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan meningkatkan dukungan sosial, yang terbukti meningkatkan efektivitas edukasi kesehatan. Sementara itu, metode massa seperti kampanye kesehatan melalui media sosial memiliki jangkauan yang luas dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat secara cepat. Media promosi kesehatan meliputi media cetak, audiovisual, dan digital. Pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi kesehatan dan telehealth semakin berkembang dan terbukti meningkatkan akses serta efektivitas edukasi kesehatan maternal (World Health Organization, 2021).

9. Peran Strategis Perawat

Perawat memiliki peran strategis dalam promosi kesehatan maternal sebagai tenaga kesehatan yang paling dekat dengan pasien dan komunitas. Peran ini mencakup fungsi sebagai educator, counselor, advocate, dan care coordinator (Schober, 2020). Sebagai educator, perawat bertanggung jawab dalam memberikan informasi kesehatan yang akurat dan berbasis evidence kepada ibu dan keluarga. Edukasi yang efektif dapat meningkatkan pengetahuan dan perubahan perilaku kesehatan (Glanz, K., Rimer, B. K., & Viswanath, 2015). Sebagai counselor, perawat membantu pasien dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksi dan kehamilan, dengan mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial (WHO, 2016). Sebagai advocate, perawat berperan dalam melindungi hak pasien dan memastikan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama bagi kelompok rentan (Schober, 2020).

10. Evaluasi Promosi Kesehatan

Evaluasi promosi kesehatan merupakan proses sistematis untuk menilai efektivitas program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi proses dilakukan untuk menilai pelaksanaan program, termasuk kesesuaian dengan rencana dan penggunaan sumber daya (McKenzie et al., 2022). Evaluasi outcome berfokus pada perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku sasaran

setelah intervensi (Glanz, K., Rimer, B. K., & Viswanath, 2015). Evaluasi impact menilai dampak jangka panjang program, seperti penurunan angka kematian ibu dan bayi serta peningkatan status kesehatan masyarakat (World Health Organization, 2024b).

11. Tantangan dan Isu Kontemporer

Pelaksanaan promosi kesehatan maternal menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya literasi kesehatan dan ketimpangan akses layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil (World Health Organization, 2024b). Faktor budaya dan kepercayaan masyarakat juga dapat memengaruhi perilaku kesehatan, sehingga diperlukan pendekatan yang sensitif terhadap budaya (*cultural competence*). Perkembangan teknologi digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan dalam promosi kesehatan, termasuk masalah validitas informasi dan kesenjangan digital (World Health Organization, 2021).

12. Evidence-Based Practice

Evidence-based practice (EBP) merupakan pendekatan dalam praktik keperawatan yang mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik dengan keahlian klinis dan preferensi pasien. Penggunaan EBP dalam promosi kesehatan terbukti meningkatkan efektivitas intervensi serta kualitas pelayanan kesehatan maternal (WHO, 2016). EBP juga memungkinkan perawat untuk memilih intervensi yang paling tepat berdasarkan hasil penelitian terkini, sehingga meningkatkan outcome pasien (Glanz, K., Rimer, B. K., & Viswanath, 2015).

13. Implikasi Praktik Keperawatan

Promosi kesehatan dalam keperawatan maternitas menuntut perawat untuk memiliki kompetensi dalam komunikasi, edukasi, dan pemberdayaan pasien. Perawat harus mampu mengintegrasikan pendekatan berbasis budaya dan keluarga dalam praktiknya. Kolaborasi interprofesional juga menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas promosi kesehatan, karena kesehatan maternal melibatkan berbagai disiplin ilmu (WHO, 2016). Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam praktik keperawatan menjadi kebutuhan penting dalam meningkatkan akses dan kualitas edukasi kesehatan (World Health Organization, 2021).

B. Gizi pada Masa Prakonsepsi dan Antenatal

1. Pendahuluan

Gizi merupakan determinan utama dalam kesehatan reproduksi yang berperan penting dalam menentukan kualitas kehamilan dan outcome janin. Status gizi ibu sebelum dan selama kehamilan berhubungan erat dengan risiko komplikasi seperti anemia, preeklamsia, bayi berat lahir rendah (BBLR), dan

stunting (Bhutta et al., 2013; WHO, 2016). Pendekatan *life-course* menegaskan bahwa intervensi gizi tidak hanya dilakukan selama kehamilan, tetapi harus dimulai sejak masa prakonsepsi untuk mencapai hasil yang optimal. Kekurangan gizi pada masa prakonsepsi dapat berdampak jangka panjang terhadap kesehatan ibu dan anak (Dean et al., 2014a; UNICEF et al., 2019).

Di negara berkembang, masalah gizi pada perempuan usia subur masih didominasi oleh anemia, kekurangan energi kronis (KEK), serta defisiensi mikronutrien seperti zat besi dan asam folat. Kondisi ini menjadi faktor risiko utama terjadinya komplikasi kehamilan dan persalinan (Mulati, 2020; WHO, 2016).

2. Konsep Dasar Gizi Prakonsepsi dan Antenatal

Gizi prakonsepsi adalah kondisi nutrisi perempuan sebelum kehamilan yang bertujuan untuk mempersiapkan tubuh dalam menghadapi proses reproduksi. Sementara itu, gizi antenatal adalah pemenuhan kebutuhan nutrisi selama kehamilan untuk mendukung pertumbuhan janin dan kesehatan ibu (Dean et al., 2014a). Kebutuhan gizi pada masa ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk usia, status kesehatan, aktivitas fisik, serta kondisi sosial ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan individual sangat diperlukan dalam perencanaan intervensi gizi (Brown et al., 2017).

3. Gizi pada Masa Prakonsepsi

a. Status Gizi dan Indeks Massa Tubuh (IMT)

Status gizi prakonsepsi yang optimal ditandai dengan IMT normal (18,5–24,9 kg/m²). Baik kekurangan maupun kelebihan berat badan dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan seperti infertilitas, diabetes gestasional, dan preeklamsia (WHO, 2016).

b. Kebutuhan Zat Gizi Makro

Karbohidrat, protein, dan lemak merupakan sumber energi utama yang diperlukan untuk menjaga fungsi tubuh dan kesiapan reproduksi. Asupan protein yang cukup penting untuk mendukung pembentukan sel dan jaringan (Wu, 2016)

c. Kebutuhan Zat Gizi Mikro

Zat gizi mikro memiliki peran penting dalam kesehatan reproduksi, antara lain (WHO, 2016, 2021):

- 1) Asam folat: mencegah cacat tabung saraf
- 2) Zat besi: mencegah anemia
- 3) Iodium: mendukung perkembangan otak janin
- 4) Kalsium: mendukung kesehatan tulang

d. Masalah Gizi pada Masa Prakonsepsi

Masalah gizi pada masa prakonsepsi merupakan faktor penting yang memengaruhi keberhasilan kehamilan dan kesehatan janin. Kondisi gizi yang tidak optimal sebelum kehamilan dapat meningkatkan risiko komplikasi seperti infertilitas, keguguran, kelahiran prematur, dan bayi berat lahir rendah (Dean et al., 2014a; World Health Organization, 2013).

Salah satu masalah gizi yang paling umum adalah **anemia defisiensi besi**, yang prevalensinya masih tinggi pada perempuan usia subur di negara berkembang. Anemia dapat menyebabkan penurunan kapasitas kerja, gangguan fungsi imun, serta meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan (WHO, 2025; World Health Organization, 2016). Selain anemia, **kekurangan energi kronis (KEK)** juga menjadi masalah utama yang ditandai dengan rendahnya cadangan energi tubuh. KEK berhubungan dengan peningkatan risiko bayi berat lahir rendah dan pertumbuhan janin terhambat (World Health Organization, 2024a). Di sisi lain, **obesitas** pada masa prakonsepsi juga menjadi masalah yang semakin meningkat secara global. Obesitas berhubungan dengan peningkatan risiko diabetes gestasional, preeklamsia, serta komplikasi persalinan (Poston et al., 2016; WHO, 2016).

Defisiensi mikronutrien seperti asam folat, iodium, dan vitamin D juga memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan reproduksi. Kekurangan asam folat dapat menyebabkan cacat tabung saraf, sementara defisiensi iodium berhubungan dengan gangguan perkembangan kognitif anak (UNICEF et al., 2019; WHO, 2016). Faktor sosial ekonomi, pendidikan, dan budaya turut berkontribusi terhadap terjadinya masalah gizi prakonsepsi. Perempuan dengan akses terbatas terhadap makanan bergizi dan layanan kesehatan memiliki risiko lebih tinggi mengalami malnutrisi (Marmot, 2015).

e. Intervensi Gizi Prakonsepsi

Intervensi meliputi suplementasi, edukasi gizi, dan fortifikasi makanan yang terbukti efektif dalam meningkatkan status gizi perempuan usia subur (Bhutta et al., 2013).

f. Edukasi Gizi pada Masa Prakonsepsi

Edukasi gizi pada masa prakonsepsi merupakan intervensi penting untuk meningkatkan pengetahuan dan perilaku kesehatan perempuan sebelum kehamilan. Edukasi ini bertujuan untuk mempersiapkan kondisi tubuh yang optimal guna mendukung kehamilan yang sehat (Dean et al., 2014a). Materi edukasi meliputi pemenuhan kebutuhan gizi seimbang, pentingnya suplementasi asam folat, serta pencegahan anemia melalui konsumsi makanan kaya zat besi. Intervensi edukasi terbukti meningkatkan kepatuhan terhadap pola makan sehat dan suplementasi (Bhutta et al., 2013).

Pendekatan edukasi harus mempertimbangkan aspek budaya dan sosial agar pesan kesehatan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Pendekatan berbasis komunitas dan keluarga terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan individual (Glanz, K., Rimer, B. K., & Viswanath, 2015). Metode edukasi dapat dilakukan melalui konseling, kelas kesehatan, maupun media digital. Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi kesehatan memungkinkan penyampaian informasi yang lebih luas dan interaktif. Peran tenaga kesehatan, khususnya perawat, sangat penting dalam memberikan edukasi yang berbasis evidence dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan kehamilan (World Health Organization, 2021).

4. Gizi pada Masa Antenatal

a. Kebutuhan Energi

Kebutuhan energi meningkat selama kehamilan untuk mendukung pertumbuhan janin, plasenta, dan jaringan ibu. Tambahan energi sekitar 300–450 kkal/hari diperlukan pada trimester kedua dan ketiga (WHO, 2016).

b. Kebutuhan Protein

Protein diperlukan untuk pembentukan jaringan janin dan ibu. Kebutuhan protein meningkat sekitar 1,1 g/kgBB/hari selama kehamilan (Wu, 2016).

c. Kebutuhan Mikronutrien

Mikronutrien penting meliputi (WHO, 2016):

- 1) Zat besi: mencegah anemia
- 2) Asam folat: mencegah cacat lahir
- 3) Kalsium: mencegah preeklamsia
- 4) Vitamin D: mendukung kesehatan tulang

d. Kenaikan Berat Badan Selama Kehamilan

Kenaikan berat badan harus sesuai dengan IMT awal untuk menghindari risiko komplikasi seperti BBLR atau makrosomia (IOM, 2014).

e. Masalah Gizi dalam Kehamilan

Masalah gizi selama kehamilan merupakan salah satu determinan utama yang memengaruhi kesehatan ibu dan janin. Kondisi nutrisi yang tidak adekuat selama masa gestasi dapat meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas maternal maupun neonatal, termasuk anemia, preeklamsia, pertumbuhan janin terhambat, persalinan prematur, dan bayi berat lahir rendah (BBLR) (Victora et al., 2021; WHO, 2016).

Kehamilan menyebabkan peningkatan kebutuhan energi, protein, vitamin, dan mineral untuk mendukung perkembangan janin, plasenta, serta perubahan fisiologis tubuh ibu. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan asupan dapat

menyebabkan berbagai gangguan gizi, baik kekurangan maupun kelebihan nutrisi (Brown et al., 2017; IOM, 2014).

1) Anemia Defisiensi Besi

Anemia defisiensi besi merupakan masalah gizi paling umum pada kehamilan dan menjadi penyebab utama kelelahan maternal, penurunan kapasitas kerja, infeksi, hingga peningkatan risiko perdarahan postpartum (WHO, 2016). Peningkatan volume plasma selama kehamilan menyebabkan hemodilusi fisiologis, sehingga kebutuhan zat besi meningkat secara signifikan untuk mendukung pembentukan hemoglobin ibu dan janin. Faktor risiko anemia meliputi asupan zat besi yang rendah, infeksi, jarak kehamilan yang dekat, dan status sosial ekonomi rendah (Mulati, 2020).

2) Kekurangan Energi Kronis (KEK)

KEK pada ibu hamil ditandai dengan cadangan energi tubuh yang rendah dan sering diidentifikasi melalui ukuran lingkaran lengan atas (LILA) <23,5 cm. Kondisi ini meningkatkan risiko BBLR, persalinan prematur, dan mortalitas neonatal (Victora et al., 2021). KEK umumnya disebabkan oleh asupan energi yang tidak mencukupi dalam jangka panjang, kemiskinan, dan rendahnya akses pangan bergizi (UNICEF et al., 2019).

3) Defisiensi Asam Folat

Asam folat berperan penting dalam sintesis DNA dan pembentukan tabung saraf janin. Kekurangan asam folat pada trimester awal berhubungan dengan peningkatan risiko neural tube defects seperti spina bifida (WHO, 2016).

4) Defisiensi Kalsium dan Vitamin D

Defisiensi kalsium pada kehamilan berhubungan dengan peningkatan risiko hipertensi gestasional dan preeklamsia (WHO, 2016).

Vitamin D penting untuk metabolisme kalsium dan perkembangan skeletal janin. Defisiensi vitamin D dapat meningkatkan risiko gangguan pertumbuhan tulang (NIH, 2022).

5) Obesitas dan Overnutrition

Selain kekurangan gizi, obesitas maternal juga menjadi masalah serius. Obesitas meningkatkan risiko diabetes gestasional, hipertensi, preeklamsia, persalinan operatif, dan komplikasi neonatal (Poston et al., 2016). Kelebihan berat badan pada kehamilan juga berhubungan dengan makrosomia dan peningkatan risiko obesitas pada anak di masa depan (WHO, 2016).

5. Intervensi Keperawatan dalam Gizi Maternal

Intervensi keperawatan dalam gizi maternal merupakan bagian integral dari pelayanan antenatal yang bertujuan mengoptimalkan status nutrisi ibu dan janin

melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative (Pender, Nola J.; Murdaugh, Carolyn L.; Parsons, 2015).

a. Pengkajian Status Gizi

Pengkajian awal meliputi:

- 1) IMT prakehamilan
- 2) Kenaikan berat badan
- 3) LILA
- 4) Riwayat diet
- 5) Pemeriksaan laboratorium (Hb, ferritin)

Pengkajian komprehensif memungkinkan identifikasi dini risiko gizi.

b. Diagnosa Keperawatan

Diagnosa yang umum meliputi:

- 1) Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh
- 2) Risiko ketidakseimbangan glukosa darah
- 3) Defisit pengetahuan tentang nutrisi kehamilan

Pendekatan SDKI dapat digunakan untuk standardisasi praktik keperawatan (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017)

c. Intervensi Edukatif

Perawat memberikan edukasi terkait:

- 1) Diet seimbang
- 2) Porsi makan
- 3) Frekuensi konsumsi
- 4) Suplementasi
- 5) Keamanan pangan

Intervensi edukatif berbasis keluarga terbukti meningkatkan kepatuhan ibu (Glanz, K., Rimer, B. K., & Viswanath, 2015).

d. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan secara berkala terhadap:

- 1) Berat badan
- 2) Hb
- 3) Kepatuhan suplementasi
- 4) Pola makan

Evaluasi penting untuk memastikan efektivitas intervensi (WHO, 2016).

e. Kolaborasi Interprofesional

Kolaborasi dengan ahli gizi, dokter, dan bidan penting dalam manajemen kasus gizi kompleks seperti diabetes gestasional atau obesitas (WHO, 2016).

6. Evidence Based Practice dalam Gizi Maternal

Evidence-Based Practice (EBP) dalam gizi maternal merupakan pendekatan yang mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik dengan keahlian klinis dan preferensi pasien dalam pengambilan keputusan terkait intervensi gizi (Melnyk & Fineout-Overholt, 2019). Intervensi berbasis bukti yang telah terbukti efektif antara lain suplementasi zat besi dan asam folat, fortifikasi makanan, serta edukasi gizi yang terstruktur. Program suplementasi zat besi secara signifikan menurunkan prevalensi anemia pada ibu hamil (Bhutta et al., 2013; WHO, 2016). Selain itu, suplementasi kalsium pada ibu hamil dengan risiko tinggi terbukti menurunkan kejadian preeklamsia. Intervensi ini direkomendasikan oleh World Health Organization sebagai bagian dari pelayanan antenatal (WHO, 2016).

Pendekatan EBP juga menekankan pentingnya penggunaan data dan penelitian terkini dalam merancang program intervensi gizi yang efektif dan efisien. Hal ini memungkinkan tenaga kesehatan untuk memberikan intervensi yang tepat sasaran (Glanz, K., Rimer, B. K., & Viswanath, 2015).

Dalam praktik keperawatan, penerapan EBP meningkatkan kualitas pelayanan dan outcome pasien melalui penggunaan intervensi yang telah teruji secara ilmiah (Melnyk & Fineout-Overholt, 2019).

7. Implikasi praktik keperawatan dalam gizi maternal

Implikasi praktik keperawatan dalam gizi maternal menuntut perawat untuk memiliki kompetensi dalam pengkajian, intervensi, dan evaluasi status gizi ibu secara komprehensif. Pengkajian gizi meliputi penilaian antropometri, asupan makanan, dan kondisi klinis. Perawat juga berperan dalam memberikan edukasi gizi yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, termasuk mempertimbangkan faktor budaya, sosial, dan ekonomi pasien. Pendekatan ini dikenal sebagai *culturally sensitive care*. Selain itu, perawat harus mampu berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain seperti ahli gizi dan dokter dalam memberikan pelayanan yang holistik. Kolaborasi interprofesional terbukti meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan maternal (WHO, 2016).

Pemanfaatan teknologi digital dalam praktik keperawatan juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas edukasi dan monitoring status gizi ibu. Telehealth dan aplikasi kesehatan memungkinkan pemantauan yang lebih kontinu (World Health Organization, 2021). Perawat juga berperan sebagai advokat dalam memastikan ibu mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan pelayanan kesehatan yang memadai, terutama pada kelompok rentan (Schober, 2020).

C. Imunisasi

1. Pendahuluan

Imunisasi merupakan salah satu intervensi kesehatan masyarakat paling efektif, aman, dan *cost-effective* dalam mencegah penyakit infeksi yang dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas ibu maupun bayi. Dalam kesehatan reproduksi, imunisasi pada masa prakonsepsi dan antenatal berfungsi melindungi perempuan sebelum kehamilan, selama kehamilan, serta memberikan perlindungan pasif kepada janin dan bayi baru lahir melalui transfer antibodi maternal (ACOG, 2026; Centers for Disease Control and Prevention, 2025a).

Pendekatan imunisasi dalam keperawatan maternitas tidak hanya berfokus pada pencegahan penyakit individu, tetapi juga pada perlindungan lintas generasi (*intergenerational protection*) (Healy & Baker, 2020; Munoz et al., 2018). Infeksi tertentu pada masa prakonsepsi atau kehamilan dapat berdampak serius terhadap outcome maternal-fetal (Centers for Disease Control and Prevention, 2025a; WHO, 2022).

Dalam pendekatan *life-course immunization*, perlindungan melalui vaksinasi dimulai sejak perempuan usia reproduktif, diperkuat pada masa prakonsepsi, dilanjutkan saat kehamilan, dan dievaluasi kembali pada masa nifas. Strategi ini mendukung konsep *continuum of care* dalam kesehatan maternal (World Health Organization, 2024c).

2. Konsep Dasar Imunisasi dalam Kesehatan Reproduksi

Imunisasi adalah proses pemberian vaksin untuk merangsang sistem imun membentuk respons protektif spesifik terhadap patogen tertentu. Vaksin bekerja dengan menstimulasi pembentukan antibodi dan memori imunologis tanpa menimbulkan penyakit berat seperti infeksi alami (Orenstein et al., 2018).

Dalam kesehatan reproduksi, tujuan imunisasi meliputi (ACOG, 2026):

- a. Melindungi perempuan usia subur dari penyakit infeksi sebelum kehamilan
- b. Mencegah transmisi vertikal ibu-ke-janin
- c. Menurunkan risiko kelainan kongenital
- d. Mengurangi morbiditas dan mortalitas maternal-neonatal)

Jenis vaksin dalam konteks reproduksi dapat dibagi menjadi:

- a. Vaksin hidup dilemahkan (*live attenuated vaccines*)

Contoh vaksin ini antara lain: MMR, varisela. Umumnya dikontraindikasikan selama kehamilan (CDC, 2023).

- b. Vaksin inaktif

Contoh vaksin inaktif: influenza inaktif, hepatitis B, Td/Tdap. Umumnya aman pada kehamilan (ACOG, 2022).

c. Toksoid

Contoh vaksin toksoid: tetanus toxoid. Berfungsi membentuk kekebalan terhadap toksin bakteri (WHO, 2017).

Pemahaman klasifikasi ini penting dalam praktik keperawatan agar pemberian imunisasi sesuai prinsip keamanan maternal-fetal.

3. Imunisasi pada Masa Prakonsepsi

a. Tujuan Imunisasi Prakonsepsi

Imunisasi prakonsepsi bertujuan memastikan perempuan memasuki kehamilan dengan status imunologis optimal sehingga risiko infeksi yang dapat dicegah vaksin dapat diminimalkan (World Health Organization, 2013). Periode prakonsepsi menjadi waktu ideal untuk evaluasi riwayat imunisasi karena beberapa vaksin penting, terutama vaksin hidup, tidak direkomendasikan selama kehamilan (Centers for Disease Control and Prevention, 2025a).

b. Skrining Status Imunisasi

Skrining merupakan bagian integral dari pelayanan pranikah dan prakonsepsi (ACOG, 2026). Skrining tersebut meliputi:

- 1) Riwayat vaksinasi masa kecil
- 2) Status rubella
- 3) Status hepatitis B
- 4) Status tetanus
- 5) Risiko varisela
- 6) HPV

c. Jenis Imunisasi yang Direkomendasikan

1) Rubella (MMR)

Rubella pada awal kehamilan dapat menyebabkan CRS berupa tuli sensorineural, penyakit jantung bawaan, dan gangguan neurologis (WHO, 2020). Vaksin MMR direkomendasikan sebelum kehamilan dengan penundaan konsepsi minimal 1 bulan pascavaksinasi (Centers for Disease Control and Prevention, 2025a).

2) Varisela

Infeksi varisela maternal dapat menyebabkan pneumonia maternal berat dan congenital varicella syndrome (Centers for Disease Control and Prevention, 2025a)

3) Hepatitis B

Direkomendasikan pada perempuan dengan risiko tinggi atau status imunisasi tidak lengkap (WHO, 2017).

4) HPV

Penting untuk pencegahan kanker serviks sebelum kehamilan, terutama pada usia reproduktif muda (WHO, 2022)

5) Tetanus Toxoid (TT/Td/Tdap)

Status imunisasi tetanus harus dipastikan sejak masa prakonsepsi untuk mencegah tetanus maternal dan neonatal (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017, 2017; WHO, 2017)

d. Imunisasi Tetanus pada Perempuan Usia Subur dan Prakonsepsi

Tetanus maternal-neonatal disebabkan oleh paparan *Clostridium tetani* yang sering terkait dengan persalinan tidak steril atau perawatan tali pusat yang tidak higienis (World Health Organization, 2024c). Program imunisasi TT pada wanita usia subur bertujuan memberikan perlindungan jangka panjang sebelum dan selama kehamilan. Di Indonesia, strategi ini diintegrasikan dalam pelayanan calon pengantin, WUS, dan ANC (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017, 2017). Jadwal TT bertahap (TT1–TT5) memungkinkan perlindungan hingga usia reproduktif panjang (WHO, 2017).

4. Imunisasi pada Masa Antenatal

a. Prinsip Dasar

Imunisasi selama kehamilan didasarkan pada evaluasi manfaat-risiko dan hanya menggunakan vaksin yang terbukti aman (ACOG, 2026)

b. Vaksin yang Direkomendasikan

1) Td/Tdap

Melindungi ibu dari tetanus dan bayi dari pertusis melalui transfer antibodi transplasenta (Munoz & Jamieson, 2019).

2) Influenza Inaktif

Melindungi ibu dari komplikasi influenza berat dan menurunkan risiko rawat inap (Centers for Disease Control and Prevention, 2025a).

3) COVID-19

Direkomendasikan karena kehamilan meningkatkan risiko penyakit (WHO, 2022).

4) Hepatitis B

Untuk kelompok risiko tinggi (Centers for Disease Control and Prevention, 2025a).

c. Vaksin Kontraindikasi dalam Kehamilan

Vaksin hidup seperti MMR, Varisela, dan Live influenza nasal tidak direkomendasikan selama kehamilan karena risiko teoritis terhadap janin (Centers for Disease Control and Prevention, 2025a).

d. Keamanan, Efektivitas, dan Evidence-Based Practice

Bukti ilmiah menunjukkan bahwa imunisasi maternal aman, efektif, dan menurunkan risiko infeksi maternal-neonatal secara signifikan (Healy, 2012). Evidence-based practice mengharuskan tenaga kesehatan menggunakan rekomendasi WHO, CDC, dan ACOG dalam pengambilan keputusan klinis (Melnyk & Fineout-Overholt, 2019).

e. Hambatan dan Isu Kontemporer

Hambatan dalam pemberian imunisasi yang sering ditemui antara lain: Vaccine hesitancy, Hoaks digital, Ketimpangan akses, Faktor budaya, dan Kurangnya rekomendasi provider (MacDonald, 2015).

f. Peran Strategis Perawat

Perawat maternitas berperan sebagai:

1) Educator

Memberikan edukasi vaksin berbasis evidence (Pender, Nola J.; Murdaugh, Carolyn L.; Parsons, 2015)

2) Counselor

Mengurangi kecemasan dan keraguan (Schober, 2020)

3) Advocate

Meningkatkan akses imunisasi (Munoz & Jamieson, 2019)

4) Care Coordinator

Memastikan dokumentasi dan tindak lanjut imunisasi (Centers for Disease Control and Prevention, 2025a)

g. Implikasi Praktik Keperawatan

Untuk dapat mengoptimalkan program imunisasi prakonsepsi dan kehamilan, maka perawat perlu melakukan beberapa hal, antara lain:

1) Skrining status imunisasi

2) Edukasi prakonsepsi

3) Integrasi imunisasi dalam ANC

4) Kolaborasi interprofesional

5) Monitoring kepatuhan

D. Perencanaan Kehamilan

1. Pendahuluan

Perencanaan kehamilan merupakan komponen esensial dalam kesehatan reproduksi yang bertujuan memastikan kehamilan terjadi pada waktu yang diinginkan, dalam kondisi kesehatan optimal, serta dengan kesiapan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang memadai. Kehamilan yang direncanakan terbukti berhubungan dengan peningkatan kesehatan maternal, penurunan

komplikasi obstetri, serta outcome neonatal yang lebih baik dibandingkan kehamilan yang tidak direncanakan (Dean et al., 2014a; World Health Organization, 2013).

Dalam perspektif kesehatan masyarakat, perencanaan kehamilan merupakan strategi preventif primer yang memungkinkan identifikasi dan modifikasi faktor risiko sebelum konsepsi, termasuk penyakit kronis, status gizi, imunisasi, perilaku berisiko, dan kondisi psikososial (Centers for Disease Control and Prevention, 2025b). Pendekatan ini sejalan dengan konsep *preconception care* yang menekankan bahwa kesehatan ibu dan bayi dimulai sebelum terjadinya fertilisasi.

Kehamilan yang tidak direncanakan masih menjadi tantangan global dengan dampak luas, termasuk keterlambatan antenatal care, peningkatan risiko depresi maternal, rendahnya status gizi, serta meningkatnya komplikasi maternal-neonatal. Oleh karena itu, perencanaan kehamilan menjadi bagian penting dari continuum of reproductive care.

Dalam praktik keperawatan maternitas, perencanaan kehamilan tidak hanya berfokus pada fertilitas, tetapi juga pada pemberdayaan perempuan dan pasangan dalam membuat keputusan reproduktif yang sehat, aman, dan berbasis informasi (Schober, 2020).

2. Konsep Dasar Perencanaan Kehamilan

Perencanaan kehamilan adalah proses sistematis yang melibatkan persiapan biologis, medis, psikologis, sosial, dan ekonomi sebelum terjadinya konsepsi. *World Health Organization* juga menyebutkan bahwa tujuan utama dari perencanaan kehamilan meliputi: a. Mengoptimalkan kesehatan perempuan sebelum hamil, b. Mengurangi faktor risiko maternal-fetal, c. Menentukan waktu terbaik untuk kehamilan, d. Meningkatkan kesiapan keluarga, e. Mendukung outcome ibu dan bayi yang sehat (Dean et al., 2014a; World Health Organization, 2013).

Konsep ini menempatkan kehamilan sebagai hasil keputusan sadar, bukan sekadar kejadian biologis. Oleh karena itu, perencanaan kehamilan sangat berkaitan dengan hak reproduksi, pendidikan kesehatan, dan akses layanan kesehatan reproduksi.

3. Komponen Utama Perencanaan Kehamilan

a. Kesiapan Biologis dan Medis

Evaluasi kesehatan biologis merupakan dasar utama dalam perencanaan kehamilan. Pemeriksaan prakonsepsi meliputi: Status gizi, IMT, Penyakit kronis (diabetes, hipertensi, epilepsi), Penyakit infeksi (HIV, hepatitis B, sifilis), Riwayat obstetric, Status imunisasi. Kondisi medis yang tidak terkontrol sebelum

kehamilan dapat meningkatkan risiko abortus, kelainan kongenital, preeklamsia, dan kematian maternal (Centers for Disease Control and Prevention, 2025b; World Health Organization, 2013).

b. Kesiapan Psikologis

Kesehatan mental merupakan aspek penting dalam kesiapan kehamilan. Perempuan dengan kesiapan psikologis yang baik cenderung memiliki adaptasi maternal lebih sehat dan risiko depresi perinatal lebih rendah (World Health Organization, 2025a). Gangguan kecemasan, depresi, kekerasan dalam rumah tangga, dan stres kronis perlu diidentifikasi sejak masa prakonsepsi karena dapat memengaruhi perilaku kesehatan dan outcome kehamilan (UNICEF et al., 2019).

c. Kesiapan Sosial dan Ekonomi

Faktor sosial ekonomi memengaruhi akses terhadap nutrisi, layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan keluarga. Stabilitas ekonomi dan dukungan pasangan terbukti meningkatkan kualitas perawatan prakonsepsi dan antenatal (Equinet, 2020).

4. Usia Ideal dan Jarak Kehamilan

Usia reproduksi ideal untuk kehamilan umumnya berada pada rentang 20–35 tahun, karena kehamilan usia terlalu muda maupun terlalu tua berhubungan dengan peningkatan risiko komplikasi (WHO, 2013). Kehamilan remaja meningkatkan risiko anemia, persalinan prematur, dan BBLR, sedangkan usia >35 tahun berhubungan dengan peningkatan risiko aneuploidi, hipertensi, dan diabetes gestasional (ACOG, 2019). Jarak kehamilan ideal minimal 24 bulan setelah persalinan sebelumnya direkomendasikan untuk menurunkan risiko prematuritas, BBLR, dan deplesi nutrisi maternal (Khan & Khanam, 2023).

5. Nutrisi dan Suplementasi dalam Perencanaan Kehamilan

Status gizi optimal merupakan fondasi kehamilan sehat. Asam folat direkomendasikan minimal 400 mcg/hari sebelum konsepsi untuk mencegah cacat tabung saraf (Centers for Disease Control and Prevention, 2025b). Selain asam folat, perhatian juga diberikan pada pemberian Zat besi, Iodium, Kalsium, Vitamin D, dan berat badan sehat (WHO, 2013).

Obesitas maupun malnutrisi sebelum kehamilan sama-sama meningkatkan risiko komplikasi (Poston et al., 2016).

6. Perencanaan Reproduksi dan Kontrasepsi

Perencanaan kehamilan berkaitan erat dengan penggunaan kontrasepsi yang efektif hingga pasangan siap untuk konsepsi. Kontrasepsi memungkinkan terjadinya pengaturan waktu kehamilan, jumlah anak, dan jarak kehamilan

(Kementerian Kesehatan RI, 2020). Konseling kontrasepsi harus berbasis hak reproduksi dan informed choice (World Health Organization, 2025a).

7. Pemeriksaan Prakonsepsi

Pemeriksaan prakonsepsi meliputi:

- a. Pemeriksaan fisik umum
- b. Pemeriksaan laboratorium
- c. Skrining genetik bila diperlukan
- d. Evaluasi obat-obatan teratogenik
- e. Konseling gaya hidup (merokok, alkohol, aktivitas fisik)

Pendekatan ini terbukti menurunkan risiko komplikasi maternal-fetal (Dean et al., 2014a).

8. Edukasi dan Konseling Perencanaan Kehamilan

Edukasi bertujuan meningkatkan literasi kesehatan reproduksi dan kemampuan pengambilan keputusan pasangan. Topik utama yang dapat digunakan untuk edukasi antara lain: Siklus menstruasi dan masa subur, Nutrisi, Imunisasi, Penyakit kronis, Kesehatan mental, Risiko kehamilan, dll. Pendekatan edukasi berbasis keluarga dan budaya terbukti lebih efektif (Glanz, K., Rimer, B. K., & Viswanath, 2015).

9. Peran Strategis Perawat dalam Perencanaan Kehamilan

Perawat maternitas berperan sebagai:

- a. Educator
Menyampaikan informasi kesehatan reproduksi berbasis evidence (Pender, Nola J.; Murdaugh, Carolyn L.; Parsons, 2015)
- b. Counselor
Membantu pasangan membuat keputusan reproduktif sehat (Schober, 2020).
- c. Advocate
Memastikan akses layanan prakonsepsi (Rai, 2014).
- d. Care Coordinator
Mengintegrasikan skrining, edukasi, dan rujukan (Centers for Disease Control and Prevention, 2025b)

10. Evidence-Based Practice dalam Perencanaan Kehamilan

Evidence-based practice menekankan bahwa intervensi prakonsepsi seperti suplementasi asam folat, kontrol penyakit kronis, penghentian merokok, dan imunisasi sebelum kehamilan terbukti menurunkan komplikasi signifikan (Dean et al., 2014a). Praktik berbasis bukti juga mendorong pendekatan individualisasi sesuai faktor risiko pasien.

11. Tantangan dan Isu Kontemporer

Hambatan utama dalam sosialisasi perencanaan kehamilan bagi masyarakat khususnya WUS antara lain : Rendahnya literasi prakonsepsi, Kehamilan tidak direncanakan, Ketimpangan akses layanan, Norma budaya, Pernikahan usia dini, Misinformasi digital (World Health Organization, 2013, 2021). Perawat perlu mengembangkan pendekatan promotif berbasis komunitas untuk mengatasi tantangan ini.

12. Implikasi Praktik Keperawatan

Praktik keperawatan modern menuntut integrasi, meliputi: Skrining prakonsepsi, Edukasi berbasis budaya, Kesehatan mental, Perencanaan reproduksi, dan Kolaborasi interprofessional. Pendekatan holistik ini mendukung kesehatan ibu, bayi, dan keluarga secara berkelanjutan (Rai, 2014).

E. Ketidaknyamanan Kehamilan

1. Pendahuluan

Ketidaknyamanan selama kehamilan merupakan kondisi fisiologis yang umum terjadi akibat perubahan anatomi, hormonal, dan metabolik pada tubuh ibu. Perubahan ini merupakan bentuk adaptasi tubuh terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin, namun dapat menimbulkan keluhan yang mempengaruhi kualitas hidup ibu hamil (Cunningham et al., 2022; Lowdermilk & Perry, 2019).

Sebagian besar ketidaknyamanan bersifat ringan dan tidak membahayakan, tetapi tetap memerlukan perhatian karena dapat berkembang menjadi kondisi patologis apabila tidak ditangani dengan tepat (ACOG, 2018). Oleh karena itu, peran perawat sangat penting dalam melakukan edukasi, deteksi dini, dan intervensi yang tepat.

2. Perubahan Fisiologis Penyebab Ketidaknyamanan

Ketidaknyamanan kehamilan sebagian besar disebabkan oleh perubahan fisiologis yang kompleks, termasuk perubahan hormonal, mekanik, dan sistemik yang terjadi selama masa gestasi (Cunningham et al., 2022)

Perubahan hormon progesteron menyebabkan relaksasi otot polos yang berdampak pada sistem gastrointestinal dan musculoskeletal. Sementara itu, pembesaran uterus memberikan tekanan pada organ-organ di sekitarnya. (Lowdermilk & Perry, 2019).

3. Jenis Ketidaknyamanan Kehamilan

a. Mual dan Muntah (Nausea and Vomiting)

Mual dan muntah merupakan keluhan yang paling sering terjadi pada trimester pertama kehamilan dan dialami oleh sekitar 70–80% ibu hamil. Peningkatan hormon human chorionic gonadotropin (hCG) dan estrogen

mempengaruhi pusat muntah di otak, sehingga memicu mual dan muntah. Penatalaksanaan kasus mual muntah dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain: Makan dalam porsi kecil dan sering, Menghindari makanan berlemak, Konsumsi jahe atau dan vitamin B6 (Cunningham et al., 2022).

b. Nyeri Punggung

Nyeri punggung sering terjadi pada trimester kedua dan ketiga akibat perubahan postur tubuh dan peningkatan berat badan (Lowdermilk & Perry, 2019). Relaksasi ligamen akibat hormon relaksin menyebabkan instabilitas sendi, sehingga meningkatkan risiko nyeri punggung. Tata laksana dapat dilakukan melalui beberapa Langkah yaitu Latihan peregangan, Posisi tubuh yang benar, dan Penggunaan penyangga perut (Cunningham et al., 2022).

c. Edema

Edema fisiologis pada kehamilan umumnya terjadi pada ekstremitas bawah akibat retensi cairan dan tekanan vena (ACOG, 2018). Tekanan uterus pada vena cava inferior menyebabkan penurunan aliran balik vena, sehingga terjadi akumulasi cairan. Penatalaksanaan yang tepat pada kasus ini yaitu Elevasi kaki, Hindari berdiri lama, dan gunakan stocking kompresi (Cunningham et al., 2022).

d. Konstipasi

Konstipasi sering terjadi selama kehamilan akibat penurunan motilitas usus (Lowdermilk & Perry, 2019). Progesteron memperlambat peristaltik usus, sehingga menyebabkan konstipasi. Penatalaksanaan kasus ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah yaitu Diet tinggi serat, Peningkatan asupan cairan, dan Aktivitas fisik ringan (Cunningham et al., 2022).

4. Peran Perawat dalam Penanganan Ketidaknyamanan

Perawat memiliki peran strategis dalam membantu ibu hamil mengatasi ketidaknyamanan melalui pendekatan holistik yang mencakup aspek fisik, psikologis, dan edukatif. Perawat tidak hanya memberikan intervensi langsung, tetapi juga memberdayakan ibu melalui edukasi dan konseling. Intervensi Keperawatan dilakukan dengan Edukasi tentang perubahan fisiologis, Konseling gaya hidup sehat, Monitoring tanda bahaya (Cunningham et al., 2022).

5. Indikator Rujukan

Tidak semua ketidaknyamanan bersifat fisiologis. Beberapa kondisi dapat menjadi tanda komplikasi serius yang memerlukan rujukan segera (ACOG, 2021). Yang harus diperhatikan antara lain mual muntah berlebihan (hiperemesis gravidarum), edema disertai hipertensi, dan nyeri hebat. (Cunningham et al., 2022).

F. Edukasi Prakonsepsi dan Kehamilan

1. Pendahuluan

Edukasi kesehatan pada fase prakonsepsi dan kehamilan merupakan komponen inti dalam asuhan keperawatan maternitas yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku kesehatan perempuan serta pasangannya agar mampu merencanakan dan menjalani kehamilan secara aman (Kemenkes RI, 2021; World Health Organization, 2013). Edukasi yang efektif terbukti meningkatkan kesiapan kehamilan, kepatuhan kunjungan antenatal, serta menurunkan risiko komplikasi maternal dan neonatal (World Health Organization, 2013).

Edukasi pada fase prakonsepsi berfokus pada pencegahan risiko sebelum kehamilan terjadi, sedangkan edukasi antenatal menekankan adaptasi selama kehamilan serta kesiapan persalinan dan perawatan bayi (Dean et al., 2014a).

2. Konsep dan Prinsip Edukasi Kesehatan

Edukasi kesehatan merupakan proses pembelajaran sistematis untuk meningkatkan literasi kesehatan individu dan keluarga dalam pengambilan keputusan (Glanz, K., Rimer, B. K., & Viswanath, 2015). Edukasi harus memenuhi prinsip:

- a. Individualisasi: sesuai kebutuhan individu dan pasangan (WHO, 2023)
- b. Partisipatif: melibatkan klien secara aktif (Mulati, 2020)
- c. Berbasis budaya: mempertimbangkan nilai lokal (WHO, 2023)
- d. Kontinu: sejak prakonsepsi hingga postpartum (WHO, 2016)

3. Edukasi Kesehatan Prakonsepsi

Edukasi prakonsepsi bertujuan meningkatkan kesiapan biologis, psikologis, dan sosial sebelum kehamilan untuk menurunkan risiko komplikasi (Dean et al., 2014a). Materi edukasi yang dapat diberikan pada periode prakonsepsi di antara: Perencanaan kehamilan, Skrining kesehatan (anemia, penyakit kronis), Suplementasi asam folat, Gaya hidup sehat (tidak merokok, nutrisi seimbang), dll. Intervensi prakonsepsi terbukti menurunkan risiko cacat lahir dan komplikasi obstetri (Dean et al., 2014a; WHO, 2016).

4. Edukasi Kesehatan Selama Kehamilan

Edukasi antenatal berfokus pada pemantauan kehamilan, deteksi dini komplikasi, serta peningkatan kesiapan persalinan. Tanda Bahaya Kehamilan yang layak dikenali oleh ibu hamil sejak dini untuk memberikan peluang keselamatan ibu dan janin yaitu: Perdarahan, Nyeri hebat, dan Penurunan gerak janin (WHO, 2016). Selain itu ibu hamil juga perlu menerima edukasi dengan materi tentang Persiapan Persalinan meliputi: Tempat persalinan, Transportasi, Biaya, Bidan, Obat-Obatan, Pendamping, dan Uang. Birth preparedness menurunkan

keterlambatan pelayanan (WHO, 2016). Ibu hamil juga perlu memperoleh edukasi tentang Perawatan Bayi Baru Lahir yang meliputi IMD dan ASI eksklusif untuk sif meningkatkan kesehatan bayi (World Health Organization, 2023). Selanjutnya ibu hamil juga perlu menerima edukasi tentang Gizi dan Gaya Hidup yaitu mengenai Diet seimbang dan Aktivitas fisik aman. Gaya hidup sehat meningkatkan outcome kehamilan (Kominiarek & Peaceman, 2017).

5. Metode dan Media Edukasi

Metode edukasi yang tepat meningkatkan efektivitas perubahan perilaku kesehatan (Glanz, K., Rimer, B. K., & Viswanath, 2015). Macam-macam metode edukasi yang dapat digunakan di antaranya Konseling individu, Kelas ibu hamil, Edukasi pasangan (Notoatmojo, 2018; WHO, 2016; World Health Organization, 2013). Sedangkan media edukasi yang dapat digunakan yaitu Leaflet, Video, dan Aplikasi digital. Media audiovisual meningkatkan pemahaman individu lebih baik (WHO, 2023).

6. Evaluasi Edukasi

Evaluasi bertujuan menilai pemahaman dan perubahan perilaku klien. Evaluasi dapat dilakukan melalui Tanya jawab, Observasi, dan Kuesioner (Notoatmojo, 2018).

7. Peran Perawat

Perawat berperan sebagai edukator dan konselor dalam seluruh siklus reproduksi (Kemenkes RI, 2020). Perawat dapat berperan sebagai Edukator, Konselor, maupun Advokat (Schober, 2020).

G. Penutup

Asuhan keperawatan prakonsepsi dan antenatal merupakan fondasi penting dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak secara berkelanjutan. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada penanganan masalah kesehatan, tetapi juga pada upaya promotif dan preventif melalui edukasi, pemberdayaan, serta peningkatan kesadaran kesehatan perempuan dan keluarga.

Melalui buku ini, telah dibahas secara komprehensif berbagai aspek penting yang meliputi promosi kesehatan, pemenuhan kebutuhan gizi, imunisasi, perencanaan kehamilan, penanganan ketidaknyamanan selama kehamilan, serta edukasi kesehatan pada fase prakonsepsi dan antenatal. Keseluruhan materi disusun dengan pendekatan evidence-based dan terintegrasi dengan standar asuhan keperawatan.

Diharapkan buku ini dapat menjadi pedoman praktis sekaligus referensi ilmiah dalam meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, khususnya perawat dan bidan, dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Selain itu, buku ini juga diharapkan

dapat berkontribusi dalam menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi melalui peningkatan kualitas asuhan keperawatan.

Akhirnya, semoga buku ini memberikan manfaat yang luas bagi dunia pendidikan dan praktik kesehatan, serta menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Referensi

- ACOG. (2018). Practice Bulletin No. 189: Nausea And Vomiting Of Pregnancy. *Obstetrics and Gynecology*, 131(1), e15–e30. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000002456>
- ACOG. (2019). Prepregnancy Counseling. *Obstetrics & Gynecology*, 133(1), e78–e89. <http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage&an=00006250-200601000-00051%0Ahttp://journals.lww.com/00006250-201901000-00053>
- ACOG. (2026). Maternal Immunizations.pdf. *American College of Obstreticians and Gynecologisteticians and Gynecologist*, 147(5). <https://www.acog.org/-/media/project/acog/acogorg/clinical/files/committee-statement/articles/2026/02/maternal-immunizations.pdf?rev=18c3aef1d22240d4a2f21323481d0e8d&hash=1F85003A8C2C1C60B9D4BE48B9296785>
- Andriani, H., Rachmadani, S. D., Natasha, V., & Saptari, A. (2022). Continuum of care in maternal, newborn and child health in Indonesia: Evidence from the Indonesia Demographic and Health Survey. *Journal of Public Health Research*, 11(4). <https://doi.org/10.1177/22799036221127619>
- Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. In *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Prentice-Hall, Inc.
- Bhutta, Z. A., Das, J. K., Rizvi, A., Gaffey, M. F., Walker, N., Horton, S., Webb, P., Lartey, A., & Black, R. E. (2013). Evidence-based interventions for improvement of maternal and child nutrition: What can be done and at what cost? *The Lancet*, 382(9890), 452–477. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60996-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60996-4)
- Brown, J. E., Lechtenberg, E., Murtaugh, M. A., Splett, P. L., Stang, J., Wong, R., Kaiser, L. D., Bowser, E. K., Leonberg, B. L., Sahyoun, N. R., Brazil, A. •, Mexico, •, & Singapore, •. (2017). *Nutrition Through Life Cycle Sixth Edition*.

- Centers for Disease Control and Prevention. (2025a). *Guidelines for Vaccinating Pregnant Women*. <https://www.cdc.gov/vaccines-pregnancy/hcp/vaccination-guidelines/index.html>
- Centers for Disease Control and Prevention. (2025b). *Planning for Pregnancy*. <https://www.cdc.gov/pregnancy/about/index.html>
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Spong, C. Y., & Casey, B. M. (2022). *Williams Obstetrics, Twenty-sixth Edition*. McGraw Hill LLC. <https://books.google.co.id/books?id=2HVKEAAAQBAJ>
- Dean, S. V., Lassi, Z. S., Imam, A. M., & Bhutta, Z. A. (2014a). Preconception care: Closing the gap in the continuum of care to accelerate improvements in maternal, newborn and child health. *Reproductive Health*, 11(Suppl 3), 1–8. <https://doi.org/10.1186/1742-4755-11-S3-S1>
- Dean, S. V., Lassi, Z. S., Imam, A. M., & Bhutta, Z. A. (2014b). Preconception care: Nutritional risks and interventionDean, S. V., Lassi, Z. S., Imam, A. M., & Bhutta, Z. A. (2014). Preconception care: Nutritional risks and interventions. *Reproductive Health*, 11(Suppl 3), S3. <https://doi.org/10.1186/1742-4755-11-S3-S3>. *Reproductive Health*, 11(Suppl 3), S3. <https://doi.org/10.1186/1742-4755-11-S3-S3>
- Du, L., La, X., Zhu, L., Jiang, H., Xu, B., Chen, A., & Li, M. (2021). Utilization of preconception care and its impacts on health behavior changes among expectant couples in Shanghai, China. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 21(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s12884-021-03940-0>
- Equinet. (2020). *Women in Poverty Access to Health and Social Services*. <https://doi.org/10.5040/9798216027195.ch-007>
- Glanz, K., Rimer, B. K., & Viswanath, K. (2015). Health behavior: Theory, research, and practice, 5th ed. In *Health behavior: Theory, research, and practice, 5th ed.* (4th ed.). Jossey-Bass/Wiley.
- Healy, C. M. (2012). Vaccines in pregnant women and research initiatives. *Clinical Obstetrics and Gynecology*, 55(2), 474–486. <https://doi.org/10.1097/GRF.0b013e31824f3acb>
- IOM. (2014). Weight gain during pregnancy. Committee Opinion No. 548. American College of Obstetricians and Gynecologists. *Obstet Gynecol* 2013;121:210–2. *Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery*, 20(5), 248–251.

- Kemenkes RI. (2021). Buku Saku Merencanakan Kehamilan Sehat. In *Kementrian Kesehatan RI*.
- Kemenkes RI. (2023). Panduan Pengelolaan Posyandu Bidang Kesehatan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Pedoman Pelayanan Kontrasepsi dan Keluarga Berencana*. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
- Khan, M. N., & Khanam, S. J. (2023). The effectiveness of WHO's interpregnancy interval advice. *The Lancet Global Health*, 11(10), e1476–e1477. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(23\)00402-3](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(23)00402-3)
- Kominiarek, M. A., & Peaceman, A. M. (2017). Gestational weight gain. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 217(6), 642–651. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2017.05.040>
- Lassi, Z. S., Dean, S. V., Mallick, D., & Bhutta, Z. A. (2014). Preconception care: Delivery strategies and packages for care. *Reproductive Health*, 11(3), S7. <https://doi.org/10.1186/1742-4755-11-S3-S7>
- Lowdermilk, D. L., & Perry, S. E. (2019). Maternity & women's health care. In *Maternity and women's health care* (9th ed.). Mosby Elsevier.
- MacDonald, N. E. (2015). Vaccine hesitancy: Definition, scope and determinants. *Vaccine*, 33(34), 4161–4164. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2015.04.036>
- Marmot, M. (2015). *The health gap: The challenge of an unequal world* (1st ed.). Bloomsbury Publishing. <https://www.bloomsbury.com/us/health-gap-9781632860781/>
- McKenzie, J. F., Neiger, B. L., & Thackeray, R. (2022). *Planning, implementing, and evaluating health promotion programs* (8th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Melnyk, B. M., & Fineout-Overholt, E. (2019). *Evidence-based Practice in Nursing & Healthcare: A Guide to Best Practice* (4th ed.). Wolters Kluwer. <https://books.google.co.id/books?id=8FditAEACAAJ>
- Montaño, D. E., & Kasprzyk, D. (2015). Theory of reasoned action, theory of planned behavior, and the integrated behavioral model. In *Health behavior: Theory, research, and practice*, 5th ed. (pp. 95–124). Jossey-Bass/Wiley.
- Mulati, E. (2020). *Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu*. Kementerian Kesehatan RI. <https://repository.kemkes.go.id/book/147>

- Munoz, F. M., & Jamieson, D. J. (2019). Maternal Immunization. *Obstetrics and Gynecology*, 133(4), 739–753. <https://doi.org/10.1097/AOG.00000000000003161>
- NIH. (2022). Vitamin D - Fact Sheet for Consumers. *National Institutes of Health*. <https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminD-Consumer/>
- Notoatmodjo, S. (2018). *Promosi Kesehatan: Teori dan Aplikasi*. PT Rineka Cipta.
- Notoatmojo, S. (2018). *Promosi Kesehatan Dan Perilaku Kesehatan*. PT Rineka Cipta.
- Nutbeam, D. (2025). Health literacy as a public health goal: 25 years on. *Health Promotion International*, 40(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/heapro/daaf119>
- Opus, B., Namatovu, J. F., Besigye, I. K., Okuuny, V., & Onyango, J. T. (2025). Determinants of birth preparedness and complications readiness among mothers attending the antenatal care clinic at Katakwi General Hospital, Eastern Uganda: a cross-sectional study. *The Pan African Medical Journal*, 50, 107. <https://doi.org/10.11604/pamj.2025.50.107.45514>
- Orenstein, W. A., Plotkin, S. A., Offit, P. A., & Edwards, K. M. (2018). *Plotkin's Vaccines*. Elsevier. <https://books.google.co.id/books?id=2pW5DAEACAAJ>
- Pender, Nola J.; Murdaugh, Carolyn L.; Parsons, M. A. (2015). *Health Promotion in Nursing Practice* (7th ed.). Pearson.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 (2017).
- Poston, L., Caleyachetty, R., Cnattingius, S., Corvalán, C., Uauy, R., Herring, S., & Gillman, M. W. (2016). Preconceptional and maternal obesity: epidemiology and health consequences. *The Lancet. Diabetes & Endocrinology*, 4(12), 1025–1036. [https://doi.org/10.1016/S2213-8587\(16\)30217-0](https://doi.org/10.1016/S2213-8587(16)30217-0)
- Rai, R. K. (2014). Tracking women and children in a Continuum of Reproductive, Maternal, Newborn, and Child Healthcare (RMNCH) in India. *Journal of Epidemiology and Global Health*, 4(3), 239–243. <https://doi.org/10.1016/j.jegh.2013.12.006>
- Schober, M. (2020). Guidelines on Advanced Practice Nursing. In *ICN Regulation series*. https://www.icn.ch/system/files/documents/2020-04/ICN_APN_Report_EN_WEB.pdf
- Tang, Y., Soh, K. L., Gan, W. Y., Zhou, J., & Soh, K. G. (2025). The efficacy of PRECEDE-PROCEED model-based interventions on HbA1c and self-management in type 2 diabetes patients: a systematic review and meta-analysis. *BMC Public Health*,

- 25(1), 1980. <https://doi.org/10.1186/s12889-025-23073-9>
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia Ed 1, Cet II (REVISI) (1) (1 Revisi)*. DPP PPNI.
- UNICEF, Kemenkes RI, & Bappenas. (2019). *Framework of Action Maternal Health 2019* (pp. 1–8).
- United Nations Children's Fund (UNICEF). (2019). State of the World's Children 2019: Children, food and nutrition. In *Unicef*. <https://www.unicef.org/media/63016/file/SOWC-2019.pdf>
- Victora, C. G., Christian, P., Vdaletti, L. P., Gatica-Domínguez, G., Menon, P., & Black, R. E. (2021). Revisiting maternal and child undernutrition in low-income and middle-income countries: variable progress towards an unfinished agenda. *Lancet (London, England)*, 397(10282), 1388–1399. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)00394-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00394-9)
- WHO. (1987). International Conference on Health Promotion: Ottawa charter. *WHO/HPR/HEP/95.1. Unpublished*, 8 p. <http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/>
- WHO. (2013). *WHO guidelines on sexual and reproductive health*.
- WHO. (2016). *WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience*. WHO.
- WHO. (2017). Weekly epidemiological record – Tetanus vaccines: WHO position paper – February 2017. *Weekly Epidemiological Record 2017*, 92(6), 53–76.
- WHO. (2021). *WHO Global Anaemia estimates, 2021 Edition*. https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/anaemia_in_women_and_children
- WHO. (2022). Questions and Answers: COVID-19 vaccines and pregnancy. *World Health Organization*, February, 1–5. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/341811>
- WHO. (2025). *Anaemia in women and children*.
- WHO, U. (2023). WHO recommendations on maternal health: guidelines approved by the WHO Guidelines Review Committee. In *World Health Organization*.
- World Health Organization. (2013). *Preconception care: Maximizing the gains for maternal and child health*. 8.

- World Health Organization. (2015). *WHO recommendations on health promotion interventions*. WHO Press.
- World Health Organization. (2016). *Guideline: Daily iron Supplementation in Adult Women and Adolescent Girls*. World Health Organization; file:///F:/BACKUP/AJARAN MEGA/PENELITIAN/19-20/LAPORAN KEMAJUAN/4. WHO daily_iron_supp_womenandgirls.pdf
- World Health Organization. (2021). *Global Strategy on Digital Health 2020-2025*. WHO Press. <https://www.who.int/docs/default-source/documents/gd4dhdaa2a9f352b0445bafbc79ca799dce4d.pdf>
- World Health Organization. (2023). *Infant and young child feeding*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-feeding>
- World Health Organization. (2024a). *Malnutrition*. WHO. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition>
- World Health Organization. (2024b). *Maternal Mortality*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality>
- World Health Organization. (2024c). *Validation of Maternal and Neonatal Tetanus Elimination*. World Health Organization.
- World Health Organization. (2025a). *Family planning/contraception methods*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/family-planning-contraception>
- World Health Organization. (2025b). *Maternal Mortality*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality>
- Wu, G. (2016). Dietary protein intake and human health. *Food & Function*, 7(3), 1251–1265. <https://doi.org/10.1039/c5fo01530h>

BAB IV

ASUHAN KEPERAWATAN INTRANATAL

A. Pendahuluan

Asuhan keperawatan intranatal merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan maternal yang berfokus pada pemberian asuhan selama proses persalinan berlangsung, mulai dari kala I hingga kala IV persalinan. Masa intranatal merupakan periode yang sangat krusial karena pada tahap ini ibu dan janin menghadapi berbagai perubahan fisiologis dan psikologis yang membutuhkan pemantauan serta intervensi yang tepat. Keberhasilan asuhan intranatal yang optimal sangat berpengaruh terhadap keselamatan ibu dan bayi serta berkontribusi dalam menurunkan angka morbiditas dan mortalitas maternal maupun neonatal.

Tenaga keperawatan memiliki peran strategis dalam memberikan asuhan intranatal yang komprehensif, aman, dan berbasis bukti (*evidence-based practice*). Perawat diharapkan mampu melakukan pengkajian secara sistematis, mengidentifikasi masalah keperawatan, merencanakan intervensi yang sesuai, melaksanakan tindakan secara profesional, serta melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap kondisi ibu dan janin selama proses persalinan. Selain itu, perawat juga berperan dalam memberikan dukungan emosional, edukasi kesehatan, serta memastikan kenyamanan dan keselamatan ibu selama persalinan berlangsung.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan maternal menuntut tenaga keperawatan untuk terus meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam memberikan asuhan intranatal. Oleh karena itu, diperlukan sumber referensi yang komprehensif, sistematis, dan mudah dipahami sebagai pedoman dalam praktik klinik maupun pembelajaran akademik. Buku referensi ini disusun untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan menyajikan konsep dasar, prinsip asuhan keperawatan intranatal, serta penerapan proses keperawatan yang terintegrasi dengan standar praktik keperawatan maternitas.

B. Pemantauan Kemajuan Persalinan

Pemantauan kemajuan persalinan merupakan proses pengamatan secara sistematis terhadap kondisi ibu dan janin selama proses persalinan untuk menilai apakah persalinan berlangsung secara normal atau mengalami penyimpangan. Pemantauan ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini adanya kelainan atau

komplikasi sehingga intervensi yang tepat dapat segera dilakukan guna mencegah risiko terhadap ibu dan bayi (World Health Organization, 2020).

Kemajuan persalinan dinilai berdasarkan perubahan fisiologis yang terjadi pada ibu, khususnya dilatasi serviks, penurunan bagian terendah janin, serta kekuatan dan frekuensi kontraksi uterus. Selain itu, kondisi kesejahteraan janin juga menjadi bagian penting dalam pemantauan kemajuan persalinan (Lowdermilk, Deitra Leonard et al., 2016). Pemantauan yang tepat dan berkesinambungan merupakan komponen utama dalam asuhan persalinan yang aman dan berkualitas (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

1. Tujuan Pemantauan Kemajuan Persalinan

Pemantauan kemajuan persalinan dilakukan dengan beberapa tujuan utama, yaitu: menilai kemajuan persalinan secara objektif, mengidentifikasi secara dini adanya penyimpangan atau komplikasi selama persalinan, menentukan kebutuhan intervensi yang tepat dan cepat, menilai kesejahteraan ibu dan janin selama proses persalinan serta mengurangi risiko morbiditas dan mortalitas maternal serta neonatal.

Pemantauan yang baik memungkinkan tenaga kesehatan untuk melakukan pengambilan keputusan klinis yang tepat sehingga dapat meningkatkan keselamatan ibu dan bayi (Varney, Helen et al., 2015).

2. Parameter Pemantauan Kemajuan Persalinan

Pemantauan kemajuan persalinan dilakukan melalui beberapa parameter utama yang meliputi kondisi ibu, kondisi janin, serta kemajuan proses persalinan.

a. Parameter Kondisi Ibu

Pemantauan kondisi ibu meliputi:

1) Tanda-tanda vital

Pemantauan tanda vital seperti tekanan darah, nadi, suhu tubuh, dan frekuensi pernapasan dilakukan secara berkala untuk mendeteksi adanya infeksi, perdarahan, atau gangguan sistemik lainnya selama persalinan (Bobak, Irene M. et al., 2005).

2) Kontraksi uterus

Kontraksi uterus dinilai berdasarkan frekuensi, durasi, dan kekuatan kontraksi. Kontraksi yang adekuat sangat penting untuk mendukung pembukaan serviks dan penurunan janin selama proses persalinan (Lowdermilk, Deitra Leonard et al., 2016).

3) Keadaan kandung kemih

Kandung kemih yang penuh dapat menghambat penurunan kepala janin dan memperlambat kemajuan persalinan, sehingga perlu dipantau secara berkala selama proses persalinan berlangsung (Varney, Helen et al., 2015).

4) Kondisi psikologis ibu

Kondisi psikologis ibu seperti kecemasan dan ketegangan dapat memengaruhi efektivitas kontraksi uterus dan kemajuan persalinan. Dukungan emosional dari tenaga kesehatan sangat diperlukan untuk meningkatkan kenyamanan ibu (World Health Organization, 2020).

b. Parameter Kondisi Janin

Pemantauan kondisi janin bertujuan untuk menilai kesejahteraan janin selama persalinan.

Parameter kondisi janin, meliputi:

1) Denyut Jantung Janin (DJJ)

Denyut jantung janin normal berkisar antara 110–160 kali per menit. Pemantauan DJJ dilakukan secara berkala untuk mendeteksi tanda-tanda gawat janin selama proses persalinan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

2) Air Ketuban

Pemantauan air ketuban meliputi warna, jumlah, dan bau air ketuban. Air ketuban berwarna hijau atau bercampur mekonium dapat menunjukkan adanya gangguan kesejahteraan janin (Lowdermilk, Deitra Leonard et al., 2016).

3) Presentasi dan posisi janin

Penilaian presentasi dan posisi janin dilakukan melalui pemeriksaan palpasi abdomen dan pemeriksaan dalam untuk memastikan posisi janin sesuai dengan proses persalinan normal (Varney, Helen et al., 2015).

c. Parameter Kemajuan Persalinan

Kemajuan persalinan dinilai melalui beberapa indikator utama, meliputi:

1) Dilatasi serviks

Dilatasi serviks merupakan indikator utama kemajuan persalinan yang berlangsung secara bertahap dari 0 cm hingga 10 cm sebagai tanda pembukaan lengkap (Bobak, Irene M. et al., 2005).

2) Penurunan bagian terendah janin

Penurunan kepala janin dinilai berdasarkan stasiun kepala terhadap spina ischiadica yang menunjukkan kemajuan perjalanan janin melalui jalan lahir (Varney, Helen et al., 2015).

3) Penipisan serviks (*afesemen*)

Penipisan serviks menunjukkan kesiapan jalan lahir untuk dilalui oleh janin dan merupakan bagian penting dalam proses persalinan (Lowdermilk, Deitra Leonard et al., 2016).

3. Penggunaan Partograf dalam Pemantauan Kemajuan Persalinan

Partograf merupakan alat penting dalam pemantauan kemajuan persalinan yang digunakan untuk mencatat secara sistematis kondisi ibu, janin, dan kemajuan persalinan. Penggunaan partograf membantu tenaga kesehatan dalam mendeteksi secara dini adanya penyimpangan kemajuan persalinan serta mendukung pengambilan keputusan klinis yang tepat (World Health Organization, 2020). Komponen utama partograf meliputi kemajuan persalinan, kondisi janin, dan kondisi ibu yang dicatat secara berkala selama proses persalinan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Partograf digunakan pada semua ibu dalam kala I fase aktif (fase laten tidak dicatat di partograf, tetapi dicatat terpisah seperti KMS ibu hamil atau rekam medik). Pencatatan dilakukan pada persalinan di semua tempat seperti spesialis obgyn, bidan, dokter umum, residen swasta, rumah sakit, dan lain-lain. Pencatatan juga dilakukan secara rutin oleh semua penolong persalinan yang memberikan asuhan kepada ibu selama persalinan dan kelahiran.

Kondisi ibu dan janin yang harus dicatat secara seksama, yaitu: denyut jantung janin: setiap $\frac{1}{2}$ jam, frekuensi dan lamanya kontraksi uterus: setiap $\frac{1}{2}$ jam, nadi: setiap $\frac{1}{2}$ jam, pembukaan serviks: setiap 4 jam, penurunan bagian terendah janin: setiap 4 jam, tekanan darah dan suhu tubuh: setiap 4 jam, serta produksi urin, aseton dan protein: setiap 2-4 jam

Pencatatan kondisi ibu dan janin meliputi:

a. Informasi tentang ibu

- 1) Nama, umur
- 2) Gravida, para, abortus
- 3) Nomor catatan medis/nomor puskesmas
- 4) Tanggal dan waktu mulai dirawat (atau jika di rumah, tanggal dan waktu penolong persalinan mulai merawat ibu)

Bagian awal (atas) partograf dilengkapi secara teliti pada saat memulai asuhan persalinan. Waktu kedatangan (tertulis sebagai "jam") dan perhatikan kemungkinan ibu datang dalam fase laten persalinan. Tidak kalah penting, catat waktu terjadinya pecah ketuban.

b. Kondisi janin

Kolom pertama digunakan untuk mengamati kondisi janin. Yang diamati dari kondisi bayi adalah DJJ, air ketuban dan penyusupan (kepala janin)

1) DJJ

Menilai dan mencatat denyut jantung janin (DJJ) setiap 30 menit (lebih sering jika ada tanda-tanda gawat janin). Tiap kotak menunjukkan waktu 30 menit. Skala angka di sebelah kolom paling kiri menunjukkan DJJ. Catat DJJ

dengan memberi tanda titik pada garis yang sesuai dengan angka yang menunjukkan DJJ. Titik yang satu dengan titik lainnya dihubungkan dengan garis tidak terputus. Kisaran normal DJJ 110-160 x/menit.

2) Warna dan adanya air ketuban

Menilai air ketuban dilakukan bersamaan dengan periksa dalam. Warna air ketuban hanya bisa dinilai jika selaput ketuban telah pecah. Lambang untuk menggambarkan ketuban atau airnya: U : selaput ketuban utuh (belum pecah), J : selaput ketuban telah pecah dan air ketuban jernih, M : selaput ketuban telah pecah dan air ketuban bercampur mekonium, D : selaput ketuban telah pecah dan air ketuban bercampur darah, K : selaput ketuban telah pecah dan air ketuban kering (tidak mengalir lagi).

Mekonium dalam air ketuban tidak selalu berarti gawat janin. Merupakan indikasi gawat janin jika juga disertai DJJ di luar rentang nilai normal.

3) Penyusupan (molase) tulang kepala

Penyusupan tulang kepala merupakan indikasi penting seberapa jauh janin dapat menyesuaikan dengan tulang panggul ibu. Semakin besar penyusupan semakin besar kemungkinan disporposi kepal panggul. Lambang yang digunakan: 0: tulang –tulang kepala janin terpisah, sutura mudah dipalpasi, 1: tulang-tulang kepa janin sudah saling bersentuhan, 2: tulang-tulang kepala janin saling tumpang tindih tapi masih bisa dipisahkan, 3: tulang-tulang kepala janin saling tumpang tindih dan tidak dapat dipisahkan.

c. Kemajuan persalinan

Kolom kedua untuk mengawasi kemajuan persalinan yang meliputi: pembukaan serviks, penurunan bagian terbawah janin, garis waspada dan garis bertindak dan waktu.

1) Pembukaan serviks

Angka pada kolom kiri 0-10 menggambarkan pembukaan serviks. Menggunakan tanda X pada titik silang antara angka yang sesuai dengan temuan pertama pembukaan serviks pada fase aktif dengan garis waspada. Tanda X dihubungkan dengan garis lurus tidak terputus.

2) Penurunan bagian terbawah Janin

Tulisan “turunnya kepala” dan garis tidak terputus dari 0-5 pada sisi yang sama dengan angka pembukaan serviks. Berikan tanda “●” pada waktu yang sesuai dan hubungkan dengan garis lurus.

Contoh:

Jam 17.00 penurunan kepala 3/5

Jam 21.00 penurunan kepala 1/5.

Kedua tanda "●" dihubungkan dengan garis tidak terputus

Jika pembukaan serviks mengarah ke sebelah kanan garis waspada, maka waspadai kemungkinan adanya penyulit persalinaan. Jika persalinaan telah berada di sebelah kanan garis bertindak yang sejajar dengan garis waspada maka perlu segera dilakukan tindakan penyelesaian persalinaan. Siapkan untuk dirujuk.

3) Jam dan Waktu

Waktu berada dibagian bawah kolom terdiri atas waktu mulainya fase aktif persalinaan dan waktu aktual saat pemeriksaan. Waktu mulainya fase aktif persalinaan diberi angka 1-16, setiap kotak: 1 jam yang digunakan untuk menentukan lamanya proses persalinaan telah berlangsung. Waktu aktual saat pemeriksaan merupakan kotak kosong di bawahnya yang harus diisi dengan waktu yang sebenarnya saat kita melakukan pemeriksaan.

d. Kontraksi uterus

Terdapat lima kotak mendatar untuk kontraksi. Pemeriksaan dilakukan setiap 30 menit, raba dan catat jumlah dan durasi kontraksi dalam 10 menit. Misal jika dalam 10 menit ada 3 kontraksi yang lamanya 20 detik maka arsirlah angka tiga kebawah dengan warna arsiran yang sesuai untuk menggambarkan kontraksi 20 detik (arsiran paling muda warnanya).

e. Obat-obatan dan cairan yang diberikan

Catat obat dan cairan yang diberikan di kolom yang sesuai. Untuk oksitosin dicantumkan jumlah tetesan dan unit yang diberikan.

f. Kondisi ibu

Catat obat dan cairan yang diberikan di kolom yang sesuai. Untuk oksitosin dicantumkan jumlah tetesan dan unit yang diberikan.

g. Volume urin, protein dan aseton

Lakukan tiap 2 jam jika memungkinkan

h. Data lain yang harus dilengkapi dari partograf, adalah: Data atau informasi umum, Kala I, Kala II, Kala III, Kala IV dan Bayi Baru Lahir yang diisi dengan tanda centang (✓) dan diisi titik yang disediakan.

PARTOGRAF

No. Register Nama Ibu : Umur : G. P. A.
No. Puskesmas Tanggal : Jam : Alamat :
Ketuban pecah Sejak jam mules sejak jam

Denyut Jantung Janin (/menit)	200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80	
Air ketuban Penyusupan		
Pembukaan serviks (cm) beri tanda x Tunainya kepala beri tanda o	Sentimeter (Cm) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0	
Kontraksi tiap 0 Menit	< 20 4 20-40 3 > 40 2 (dok) 1	
Oksitosin U/L tetes/menit		
Obat dan Cairan IV		
Nadi	180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60	
Tekanan darah		
Suhu °C		
Urin { Protein Aseton Volume		

CATATAN PERSALINAN

1. Tanggal :
2. Nama bidan :
3. Tempat Persalinan :
☐ Rumah Ibu ☐ Puskesmas
☐ Polindes ☐ Rumah Sakit
☐ Klinik Swasta ☐ Lainnya :
4. Alamat tempat persalinan :
5. Catatan : ☐ rujuk, kala : I / II / III / IV
6. Alasan merujuk :
7. Tempat rujukan :
8. Pendamping pada saat merujuk :
☐ Bidan ☐ Teman
☐ Suami ☐ Dukun
☐ Keluarga ☐ Tidak ada

KALA I

9. Partogram melewati garis waspada : Y / T
10. Masalah lain, sebutkan :
11. Penatalaksanaan masalah Tsb :
12. Hasilnya :

KALA II

13. Episiotomi :
☐ Ya, Indikasi
☐ Tidak
14. Pendamping pada saat persalinan
☐ Suami ☐ Teman ☐ Tidak ada
☐ Keluarga ☐ Dukun
15. Gawat Janin :
☐ Ya, tindakan yang dilakukan
a.
b.
c.
☐ Tidak
16. Distosia bahu :
☐ Ya, tindakan yang dilakukan
a.
b.
c.
☐ Tidak
17. Masalah lain, sebutkan :
18. Penatalaksanaan masalah tersebut :
19. Hasilnya :

KALA III

20. Lama kala III :menit
21. Pemberian Oksitosin 10 U Im ?
☐ Ya, waktu : menit sesudah persalinan
☐ Tidak, alasan
22. Pemberian ulang Oksitosin (2x) ?
☐ Ya, alasan
☐ Tidak
23. Penegangan tali pusat terkendali ?
☐ Ya,
☐ Tidak, alasan

PEMANTAUAN PERSALINAN KALA IV

Jam Ke	Waktu	Tekanan darah	Nadi	Tinggi Fundus Uteri	Kontraksi Uterus	Kandung Kemih	Perdarahan
1							
2							

Masalah kala IV :

Penatalaksanaan masalah tersebut :

Hasilnya :

24. Masase fundus uteri ?
☐ Ya,
☐ Tidak, alasan
25. Plasenta lahir lengkap (*intact*) Ya / Tidak
 Jika tidak lengkap, tindakan yang dilakukan :
a.
b.
26. Plasenta tidak lahir > 30 menit : Ya / Tidak
☐ Ya, tindakan :
a.
b.
c.
27. Laserasi :
☐ Ya, dimana
☐ Tidak.
28. Jika laserasi perineum, derajat : 1 / 2 / 3 / 4
 Tindakan :
☐ Penjahitan, dengan / tanpa anestesi
☐ Tidak dijahit, alasan
29. Atoni uteri :
☐ Ya, tindakan
a.
b.
c.
☐ Tidak
30. Jumlah perdarahan : ml
31. Masalah lain, sebutkan
32. Penatalaksanaan masalah tersebut :
33. Hasilnya :

BAYI BARU LAHIR :

34. Berat badangram
35. Panjang cm
36. Jenis kelamin : L / P
37. Penilaian bayi baru lahir : baik / ada penyulit
38. Bayi lahir :
☐ Normal, tindakan :
☐ mengeringkan
☐ menghangatkan
☐ rangsang taktil
☐ bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu
☐ Asfiksia ringan/pucat/biru/lemas, tindakan :
☐ mengeringkan ☐ bebaskan jalan napas
☐ rangsang taktil ☐ menghangatkan
☐ bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu
☐ lain - lain sebutkan
- ☐ Cacat bawaan, sebutkan :
- ☐ Hipotermi, tindakan :
a.
b.
c.
39. Pemberian ASI
☐ Ya, waktu :jam setelah bayi lahir
☐ Tidak, alasan
40. Masalah lain,sebutkan :

Hasilnya :

4. Faktor yang Memengaruhi Kemajuan Persalinan

Kemajuan persalinan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang dikenal sebagai 6P, yaitu *Power* (kekuatan), *Passage* (jalan lahir), *Passenger* (janin), *Position* (posisi ibu), dan *Psyche* (psikologis ibu). Kelima faktor ini saling berinteraksi dan menentukan kelancaran proses persalinan dari kala I hingga kala IV.

a. *Power* (Kekuatan)

Power merupakan kekuatan yang mendorong janin keluar dari rahim, terdiri dari kontraksi uterus dan tenaga meneran ibu. Kontraksi uterus yang efektif ditandai dengan frekuensi teratur, durasi cukup (40–60 detik), dan intensitas kuat. Kontraksi yang tidak adekuat dapat menyebabkan persalinan berlangsung lama atau mengalami hambatan. Selain kontraksi uterus, tenaga meneran ibu pada kala II juga berperan penting dalam membantu pengeluaran janin. Gangguan pada faktor *power* dapat berupa inersia uteri (kontraksi lemah), kontraksi tidak terkoordinasi, kelelahan ibu, dan ketidakmampuan ibu meneran secara efektif

b. *Passage* (Jalan Lahir)

Passage mencakup jalan lahir yang terdiri dari panggul tulang (pelvis) dan jaringan lunak seperti serviks, vagina, dan dasar panggul. Bentuk dan ukuran panggul sangat menentukan apakah janin dapat melewati jalan lahir. Panggul yang sempit atau abnormal dapat menyebabkan hambatan persalinan (distosia). Selain itu, elastisitas jaringan lunak dan kemampuan serviks membuka (dilatasi) juga mempengaruhi kemajuan persalinan. Beberapa faktor yang mempengaruhi *passage*, yaitu bentuk panggul ibu, kelainan panggul, tumor atau massa pada jalan lahir dan kekakuan serviks.

c. *Passenger* (Janin)

Passenger adalah janin dan plasenta yang akan dilahirkan. Ukuran, posisi, presentasi, dan sikap janin sangat menentukan kelancaran persalinan. Janin dengan berat badan besar (*makrosomia*), presentasi abnormal (misalnya presentasi bokong), atau posisi janin yang tidak sesuai dapat memperlambat kemajuan persalinan. Faktor *passenger* meliputi ukuran dan berat janin, presentasi janin (kepala, bokong, dll.), posisi janin (oksiput anterior/posterior), sikap janin (fleksi atau ekstensi kepala) dan jumlah air ketuban.

d. *Position* (Posisi ibu)

Position mengacu pada posisi ibu selama proses persalinan. Posisi yang tepat dapat mempercepat kemajuan persalinan dengan memanfaatkan gaya gravitasi dan meningkatkan efektivitas kontraksi. Posisi ibu yang dianjurkan antara lain posisi tegak (berdiri, berjalan), posisi duduk, posisi miring kiri dan

posisi jongkok. Posisi terlentang dalam waktu lama dapat menghambat aliran darah ke uterus dan memperlambat kemajuan persalinan.

e. *Psyche* (Psikologis ibu)

Psyche merupakan kondisi emosional dan psikologis ibu selama persalinan. Rasa takut, cemas, dan stres dapat meningkatkan hormon katekolamin yang dapat menghambat kontraksi uterus dan memperlambat kemajuan persalinan. Dukungan emosional dari tenaga kesehatan dan keluarga sangat penting untuk menjaga kondisi psikologis ibu tetap stabil. Lingkungan persalinan yang nyaman juga membantu meningkatkan rasa percaya diri ibu. Faktor psikologis yang berpengaruh, yaitu tingkat kecemasan, pengalaman persalinan sebelumnya, dukungan keluarga serta lingkungan persalinan.

f. *Penolong* (*psycian*)

Peran dari penolong persalinan adalah mengantisipasi dan menangani komplikasi yang mungkin terjadi pada ibu dan janin, dalam hal ini tergantung dari kemampuan dan kesiapan penolong dalam menghadapi proses persalinan.

B. Dukungan Nonfarmakologis

Dukungan nonfarmakologis pada persalinan merupakan upaya yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk membantu ibu mengatasi nyeri, kecemasan, dan ketidaknyamanan selama proses persalinan tanpa menggunakan obat-obatan. Pendekatan ini menekankan pada intervensi alami yang bertujuan meningkatkan kenyamanan, memperlancar proses persalinan, serta meningkatkan kepuasan ibu terhadap pengalaman persalinannya (World Health Organization, 2020).

Dukungan nonfarmakologis merupakan bagian penting dari asuhan persalinan yang berfokus pada ibu (*woman-centered care*). Metode ini dapat membantu mengurangi persepsi nyeri, meningkatkan kemampuan coping ibu, serta mendukung kemajuan persalinan secara fisiologis (Lowdermilk, Deitra Leonard et al., 2016).

1. Tujuan Dukungan Nonfarmakologis

Pemberian dukungan nonfarmakologis selama persalinan memiliki beberapa tujuan, antara lain: mengurangi intensitas nyeri persalinan secara alami, mengurangi kecemasan dan ketegangan ibu, meningkatkan rasa percaya diri ibu dalam menghadapi persalinan, meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan ibu, mendukung kemajuan persalinan secara fisiologis, dan mengurangi kebutuhan intervensi farmakologis atau tindakan invasif.

Dukungan nonfarmakologis yang adekuat terbukti dapat meningkatkan kepuasan ibu terhadap pengalaman persalinan serta menurunkan risiko

komplikasi akibat stres dan ketegangan selama persalinan (Varney, Helen et al., 2015).

2. Bentuk Dukungan Nonfarmakologis pada Persalinan

Terdapat berbagai bentuk dukungan nonfarmakologis yang dapat diberikan kepada ibu selama persalinan.

a. Dukungan emosional

Dukungan emosional merupakan salah satu bentuk dukungan yang sangat penting selama persalinan. Dukungan ini meliputi pemberian rasa aman, empati, dan perhatian kepada ibu selama proses persalinan berlangsung.

Bentuk dukungan emosional meliputi memberikan kata-kata penyemangat kepada ibu, mendengarkan keluhan dan perasaan ibu, memberikan rasa aman dan nyaman, dan menghadirkan pendamping persalinan seperti suami atau anggota keluarga.

Kehadiran pendamping persalinan terbukti dapat menurunkan kecemasan ibu, mempercepat proses persalinan, serta meningkatkan pengalaman persalinan yang positif (World Health Organization, 2020).

b. Teknik pernapasan (*breathing technique*)

Teknik pernapasan merupakan metode yang digunakan untuk membantu ibu mengontrol nyeri dan meningkatkan relaksasi selama kontraksi uterus. Jenis teknik pernapasan meliputi pernapasan dalam (*deep breathing*), pernapasan lambat (*slow breathing*), pernapasan dangkal (*shallow breathing*). Teknik pernapasan yang benar membantu meningkatkan suplai oksigen kepada ibu dan janin serta membantu ibu tetap fokus selama kontraksi berlangsung (Lowdermilk, Deitra Leonard et al., 2016)

c. Relaksasi

Relaksasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengurangi ketegangan otot dan kecemasan selama persalinan. Relaksasi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti meditasi ringan, visualisasi, atau mendengarkan musik yang menenangkan.

Teknik relaksasi membantu menurunkan produksi hormon stres dan meningkatkan pelepasan endorfin yang berperan sebagai analgesik alami tubuh (Varney, Helen et al., 2015).

d. Massage (pijat)

Massage atau pijatan ringan pada bagian tubuh tertentu dapat membantu mengurangi nyeri persalinan serta meningkatkan relaksasi ibu. Area yang sering dilakukan pijatan meliputi punggung bagian bawah, bahu, pinggang, dan paha. Massage membantu meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi

ketegangan otot, serta menstimulasi pelepasan hormon endorfin yang berfungsi sebagai pereda nyeri alami (Lowdermilk, Deitra Leonard et al., 2016).

e. Perubahan posisi dan mobilisasi

Perubahan posisi dan mobilisasi selama persalinan membantu mempercepat penurunan janin serta meningkatkan kenyamanan ibu. Beberapa posisi yang dianjurkan meliputi posisi duduk, posisi berdiri, posisi berjalan, posisi jongkok dan posisi miring kiri. Mobilisasi selama persalinan terbukti dapat mempercepat kemajuan persalinan dan mengurangi intensitas nyeri dibandingkan dengan posisi terlentang (World Health Organization, 2020).

f. Kompres hangat atau dingin

Pemberian kompres hangat atau dingin merupakan metode sederhana untuk mengurangi nyeri selama persalinan. Manfaat kompres hangat, adalah mengurangi ketegangan otot, meningkatkan aliran darah dan memberikan rasa nyaman. Kompres dingin dapat digunakan untuk mengurangi pembengkakan dan memberikan efek analgesik lokal (Varney, Helen et al., 2015).

g. Hidroterapi

Hidroterapi merupakan metode penggunaan air, seperti mandi air hangat atau berendam, untuk mengurangi nyeri persalinan dan meningkatkan relaksasi ibu. Air hangat membantu mengurangi tekanan pada otot, meningkatkan relaksasi, serta mengurangi persepsi nyeri selama kontraksi (World Health Organization, 2020)

h. Distraksi

Distraksi merupakan teknik mengalihkan perhatian ibu dari rasa nyeri selama persalinan. Bentuk distraksi meliputi mendengarkan musik, berbicara dengan pendamping, melakukan aktivitas ringan, fokus pada objek tertentu dan membaca buku. Distraksi membantu mengurangi persepsi nyeri dengan mengalihkan fokus ibu dari kontraksi yang dirasakan (Lowdermilk, Deitra Leonard et al., 2016).

3. Peran Perawat dalam Pemberian Dukungan Nonfarmakologis

Perawat memiliki peran penting dalam memberikan dukungan nonfarmakologis selama proses persalinan. Peran tersebut meliputi mengkaji tingkat nyeri dan kecemasan ibu, memberikan edukasi tentang teknik pengurangan nyeri nonfarmakologis, membantu ibu dalam melakukan teknik pernapasan dan relaksasi, memberikan dukungan emosional secara berkesinambungan, memfasilitasi perubahan posisi selama persalinan, dan melibatkan keluarga atau pendamping dalam proses persalinan.

Peran perawat dalam pemberian dukungan nonfarmakologis sangat penting untuk meningkatkan kenyamanan ibu serta mendukung proses persalinan yang aman dan fisiologis (Persatuan Perawat Nasional Indonesia, 2017).

C. Manajemen Nyeri Persalinan

1. Pengertian Manajemen Nyeri Persalinan

Nyeri persalinan merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang terjadi akibat kontraksi uterus, dilatasi serviks, serta peregangan jaringan jalan lahir selama proses persalinan. Nyeri ini bersifat fisiologis, namun dapat menimbulkan ketidaknyamanan yang signifikan bagi ibu sehingga memerlukan penanganan yang tepat (Lowdermilk, Deitra Leonard et al., 2016).

Manajemen nyeri persalinan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengurangi intensitas nyeri serta meningkatkan kenyamanan ibu selama proses persalinan. Pendekatan manajemen nyeri dapat dilakukan secara farmakologis maupun nonfarmakologis sesuai dengan kondisi ibu, tahap persalinan, serta ketersediaan fasilitas kesehatan (World Health Organization, 2020).

Pengelolaan nyeri yang efektif sangat penting untuk mendukung proses persalinan yang aman dan fisiologis serta meningkatkan pengalaman persalinan yang positif bagi ibu (Varney, Helen et al., 2015).

2. Fisiologi Nyeri Persalinan

Nyeri persalinan terjadi akibat rangsangan saraf yang berasal dari kontraksi uterus dan perubahan pada serviks serta jaringan jalan lahir. Pada kala I persalinan, nyeri terutama disebabkan oleh dilatasi serviks dan kontraksi uterus, sedangkan pada kala II persalinan, nyeri disebabkan oleh peregangan perineum dan tekanan kepala janin pada jaringan sekitarnya (Bobak, Irene M. et al., 2005).

Nyeri pada kala I biasanya bersifat viseral dan dirasakan pada daerah abdomen bawah serta punggung, sedangkan nyeri pada kala II bersifat somatik dan dirasakan pada daerah perineum serta rektum (Lowdermilk, Deitra Leonard et al., 2016).

Respons tubuh terhadap nyeri melibatkan pelepasan hormon stres seperti katekolamin yang dapat memengaruhi kontraksi uterus serta menurunkan aliran darah ke plasenta apabila tidak dikelola dengan baik (World Health Organization, 2020).

3. Faktor yang Memengaruhi Persepsi Nyeri Persalinan

Persepsi nyeri selama persalinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor fisiologis: meliputi kekuatan kontraksi uterus, ukuran janin, dan posisi

janin; faktor psikologis: meliputi kecemasan, ketakutan, serta pengalaman persalinan sebelumnya; faktor sosial dan budaya: persepsi nyeri dipengaruhi oleh nilai budaya dan dukungan keluarga; faktor lingkungan: lingkungan persalinan yang nyaman dapat membantu mengurangi persepsi nyeri. Faktor-faktor tersebut perlu dipertimbangkan dalam menentukan metode manajemen nyeri yang tepat bagi ibu selama persalinan (Varney, Helen et al., 2015).

4. Metode Manajemen Nyeri Persalinan

Manajemen nyeri persalinan dapat dilakukan dengan dua pendekatan utama, yaitu metode nonfarmakologis dan farmakologis.

a. Manajemen Nyeri Persalinan Nonfarmakologis

Metode nonfarmakologis merupakan pendekatan yang dilakukan tanpa menggunakan obat-obatan dan bertujuan meningkatkan relaksasi serta kenyamanan ibu selama persalinan. Beberapa metode nonfarmakologis meliputi:

1) Teknik pernapasan

Teknik pernapasan membantu ibu mengontrol nyeri dengan meningkatkan relaksasi serta meningkatkan suplai oksigen ke jaringan tubuh (Lowdermilk, Deitra Leonard et al., 2016).

2) Relaksasi

Relaksasi membantu menurunkan ketegangan otot serta mengurangi kecemasan selama kontraksi berlangsung (Varney, Helen et al., 2015).

3) Massage

Massage atau pijatan ringan pada punggung atau pinggang dapat membantu mengurangi nyeri dan meningkatkan kenyamanan ibu selama persalinan (Bobak, Irene M. et al., 2005).

4) Perubahan posisi

Perubahan posisi seperti berjalan, duduk, atau posisi miring kiri membantu mempercepat kemajuan persalinan serta mengurangi nyeri (World Health Organization, 2020).

5) Kompres hangat atau dingin

Kompres hangat membantu meningkatkan relaksasi otot, sedangkan kompres dingin membantu mengurangi nyeri lokal (Varney, Helen et al., 2015).

6) Distraksi dan musik terapi

Distraksi melalui musik atau aktivitas ringan membantu mengalihkan perhatian ibu dari rasa nyeri selama persalinan (Lowdermilk, Deitra Leonard et al., 2016).

Metode nonfarmakologis direkomendasikan sebagai pilihan pertama dalam manajemen nyeri persalinan normal karena relatif aman dan minim efek samping (World Health Organization, 2020).

b. Manajemen Nyeri Farmakologis

Metode farmakologis digunakan apabila metode nonfarmakologis tidak memberikan hasil yang optimal atau ketika ibu mengalami nyeri yang berat. Beberapa metode farmakologis meliputi:

1) Analgetik sistemik

Analgesik sistemik diberikan melalui injeksi intravena atau intramuskular untuk mengurangi nyeri persalinan. Jenis analgesik yang sering digunakan meliputi Opioid dan Sedatif ringan. Penggunaan analgesik harus dilakukan dengan pemantauan ketat karena dapat memengaruhi kondisi ibu dan janin (Lowdermilk, Deitra Leonard et al., 2016).

2) Anestesi regional

Anestesi regional merupakan metode pengurangan nyeri dengan menyuntikkan obat anestesi pada daerah tertentu untuk memblokir saraf nyeri. Jenis anestesi regional meliputi Epidural, Spinal dan Kombinasi spinal-epidural. Metode ini efektif dalam mengurangi nyeri persalinan, namun memerlukan tenaga terlatih serta pemantauan ketat terhadap kondisi ibu dan janin (Varney, Helen et al., 2015)

3) Anestesi Lokal

Anestesi lokal digunakan untuk mengurangi nyeri pada daerah perineum, terutama pada tindakan episiotomi atau penjahitan luka (Bobak, Irene M. et al., 2005).

5. Penilaian Nyeri Persalinan

Penilaian nyeri persalinan dilakukan secara subjektif dan objektif menggunakan berbagai skala nyeri.

a. Skala Numerik (*Numerik Rating Scale* /NRS)

Ibu diminta menilai nyeri pada skala 0–10, di mana 0 = tidak nyeri, 1–3 = nyeri ringan, 4–6 = nyeri sedang, 7–10 = nyeri berat. skala ini paling sering digunakan karena sederhana dan mudah dipahami.

b. Skala Visual Verbal (*Visual Analog Scal*/VAS)

Menggunakan garis lurus sepanjang 10 cm. Ujung kiri tidak nyeri dan ujung kanan nyeri sangat berat. Ibu diminta menandai titik sesuai intensitas nyeri yang dirasakan.

c. Skala Verbal (*Verbal Descriptor Scale*/VDS)

Menggunakan deskripsi kata, seperti tidak nyeri, nyeri ringan, nyeri sedang, nyeri berat dan nyeri sangat berat.

d. Skala Wajah (*Wong-Baker Faces Pain Scale*)

Digunakan pada ibu dengan keterbatasan komunikasi atau kesulitan memahami angka, dengan cara menampilkan gambar ekspresi wajah dari senyum hingga menangis, kemudian ibu memilih gambar yang sesuai dengan rasa nyeri.

6. Peran Perawat dalam Manajemen Nyeri Persalinan

Perawat memiliki peran penting dalam manajemen nyeri persalinan melalui: melakukan pengkajian tingkat nyeri ibu secara berkala, memberikan edukasi tentang teknik pengurangan nyeri, memberikan intervensi nonfarmakologis sesuai kebutuhan ibu, melakukan kolaborasi dalam pemberian terapi farmakologis, mengevaluasi efektivitas intervensi yang telah dilakukan, serta memberikan dukungan emosional kepada ibu dan keluarga.

Peran aktif perawat dalam manajemen nyeri persalinan sangat penting untuk meningkatkan kenyamanan ibu serta mendukung proses persalinan yang aman dan fisiologis (World Health Organization, 2020).

D. Tahapan Persalinan

Menurut Sumarah (2013) tahapan persalinan ada 4, yaitu:

1. Kala I

Persalinan kala I adalah pembukaan yang berlangsung antara pembukaan nol sampai pembukaan lengkap, proses ini berlangsung kurang lebih 18-24 jam, yang terbagi menjadi 2 fase yaitu fase laten (8 jam). Pembukaan 0 cm - pembukaan 3 cm, dan fase aktif (7jam). Dari pembukaan serviks 3 cm-10 cm, dalam fase aktif ini masih dibagi menjadi beberapa fase lagi yaitu fase akselerasi, dimana dalam waktu 2 jam pembukaan 3 cm menjadi 4 cm, fase dilatasi maksimal yakni dalam waktu 2 jam pembukaan berlangsung sangat cepat, dari pembukaan 4 cm menjadi 9 cm, dan fase deselerasi dimana pembukaan menjadi lambat kembali. Dalam waktu 2 jam pembukaan 9 cm menjadi 10 cm, kontraksi menjadi lebih kuat dan lebih sering pada fase aktif.

2. Kala II

Persalinan kala II (pengeluaran) adalah di mulai dari pembukaan lengkap (10 cm) sampai bayi lahir. Proses ini berlangsung 2 jam pada primigravida dan 1 jam pada multigravida. Pada kala ini his menjadi lebih kuat dan cepat, kurang lebih 2-3 menit.

3. Kala III

Persalinan kala III (pelepasan uri) dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya plasenta yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Setelah bayi lahir

uterus terasa keras dengan fundus uteri agak ke di atas pusat, beberapa menit kemudian uterus berkontraksi lagi untuk melepaskan plasenta dari dindingnya.

4. Kala IV

Persalinan kala IV (observasi) dimulai dari saat lahirnya plasenta sampai 2 jam post partum.

E. Kesiapsiagaan Komplikasi

1. Pengertian Kesiapsiagaan Komplikasi

Kesiapsiagaan komplikasi pada persalinan merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk mengantisipasi, mengenali secara dini, dan menangani komplikasi yang mungkin terjadi selama proses persalinan. Kesiapsiagaan ini meliputi kesiapan tenaga kesehatan, peralatan, obat-obatan, serta sistem rujukan yang efektif untuk memastikan keselamatan ibu dan bayi (World Health Organization, 2020).

Komplikasi persalinan dapat terjadi secara tiba-tiba dan memerlukan penanganan segera. Oleh karena itu, kesiapsiagaan yang baik sangat penting untuk mencegah terjadinya morbiditas dan mortalitas maternal maupun neonatal. Kesiapsiagaan ini mencakup pengenalan tanda bahaya, kesiapan dalam melakukan tindakan awal, serta koordinasi dengan fasilitas kesehatan yang lebih lengkap apabila diperlukan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

2. Tujuan Kesiapsiagaan Komplikasi Persalinan

Kesiapsiagaan komplikasi persalinan memiliki beberapa tujuan utama, yaitu mengidentifikasi secara dini adanya komplikasi selama persalinan, menurunkan risiko keterlambatan dalam penanganan komplikasi, meningkatkan keselamatan ibu dan bayi selama persalinan, menjamin tersedianya peralatan dan tenaga kesehatan yang siap menangani kegawatdaruratan, serta mendukung sistem rujukan yang cepat dan efektif.

Kesiapsiagaan yang optimal berperan penting dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi yang sebagian besar disebabkan oleh keterlambatan dalam penanganan komplikasi persalinan (World Health Organization, 2020).

3. Jenis Komplikasi yang Perlu Diantisipasi

Beberapa komplikasi yang sering terjadi selama persalinan dan memerlukan kesiapsiagaan meliputi:

a. Perdarahan Post Partum (*Haemorrhagic Post Partum*)

Perdarahan merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu selama persalinan. Perdarahan dapat terjadi akibat atonia uteri, robekan jalan lahir, atau retensio plasenta. Tanda-tanda perdarahan meliputi perdarahan yang berlebihan >500 ml, tekanan darah menurun, nadi cepat dan lemah serta pucat

dan lemah. Penanganan awal yang cepat sangat penting untuk mencegah syok hipovolemik pada ibu (Varney, Helen et al., 2015).

b. Persalinan Lama (*Prolonged Labor*)

Persalinan lama terjadi apabila kemajuan persalinan tidak sesuai dengan kurva normal pada partograf. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko infeksi, kelelahan ibu, serta komplikasi pada janin. Faktor penyebab persalinan lama meliputi kontraksi uterus tidak adekuat, disproporsi kepala dan panggul serta posisi janin abnormal. Pemantauan menggunakan partograf membantu mendeteksi secara dini terjadinya persalinan lama (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

c. Gawat Janin

Gawat janin merupakan kondisi di mana janin mengalami gangguan kesejahteraan selama persalinan yang dapat ditandai dengan perubahan denyut jantung janin. Tanda-tanda gawat janin meliputi denyut jantung janin kurang dari 120 atau lebih dari 160 kali per menit, air ketuban bercampur mekonium, penurunan gerakan janin. Deteksi dini gawat janin sangat penting untuk mencegah asfiksia neonatal (Lowdermilk, Deitra Leonard et al., 2016).

d. Infeksi Post Partum

Infeksi selama dan setelah persalinan dapat terjadi akibat ketuban pecah lama atau prosedur yang tidak aseptik. Tanda-tanda infeksi meliputi demam, bau tidak normal pada air ketuban, nyeri pada daerah uterus dan eningkatan denyut jantung ibu dan janin. Pencegahan infeksi dilakukan dengan menjaga teknik aseptik selama tindakan persalinan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

4. Tanda dan Bahaya Persalinan

Pengenalan tanda bahaya merupakan bagian penting dari kesiapsiagaan komplikasi. Tanda bahaya selama persalinan meliputi perdarahan hebat, ketuban pecah dengan warna hijau pekat, tidak adanya kemajuan persalinan, tekanan darah meningkat, kejang, demam tinggi dan denyut jantung janin abnormal. Apabila ditemukan tanda bahaya, tenaga kesehatan harus segera melakukan tindakan penanganan awal dan merujuk ibu ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap (World Health Organization, 2020).

5. Persiapan dalam Menghadapi Komplikasi Persalinan

Kesiapsiagaan menghadapi komplikasi memerlukan beberapa persiapan penting.

a. Kesiapan Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan harus memiliki kompetensi dalam mengenali tanda bahaya, melakukan tindakan kegawatdaruratan, melakukan resusitasi ibu dan bayi,

serta melakukan rujukan tepat waktu. Pelatihan berkala sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dalam menangani komplikasi persalinan (World Health Organization, 2020).

b. Kesiapan Peralatan

Peralatan yang harus tersedia meliputi set alat persalinan steril, set alat resusitasi bayi, set peralatan infus, oksigen serta peralatan pemantauan tanda vital. Ketersediaan peralatan yang lengkap membantu meningkatkan keberhasilan penanganan komplikasi persalinan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

c. Kesiapan Obat-obatan

Obat-obatan yang harus tersedia antara lain oksitosin, magnesium sulfat, antibiotik, dan cairan infus. Ketersediaan obat-obatan emergensi merupakan bagian penting dalam manajemen komplikasi persalinan (Varney, Helen et al., 2015).

d. Sistem Rujukan

Sistem rujukan yang efektif diperlukan untuk memastikan ibu dengan komplikasi dapat memperoleh penanganan yang tepat waktu. Komponen sistem rujukan meliputi komunikasi yang jelas antar fasilitas, transportasi yang tersedia, dokumentasi lengkap serta pendampingan selama rujukan. Sistem rujukan yang baik dapat menurunkan risiko kematian ibu akibat keterlambatan penanganan komplikasi (World Health Organization, 2020).

e. Peran Perawat dalam Kesiapsiagaan Komplikasi

6. Peran Perawat dalam Kesiapsiagaan Komplikasi

Perawat memiliki peran penting dalam kesiapsiagaan komplikasi selama persalinan, antara lain melakukan pengkajian kondisi ibu dan janin secara berkala, mengidentifikasi tanda bahaya secara dini, menyiapkan peralatan dan obat-obatan yang diperlukan, memberikan tindakan awal kegawatdaruratan, melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, mendokumentasikan setiap tindakan secara akurat serta mengedukasi ibu dan keluarga mengenai tanda bahaya persalinan. Peran aktif perawat dalam kesiapsiagaan komplikasi sangat penting dalam mendukung keselamatan ibu dan bayi selama proses persalinan (Persatuan Perawat Nasional Indonesia, 2017).

F. Keselamatan Ibu dan Janin

Keselamatan ibu dan janin merupakan kondisi di mana ibu dan janin terlindungi dari risiko cedera, komplikasi, maupun kematian selama proses persalinan melalui pemberian asuhan yang aman, tepat, dan berkualitas. Keselamatan ibu dan janin menjadi prioritas utama dalam pelayanan intranatal

karena periode persalinan merupakan fase kritis yang memerlukan pemantauan ketat serta intervensi yang cepat apabila terjadi penyimpangan (World Health Organization, 2020).

Upaya keselamatan ibu dan janin dilakukan melalui pemantauan kondisi ibu dan janin secara berkesinambungan, penggunaan prosedur yang sesuai standar, serta penerapan prinsip keselamatan pasien dalam setiap tindakan yang dilakukan selama proses persalinan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Keselamatan ibu dan janin tidak hanya berfokus pada pencegahan komplikasi, tetapi juga mencakup upaya mempertahankan kesejahteraan ibu dan janin selama seluruh tahapan persalinan (Lowdermilk, Deitra Leonard et al., 2016).

Tujuan utama keselamatan ibu dan janin selama persalinan, meliputi: mencegah terjadinya komplikasi selama persalinan, mengurangi risiko morbiditas dan mortalitas maternal serta neonatal, menjamin kesejahteraan ibu dan janin selama proses persalinan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan maternal, serta meningkatkan pengalaman persalinan yang aman dan nyaman bagi ibu. Penerapan prinsip keselamatan ibu dan janin merupakan strategi penting dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi yang masih menjadi tantangan dalam pelayanan kesehatan maternal (World Health Organization, 2020).

Keselamatan ibu dan janin dalam persalinan didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu:

1. Pemantauan Kondisi Ibu dan Janin secara Berkala

Pemantauan berkala terhadap kondisi ibu dan janin sangat penting untuk mendeteksi adanya penyimpangan selama persalinan. Pemantauan ini meliputi pemeriksaan tanda vital ibu, kontraksi uterus, denyut jantung janin, serta kemajuan persalinan menggunakan partograf (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Pemantauan yang teratur memungkinkan deteksi dini terhadap komplikasi seperti gawat janin, perdarahan, atau persalinan lama (Varney, Helen et al., 2015).

2. Pencegahan Infeksi

Pencegahan infeksi merupakan komponen penting dalam menjaga keselamatan ibu dan janin selama persalinan. Langkah-langkah pencegahan infeksi meliputi mencuci tangan sebelum dan sesudah tindakan, menggunakan alat steril, menjaga kebersihan lingkungan persalinan dan menggunakan teknik aseptik selama prosedur. Penerapan prinsip pencegahan infeksi dapat menurunkan risiko infeksi maternal maupun neonatal secara signifikan (World Health Organization, 2020).

3. Penanganan Komplikasi secara Dini

Penanganan komplikasi secara cepat dan tepat sangat penting untuk menjaga keselamatan ibu dan janin. Beberapa komplikasi yang perlu diantisipasi meliputi perdarahan, gawat janin, persalinan lama, preeklampsia dan infeksi. Deteksi dini komplikasi memungkinkan tindakan segera yang dapat mencegah terjadinya kondisi yang lebih serius (Lowdermilk, Deitra Leonard et al., 2016)

4. Penerapan Standar Pelayanan Persalinan

Standar pelayanan persalinan meliputi penggunaan prosedur yang telah ditetapkan sesuai pedoman nasional maupun internasional. Penerapan standar pelayanan meliputi penggunaan partograf, pemantauan tanda vital, dokumentasi tindakan secara lengkap, dan pemberian asuhan sesuai protokol. Penerapan standar pelayanan yang konsisten dapat meningkatkan keselamatan ibu dan janin selama persalinan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Upaya untuk peningkatan keselamatan ibu dan janin melibatkan berbagai aspek pelayanan kesehatan. Aspek tersebut antara lain pemantauan kesejahteraan janin, manajemen nyeri yang tepat, dukungan emosional dan psikologis, serta sistem rujukan yang efektif. Pemantauan kesejahteraan janin dilakukan melalui pemeriksaan denyut jantung janin secara berkala serta observasi terhadap warna air ketuban dan gerakan janin. Manajemen nyeri yang efektif membantu meningkatkan kenyamanan ibu serta mengurangi stres yang dapat memengaruhi kontraksi uterus dan kesejahteraan janin. Dukungan emosional dari tenaga kesehatan maupun keluarga dapat membantu mengurangi kecemasan ibu selama persalinan. Dukungan ini dapat meningkatkan kepercayaan diri ibu serta membantu proses persalinan berlangsung lebih lancar. Sistem rujukan yang efektif diperlukan apabila terjadi komplikasi yang tidak dapat ditangani di fasilitas pelayanan kesehatan awal. Komponen sistem rujukan meliputi komunikasi antar fasilitas, transportasi yang memadai, dokumentasi yang lengkap dan pendampingan selama proses rujukan. Sistem rujukan yang cepat dan tepat dapat menyelamatkan ibu dan janin dari kondisi kegawatdaruratan

G. Asuhan Keperawatan Intra Natal

Periode intranatal atau sering disebut sebagai persalinan, adalah suatu proses keluarnya fetus sebagai hasil konsepsi dan plasenta dari uterus, ditandai dengan peningkatan aktivitas otot rahim (frekuensi dan intensitas kontraksi) yang menyebabkan penipisan dan pembukaan serviks serta keluarnya lendir darah (*bloody show*) dari vagina (Manurung, 2011).

KALA I.

1. Pengkajian

a. Keluhan

Anda kaji alasan klien datang ke rumah sakit. Alasannya dapat berupa keluar darah bercampur lendir (bloody show), keluar air-air dari kemaluan (air ketuban), nyeri pada daerah pinggang menjalar ke perut/kontraksi (mulas), nyeri makin sering dan teratur.

b. Pengkajian riwayat obstetrik

Kaji kembali HPHT, taksiran persalinan, usia kehamilan sekarang. Kaji riwayat kehamilan masa lalu, jenis persalinan lalu, penolong persalinan lalu, kondisi bayi saat lahir. Kaji riwayat nifas lalu, masalah setelah melahirkan, pemberian ASI dan kontrasepsi.

c. Pemeriksaan fisik

1) Keadaan umum, kesadaran, tanda-tanda vital (TTV) meliputi tekanan darah, nadi, suhu, respirasi, tinggi badan, dan berat badan. 2) Kaji tanda-tanda in partu seperti keluar darah campur lendir, sejak kapan dirasakan kontraksi dengan intensitas dan frekuensi yang meningkat, waktu keluarnya cairan dari kemaluan, jernih atau keruh, warna, dan jumlahnya. 3) Kaji TFU, Leopold I, II, III, dan IV (lihat kembali modul 2 atau pedoman praktikum pemeriksaan fisik ibu hamil). 4) Kaji kontraksi uterus ibu. Lakukan pemeriksaan dalam untuk mengetahui derajat dilatasi (pembukaan) dan pendataran serviks, apakah selaput ketuban masih utuh atau tidak, posisi bagian terendah janin. 5) Auskultasi DJJ.

2. Diagnosa Keperawatan

D.0079 Nyeri melahirkan

3. Intervensi Keperawatan

Tabel 4.1 Intervensi Keperawatan

Diagnosa Keperawatan	Tujuan dan Kriteria Hasil	Intervensi Keperawatan
Nyeri melahirkan berhubungan dengan dilatasi serviks	• Koping terhadap ketidaknyamanan meningkat • Nyeri dengan kontraksi meningkat • Frekuensi, periode dan intensitas kontraksi uterus membaik	Manajemen Nyeri <i>Observasi</i> • Identifikasi karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri • Identifikasi skala nyeri • Identifikasi respons nyeri non verbal <i>Terapeutik</i>

	• Tekanan darah membaik	• Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan • Berikan teknik nonfarmakologi untuk mengurangi nyeri <i>Edukasi</i> • Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri • Ajarkan teknik nonfarmakologi untuk mengurangi rasa nyeri
--	---	--

KALA II

1. Pengkajian

- Periksa TTV (TD, nadi, suhu, respirasi), tanda tanda persalinan kala II dimulai sejak pukul, evaluasi terhadap tanda–tanda persalinan kala II (dorongan meneran, tekanan ke anus, perineum menonjol, dan vulva membuka).
- Periksa kemajuan persalinan VT (status portio, pembukaan serviks, status selaput amnion, warna air ketuban, penurunan presentasi ke rongga panggul, kontraksi meliputi intensitas, durasi frekuensi, relaksasi).
- DJJ, vesika urinaria (penuh/ kosong).
- Respon perilaku (tingkat kecemasan, skala nyeri, kelelahan, keinginan mendedan, sikap ibu saat masuk kala II, intensitas nyeri).
- Bayi Baru Lahir : Nilai skor APGAR dinilai pada menit pertama kelahiran dan diulang pada menit kelima. A (Appearance/warna kulit), P (Pulse/denyut jantung), G (Grimace/respon refleks), A (Activity/tonus otot), R (Respiration/pernapasan). Nilai kelima variabel tersebut dijumlahkan. Interpretasi hasil yang diperoleh: a. Bila jumlah skor antar 7–10 pada menit pertama, bayi dianggap normal. b. Bila jumlah skor antara 4–6 pada menit pertama, bayi memerlukan tindakan medis segera seperti pengisapan lendir dengan suction atau pemberian oksigen untuk membantu bernafas.

2. Diagnosa Keperawatan

- D.0079 Nyeri Melahirkan
- D.0137 Risiko Cedera Ibu
- D.0138 Risiko Cedera Janin

3. Intervensi Keperawatan

Tabel 4.2 Intervensi Keperawatan

Diagnosa Keperawatan	Tujuan dan Kriteria Hasil	Intervensi Keperawatan
Nyeri melahirkan berhubungan dengan pengeluaran janin	• Koping terhadap ketidaknyamanan meningkat • Nyeri dengan kontraksi meningkat • Frekuensi, periode dan intensitas kontraksi uterus membaik • Tekanan darah membaik	Manajemen Nyeri <i>Observasi</i> • Identifikasi karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri • Identifikasi skala nyeri • Identifikasi respons nyeri non verbal <i>Terapeutik</i> • Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan • Berikan teknik nonfarmakologi untuk mengurangi nyeri <i>Edukasi</i> • Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri • Ajarkan teknik nonfarmakologi untuk mengurangi rasa nyeri
Risiko cedera ibu berhubungan dengan besarnya ukuran janin, malposisi janin, usia ibu, paritas banyak, ketuban pecah, infeksi, masalah kontraksi	• Kejadian cedera menurun • Luka lecet menurun	Manajemen Auhan Persalinan Normal
Risiko cedera janin berhubungan dengan besarnya ukuran janin, malposisi janin, usia ibu, paritas banyak, ketuban pecah, infeksi, masalah kontraksi	• Kejadian cedera menurun	Manajemen Auhan Persalinan Normal

KALA III

1. Pengkajian

Keluhan ibu, Jumlah Perdarahan, Pelepasan plasenta, penggunaan obat-obatan, dan keadaan psikologis ibu.

2. Diagnosa Keperawatan

D.0034 Risiko Hipovolemia

3. Intervensi Keperawatan

Tabel 4.3 Intervensi Keperawatan

Diagnosa Keperawatan	Tujuan dan Kriteria Hasil	Intervensi Keperawatan
Risiko hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan secara aktif	• Output urin meningkat • Nadi meningkat • Rasa haus menurun • Intake cairan membaik • Berat badan membaik	Manajemen hipovolemia <i>Observasi</i> • Periksa tanda dan gejala hypovolemia • Monitor intake dan output cairan <i>Terapeutik</i> • Hitung kebutuhan cairan • Berikan asupan cairan oral <i>Edukasi</i> • Anjurkan memperbanyak asupan cairan • Anjurkan menghindari perubahan posisi mendadak <i>Kolaborasi</i> • Kolaborasi pemberian IV isotonis (mis. NaCl, RL)

KALA IV

1. Pengkajian

- a. Kaji TTV (TD, nadi, pernafasan, nadi)
- b. Kaji waktu pengeluaran plasenta
- c. Kondisi selaput amnion
- d. Kotiledon lengkap atau tidak
- e. Kaji kontraksi/HIS
- f. Kaji perilaku terhadap nyeri
- g. Skala nyeri
- h. Tingkat kelelahan
- i. Keinginan untuk bonding attachment
- j. Inisiasi Menyusu Dini (IMD).

Pengkajian kala IV, dikaji selama 2 jam setelah plasenta lahir. Pada satu jam pertama, ibu dimonitoring setiap 15 menit sekali, dan jam kedua ibu dimonitoring setiap 30 menit. Adapun yang dimonitoring adalah, tekanan darah, nadi, kontraksi, kondisi vesika urinaria, jumlah perdarahan per vagina, intake cairan.

2. Diagnosa Keperawatan

D.0034 Risiko Hipovolemia

3. Intervensi Keperawatan

Tabel 4.4 Intervensi Keperawatan

Diagnosa Keperawatan	Tujuan dan Kriteria Hasil	Intervensi Keperawatan
Risiko hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan secara aktif	• Output urin meningkat • Nadi meningkat • Rasa haus menurun • Intake cairan membaik • Berat badan membaik	Manajemen hipovolemia <i>Observasi</i> • Periksa tanda dan gejala hypovolemia • Monitor intake dan output cairan <i>Terapeutik</i> • Hitung kebutuhan cairan • Berikan asupan cairan oral <i>Edukasi</i> • Anjurkan memperbanyak asupan cairan • Anjurkan menghindari perubahan posisi mendadak <i>Kolaborasi</i> • Kolaborasi pemberian IV isotonis (mis. NaCl, RL)

H. Penutup

Asuhan keperawatan intranatal merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan maternal yang memiliki peran penting dalam menjamin keselamatan ibu dan janin selama proses persalinan. Periode intranatal merupakan fase kritis yang membutuhkan pemantauan secara berkesinambungan, keterampilan klinis yang memadai, serta pengambilan keputusan yang cepat dan tepat oleh tenaga kesehatan. Oleh karena itu, perawat dituntut untuk memiliki kompetensi profesional dalam memberikan asuhan yang komprehensif, aman, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Buku referensi ini disusun sebagai upaya untuk memberikan panduan yang sistematis dan berbasis ilmiah dalam pelaksanaan asuhan keperawatan intranatal. Materi yang disajikan mencakup konsep dasar persalinan, pemantauan kemajuan

persalinan, dukungan nonfarmakologis, manajemen nyeri, tahapan persalinan, kesiapsiagaan komplikasi, upaya menjaga keselamatan ibu dan janin, serta asuhan keperawatan intra natal. Seluruh aspek tersebut merupakan komponen penting dalam memastikan proses persalinan berlangsung secara fisiologis dan aman. Pendekatan asuhan yang berbasis bukti (*evidence-based practice*) diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan maternal serta menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi.

Perawat memiliki tanggung jawab profesional dalam melakukan pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, serta evaluasi asuhan keperawatan intranatal secara berkesinambungan. Selain keterampilan teknis, kemampuan komunikasi terapeutik dan pemberian dukungan emosional kepada ibu dan keluarga juga merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap keberhasilan proses persalinan. Dukungan yang adekuat dapat meningkatkan rasa percaya diri ibu, mengurangi kecemasan, serta membantu proses persalinan berlangsung lebih lancar.

Dalam praktik pelayanan kesehatan, penerapan standar pelayanan yang sesuai dengan pedoman nasional maupun internasional menjadi landasan utama dalam menjaga mutu pelayanan. Penggunaan partograf, pemantauan tanda vital, serta deteksi dini komplikasi merupakan langkah penting dalam menjaga keselamatan ibu dan janin selama persalinan. Selain itu, kesiapan tenaga kesehatan dalam menghadapi kondisi kegawatdaruratan dan sistem rujukan yang efektif sangat menentukan keberhasilan penanganan komplikasi persalinan.

Penulis berharap buku referensi ini dapat menjadi sumber belajar yang bermanfaat bagi mahasiswa keperawatan, dosen, serta tenaga kesehatan dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam memberikan asuhan keperawatan intranatal. Dengan tersedianya sumber referensi yang komprehensif dan berbasis praktik terbaik, diharapkan tenaga keperawatan mampu memberikan pelayanan yang profesional, holistik, dan berorientasi pada keselamatan ibu dan janin.

Referensi

- Bobak, I. M., Lowdermilk, D. L., & Jensen, M. D. 2005. *Maternity Nursing*. St. Louis: Mosby.
- Cashion, K. (2005). Fisiologi Maternal pada Periode Pascapartum. In Buku Ajar Keperawatan Maternitas (pp. 492–571). EGC.\
- Chapman, L. & Durham, R. (2010). *Maternal–Newborn Nursing: The Critical Component of Nursing Care*. Philadelphia: FA Davis Company.

- Johnson, J. Y. (2014). Keperawatan Maternitas (T. . Prabawati, Arie, D. Hardjono, & W. A. Nisman (eds.); Diterjemah). Rapha Publishing.
- Karjatin, Atin. (2016). Keperawatan Maternitas. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan : Kementrian RI
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020. *Pedoman Pelayanan Persalinan Normal*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kinzie, B. & Gomez, P. (2004). Basic Maternal and Newborn Care: A Guide for Skilled Providers. JHPIEGO
- Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., & Cashion, K. 2016. *Maternity and Women's Health Care* (11th ed.). St. Louis: Elsevier.
- Manurung, S. (2011). Buku Ajar Keperawatan Maternitas Asuhan Keperawatan Intranatal. Jakarta: CV Trans Info Media.
- Mitayani. (2009). Asuhan Keperawatan Maternitas. Salemba Medika.
- Novita, R. (2011). Keperawatan Maternitas. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Perry, S., Hockenberry, M., Lowdermilk, D. & Wilson, D. (2010). Maternal Child Nursing Care. Missouri: Mosby Elsevier.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). 2017. *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI)*. Jakarta: PPNI.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). 2018. *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI)*. Jakarta: PPNI.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). 2018. *Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI)*. Jakarta: PPNI.
- Pillitteri, A. (2003). Maternal and Child Health Nursing Care of the Childbearing and Childrearing Family. (4th ed). Philadelphia: Lippincott.
- Varney, H., Kriebs, J. M., & Geger, C. L. 2015. *Varney's Midwifery* (6th ed.). Burlington: Jones & Bartlett Learning.
- World Health Organization (WHO). 2020. *WHO Recommendations: Intrapartum Care for a Positive Childbirth Experience*. Geneva: WHO.

BAB V

ASUHAN KEPERAWATAN POSTPARTUM DAN LAKTASI (PEMULIHAN NIFAS, PERAWATAN PERINEUM, INVOLUSI, PENCEGAHAN INFEKSI, DUKUNGAN MENYUSUI, DAN BONDING ATTACHMENT)

A. Pendahuluan

Asuhan keperawatan postpartum dan laktasi merupakan salah satu komponen utama dalam pelayanan keperawatan maternitas yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan ibu setelah melahirkan serta bayinya. Masa postpartum atau masa nifas dimulai segera setelah plasenta lahir hingga kurang lebih enam minggu setelah persalinan (Fan et al., 2023). Periode ini merupakan fase kritis karena tubuh ibu mengalami berbagai perubahan yang kompleks, baik secara fisiologis maupun psikologis, yang memerlukan pemantauan dan penanganan yang tepat.

Secara fisiologis, tubuh ibu akan mengalami proses pemulihan organ reproduksi seperti involusi uterus, penyembuhan luka perineum atau luka operasi (pada persalinan *sectio caesarea*), serta penyesuaian sistem hormonal yang berperan dalam produksi ASI. Selain itu, terjadi pula perubahan pada sistem kardiovaskular, endokrin, dan metabolisme yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi tubuh seperti sebelum kehamilan (Rosnani, 2022). Di sisi lain, ibu juga menghadapi perubahan psikologis yang bervariasi, mulai dari perasaan bahagia, cemas, kelelahan, hingga risiko gangguan emosional seperti *postpartum blues* atau depresi postpartum.

Perawatan pada masa nifas bertujuan untuk memastikan proses pemulihan berjalan secara optimal, mencegah terjadinya komplikasi seperti perdarahan postpartum dan infeksi, serta membantu ibu beradaptasi dengan peran barunya. Selain itu, asuhan keperawatan juga berfokus pada peningkatan kemampuan ibu dalam merawat diri dan bayinya secara mandiri. Edukasi yang diberikan mencakup perawatan diri, nutrisi, kebersihan, tanda bahaya masa nifas, serta perawatan bayi baru lahir (Fan et al., 2023). Keberhasilan menyusui menjadi salah satu indikator penting dalam asuhan postpartum. Air Susu Ibu (ASI) tidak hanya memberikan manfaat nutrisi yang optimal bagi bayi, tetapi juga berperan dalam meningkatkan

ikatan emosional antara ibu dan bayi. Oleh karena itu, dukungan terhadap proses laktasi sangat diperlukan, baik dalam bentuk edukasi teknik menyusui yang benar, manajemen laktasi, maupun dukungan psikologis agar ibu merasa percaya diri dalam menyusui.

Selain itu, pembentukan hubungan emosional atau *bonding attachment* antara ibu dan bayi merupakan aspek penting yang tidak dapat diabaikan. Interaksi awal seperti kontak kulit ke kulit, menyusui dini, serta komunikasi verbal dan nonverbal akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan emosional dan sosial bayi di masa depan. Proses ini juga membantu meningkatkan rasa percaya diri ibu dalam menjalankan perannya.

Perawat memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan asuhan keperawatan postpartum dan laktasi. Peran tersebut meliputi sebagai pemberi asuhan langsung, edukator, konselor, serta advokat bagi ibu dan bayi. Perawat dituntut untuk mampu melakukan pengkajian secara komprehensif, mengidentifikasi kebutuhan ibu, serta memberikan intervensi yang tepat berdasarkan kondisi individu. Pendekatan yang digunakan dalam asuhan keperawatan postpartum harus bersifat holistik, mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan ibu terpenuhi secara menyeluruh, sehingga kualitas kesehatan ibu dan bayi dapat ditingkatkan secara optimal. Selain itu, keterlibatan keluarga juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan perawatan pada masa nifas (Fan et al., 2023)

B. Konsep Dasar Masa Nifas (Postpartum)

Masa nifas merupakan periode pemulihan yang dimulai setelah persalinan, tepatnya sejak lahirnya plasenta hingga sekitar enam minggu (42 hari) postpartum. Periode ini menjadi fase penting dalam kehidupan seorang ibu karena terjadi proses pemulihan organ reproduksi serta penyesuaian berbagai sistem tubuh yang sebelumnya mengalami perubahan selama kehamilan (Ismael et al., 2025). Masa nifas juga menjadi masa transisi bagi ibu dalam beradaptasi terhadap peran baru sebagai orang tua.

Secara umum, masa nifas dibagi menjadi tiga tahap berdasarkan waktu dan karakteristik perubahan yang terjadi, yaitu:

1. Masa nifas dini (0–24 jam postpartum)

Masa ini merupakan fase paling kritis karena risiko komplikasi, terutama perdarahan postpartum, sangat tinggi. Pada tahap ini, fokus utama perawatan adalah pemantauan tanda-tanda vital, kontraksi uterus, serta jumlah perdarahan. Uterus diharapkan berkontraksi dengan baik untuk mencegah perdarahan. Selain

itu, ibu mulai mengalami kelelahan setelah proses persalinan dan membutuhkan istirahat yang cukup.

2. Masa nifas intermediat (1–7 hari postpartum)

Pada fase ini, proses pemulihan organ reproduksi mulai berlangsung lebih stabil. Uterus mengalami penurunan ukuran secara bertahap (involusi), dan pengeluaran lochea terjadi dengan perubahan warna dari merah (rubra) menjadi kecoklatan atau kekuningan (serosa). Ibu juga mulai belajar merawat bayinya, termasuk menyusui dan menjaga kebersihan diri. Dukungan dan edukasi dari tenaga kesehatan sangat diperlukan pada tahap ini.

3. Masa nifas lanjut (hingga 6 minggu postpartum)

Tahap ini merupakan fase pemulihan lanjutan di mana sebagian besar organ tubuh telah kembali mendekati kondisi sebelum kehamilan. Aktivitas ibu mulai meningkat, dan penyesuaian terhadap peran sebagai ibu semakin berkembang. Namun demikian, pemantauan tetap diperlukan untuk memastikan tidak terjadi komplikasi jangka panjang.

Selama masa nifas, tubuh ibu mengalami berbagai perubahan fisiologis sebagai bagian dari proses adaptasi. Perubahan tersebut meliputi:

a. Sistem reproduksi:

Terjadi involusi uterus, yaitu proses kembalinya rahim ke ukuran normal. Selain itu, terjadi pengeluaran lochea sebagai sisa jaringan kehamilan. Serviks dan vagina juga mengalami pemulihan secara bertahap.

b. Sistem kardiovaskular:

Volume darah yang meningkat selama kehamilan akan kembali normal. Denyut jantung dan tekanan darah mengalami penyesuaian, serta terjadi perubahan dalam sirkulasi darah.

c. Sistem endokrin:

Penurunan hormon estrogen dan progesteron terjadi setelah persalinan, sementara hormon prolaktin meningkat untuk mendukung produksi ASI. Perubahan hormonal ini juga berpengaruh terhadap kondisi emosional ibu.

d. Sistem muskuloskeletal:

Otot-otot yang meregang selama kehamilan dan persalinan mulai kembali ke kondisi semula. Namun, beberapa ibu mungkin mengalami nyeri otot atau kelemahan, terutama pada area panggul dan perut.

Selain perubahan fisik, ibu juga mengalami perubahan psikologis yang signifikan. Pada awal masa nifas, ibu biasanya mengalami fase adaptasi emosional yang meliputi:

a. Fase taking in: ibu cenderung pasif, fokus pada dirinya sendiri, dan membutuhkan dukungan.

- b. Fase taking hold: ibu mulai aktif belajar merawat bayi dan membutuhkan bimbingan.
- c. Fase letting go: ibu mulai menerima peran barunya dan menyesuaikan diri dengan tanggung jawab sebagai ibu.

Namun demikian, tidak semua ibu dapat melalui proses ini dengan mudah. Beberapa ibu dapat mengalami gangguan emosional seperti *postpartum blues*, yang ditandai dengan perasaan sedih, mudah menangis, cemas, dan perubahan suasana hati. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini dapat berkembang menjadi depresi postpartum yang lebih serius.

C. Pemulihan Masa Nifas

Pemulihan masa nifas merupakan proses kembalinya kondisi fisik, psikologis, dan sosial ibu setelah mengalami kehamilan dan persalinan. Masa ini berlangsung sejak plasenta lahir hingga sekitar enam minggu postpartum, di mana tubuh ibu secara bertahap beradaptasi kembali ke kondisi sebelum hamil (Landau, 2021). Proses pemulihan ini tidak hanya melibatkan penyembuhan organ reproduksi, tetapi juga penyesuaian fungsi sistem tubuh lainnya serta adaptasi terhadap peran baru sebagai seorang ibu.

Secara fisiologis, pemulihan ditandai dengan terjadinya involusi uterus, yaitu proses kembalinya rahim ke ukuran semula, penyembuhan luka pada jalan lahir atau luka operasi, serta normalisasi perubahan hormonal. Selain itu, sistem tubuh lain seperti sistem kardiovaskular, perkemihan, dan pencernaan juga mengalami penyesuaian. Pada masa ini, ibu juga mulai mengalami proses laktasi sebagai bagian dari fungsi reproduksi pasca persalinan (Martin et al., 2022). Di sisi psikologis, ibu mengalami berbagai perubahan emosional yang dipengaruhi oleh kelelahan, perubahan hormon, serta tanggung jawab baru dalam merawat bayi. Respons emosional ini dapat berupa perasaan bahagia, cemas, mudah lelah, hingga kondisi seperti *postpartum blues*. Oleh karena itu, dukungan psikologis sangat penting untuk membantu ibu menjalani masa adaptasi ini secara sehat.

Proses pemulihan masa nifas dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

1. Status kesehatan ibu sebelum dan selama kehamilan, termasuk adanya penyakit penyerta.
2. Jenis persalinan, baik persalinan normal maupun operasi (sectio caesarea) yang memengaruhi lama penyembuhan.
3. Status nutrisi, yang berperan penting dalam proses regenerasi jaringan dan produksi ASI.
4. Istirahat dan aktivitas, yang harus seimbang agar tidak menghambat proses penyembuhan.

5. Dukungan keluarga dan lingkungan, yang sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis ibu.
6. Pengetahuan ibu, terkait perawatan diri dan bayi selama masa nifas.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mempercepat dan mengoptimalkan pemulihan masa nifas meliputi beberapa aspek berikut:

1. Pemenuhan Kebutuhan Personal Hygiene

Menjaga kebersihan diri sangat penting untuk mencegah infeksi, terutama pada area genital. Ibu dianjurkan untuk membersihkan area perineum dengan benar, mengganti pembalut secara teratur, serta menjaga kebersihan tubuh secara keseluruhan.

2. Pemenuhan Nutrisi Seimbang

Ibu postpartum membutuhkan asupan gizi yang cukup dan seimbang, meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nutrisi yang adekuat berperan dalam mempercepat penyembuhan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mendukung produksi ASI.

3. Istirahat yang Cukup

Istirahat merupakan faktor penting dalam pemulihan. Kurangnya istirahat dapat menyebabkan kelelahan, menurunkan imunitas, serta memengaruhi kondisi psikologis ibu. Oleh karena itu, ibu dianjurkan untuk beristirahat ketika bayi tidur dan mengatur pola tidur sebaik mungkin.

4. Mobilisasi Dini

Mobilisasi dini dilakukan secara bertahap sesuai kondisi ibu. Aktivitas ringan seperti duduk, berdiri, dan berjalan dapat membantu memperlancar sirkulasi darah, mencegah trombosis, serta mempercepat pemulihan fungsi tubuh.

5. Dukungan Emosional dan Sosial

Dukungan dari suami, keluarga, dan tenaga kesehatan sangat penting dalam membantu ibu merasa aman dan percaya diri. Lingkungan yang suportif dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan psikologis ibu.

6. Perawatan Payudara dan Laktasi

Perawatan payudara serta pemberian ASI secara dini dan rutin dapat membantu kelancaran produksi ASI serta mencegah masalah seperti bendungan ASI atau mastitis.

Perawat memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses pemulihan masa nifas. Peran tersebut meliputi:

- a. **Sebagai edukator**, dengan memberikan informasi mengenai perawatan diri, nutrisi, aktivitas, serta teknik menyusui yang benar.
- b. **Sebagai caregiver**, dengan memberikan asuhan keperawatan secara langsung sesuai kebutuhan ibu.

- c. **Sebagai konselor**, dengan memberikan dukungan emosional dan membantu ibu mengatasi kecemasan atau masalah psikologis.
- d. **Sebagai advokat**, dengan memastikan ibu mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dan berkualitas.

Selain itu, perawat juga bertanggung jawab dalam memberikan edukasi mengenai **tanda bahaya masa nifas**, seperti perdarahan berlebihan, demam tinggi, nyeri hebat, bau tidak sedap pada lochea, serta gangguan psikologis yang berat. Deteksi dini terhadap tanda bahaya ini sangat penting untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan proses pemulihan masa nifas dapat berlangsung secara optimal. Hal ini tidak hanya berdampak pada kesehatan ibu, tetapi juga pada kesejahteraan bayi dan keluarga secara keseluruhan.

D. Perawatan Perineum

Perawatan perineum merupakan salah satu aspek penting dalam asuhan keperawatan postpartum yang bertujuan untuk menjaga kebersihan, mempercepat proses penyembuhan luka, serta mencegah terjadinya infeksi pada daerah perineum. Perineum adalah area antara vagina dan anus yang sering mengalami trauma saat persalinan, baik berupa robekan spontan (ruptur perineum) maupun tindakan episiotomi. Kondisi ini menyebabkan ibu rentan terhadap nyeri, ketidaknyamanan, serta risiko infeksi jika tidak dilakukan perawatan yang tepat (Amalia et al., 2023). Pada masa postpartum, luka perineum akan mengalami proses penyembuhan yang melibatkan fase inflamasi, proliferasi, dan maturasi. Oleh karena itu, perawatan yang adekuat sangat diperlukan untuk mendukung proses penyembuhan jaringan secara optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka antara lain kebersihan, nutrisi, sirkulasi darah, serta kepatuhan ibu dalam melakukan perawatan diri.

Perawatan perineum meliputi beberapa tindakan utama, yaitu menjaga kebersihan area genital, mengganti pembalut secara teratur, serta melakukan teknik pembersihan yang benar. Pembersihan perineum sebaiknya dilakukan menggunakan air bersih atau larutan steril dengan arah dari depan (vagina) ke belakang (anus) untuk mencegah kontaminasi bakteri dari daerah anus ke luka perineum (Graziottin, 2024). Tindakan ini sangat penting dalam mencegah infeksi. Frekuensi penggantian pembalut juga harus diperhatikan, yaitu setiap 4–6 jam atau lebih sering jika pembalut sudah penuh oleh darah nifas (lochea). Pembalut yang lembap dapat menjadi media pertumbuhan bakteri, sehingga meningkatkan risiko infeksi. Selain itu, ibu dianjurkan untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan perawatan perineum guna menjaga prinsip kebersihan.

Dalam beberapa kondisi, perawatan tambahan seperti kompres hangat atau *sitz bath* (rendam duduk dengan air hangat) dapat dilakukan untuk mengurangi nyeri, meningkatkan sirkulasi darah, dan mempercepat penyembuhan luka. Namun, tindakan ini harus dilakukan sesuai dengan indikasi dan anjuran tenaga kesehatan. Pada 24 jam pertama postpartum, kompres dingin juga dapat diberikan untuk mengurangi pembengkakan dan nyeri. Penggunaan antiseptik dalam perawatan perineum perlu dilakukan secara hati-hati. Beberapa jenis antiseptik yang terlalu kuat dapat merusak jaringan sehat dan menghambat proses penyembuhan luka. Oleh karena itu, penggunaan antiseptik sebaiknya sesuai dengan rekomendasi tenaga kesehatan dan tidak digunakan secara berlebihan.

Selain perawatan lokal, faktor sistemik seperti nutrisi juga berperan penting dalam penyembuhan luka. Ibu postpartum dianjurkan untuk mengonsumsi makanan tinggi protein, vitamin C, dan zat besi untuk mendukung regenerasi jaringan dan meningkatkan daya tahan tubuh (Frilasari et al., 2020) Asupan cairan yang cukup juga penting untuk menjaga hidrasi dan membantu proses penyembuhan.

Perawat memiliki peran yang sangat penting dalam perawatan perineum, baik sebagai pemberi asuhan langsung maupun sebagai edukator. Perawat bertanggung jawab untuk mengajarkan teknik perawatan perineum yang benar kepada ibu, memberikan informasi mengenai tanda-tanda infeksi, serta memotivasi ibu untuk melakukan perawatan secara mandiri di rumah (Nagar, 2024) Edukasi yang diberikan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman ibu agar dapat diterapkan dengan baik. Selain itu, perawat juga melakukan pemantauan terhadap kondisi luka perineum secara berkala. Tanda-tanda infeksi yang perlu diwaspadai meliputi nyeri yang semakin meningkat, kemerahan, pembengkakan, keluarnya cairan bernanah, bau tidak sedap, serta demam. Apabila ditemukan tanda-tanda tersebut, maka diperlukan tindakan segera untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

E. Proses Involusi Uterus

Involusi uterus adalah proses kembalinya rahim (uterus) ke ukuran, bentuk, dan posisi seperti sebelum kehamilan. Proses ini merupakan bagian penting dari pemulihan fisiologis ibu pada masa postpartum dan biasanya berlangsung secara bertahap selama kurang lebih enam minggu setelah persalinan. Involusi uterus terjadi akibat kontraksi otot-otot rahim serta penurunan hormon kehamilan, terutama estrogen dan progesteron, setelah plasenta lahir. Segera setelah persalinan, uterus akan berkontraksi dengan kuat untuk mencegah perdarahan dan membantu pelepasan sisa jaringan dari dalam rahim (Aires et al., 2025) Pada kondisi normal, tinggi fundus uteri (TFU) berada setinggi umbilikus (pusar) dalam 24 jam

pertama postpartum. Selanjutnya, tinggi fundus uteri akan menurun sekitar 1–2 cm setiap hari. Pada akhir minggu kedua, uterus biasanya sudah tidak teraba di atas simfisis pubis, dan pada minggu keenam, ukuran uterus kembali seperti sebelum hamil.

Selama proses involusi, ibu juga akan mengalami pengeluaran cairan dari vagina yang disebut lochea. Lochea merupakan hasil dari peluruhan jaringan endometrium, darah, dan lendir serviks (Wei et al., 2024) Lochea mengalami perubahan warna dan konsistensi seiring waktu, yang menjadi indikator penting dalam menilai proses pemulihan uterus. Tahapan lochea meliputi:

- a. **Lochea rubra**, berwarna merah terang, terjadi pada hari 1–3 postpartum, mengandung darah segar dan sisa jaringan.
- b. **Lochea serosa**, berwarna merah muda atau kecokelatan, terjadi pada hari 4–10 postpartum.
- c. **Lochea alba**, berwarna putih kekuningan, berlangsung dari hari ke-10 hingga beberapa minggu setelah persalinan.

Perubahan lochea yang normal menunjukkan bahwa proses involusi uterus berjalan dengan baik. Namun, apabila terjadi perubahan yang tidak normal, seperti perdarahan berlebihan, bau tidak sedap, atau warna yang tidak sesuai dengan tahapannya, hal ini dapat mengindikasikan adanya komplikasi (Wei et al., 2024) Beberapa faktor dapat mempengaruhi proses involusi uterus, antara lain paritas (jumlah persalinan), status nutrisi, aktivitas ibu, menyusui, serta adanya komplikasi seperti infeksi atau retensi sisa plasenta. Menyusui memiliki peran penting dalam mempercepat involusi uterus karena rangsangan pada puting susu akan meningkatkan produksi hormon oksitosin yang merangsang kontraksi rahim.

Perawat memiliki peran penting dalam memantau proses involusi uterus sebagai bagian dari asuhan keperawatan postpartum. Pemantauan dilakukan dengan cara mengukur tinggi fundus uteri, menilai konsistensi uterus (keras atau lembek), serta mengobservasi jenis, jumlah, dan karakteristik lochea. Uterus yang tidak berkontraksi dengan baik (atonia uteri) dapat meningkatkan risiko perdarahan postpartum, sehingga memerlukan penanganan segera (Sitta et al., 2023) Selain itu, perawat juga perlu mengidentifikasi adanya gangguan involusi seperti subinvolusi, yaitu kondisi di mana uterus tidak kembali ke ukuran normal sesuai waktu yang seharusnya. Subinvolusi dapat disebabkan oleh infeksi, sisa plasenta, atau kurangnya kontraksi uterus. Tanda-tanda yang perlu diwaspadai antara lain tinggi fundus uteri yang tidak menurun, perdarahan berkepanjangan, serta lochea yang abnormal.

Edukasi kepada ibu merupakan bagian penting dalam mendukung keberhasilan involusi uterus. Ibu perlu diberikan informasi mengenai perubahan normal selama masa nifas, pentingnya menyusui, menjaga kebersihan, serta

melakukan mobilisasi dini (Ningsih & Palembang, 2021) Selain itu, ibu juga harus mengetahui tanda-tanda bahaya seperti perdarahan banyak, nyeri hebat, demam, atau bau tidak sedap pada lochea, sehingga dapat segera mencari pertolongan medis.

Dengan pemantauan yang tepat dan edukasi yang memadai, proses involusi uterus diharapkan dapat berlangsung secara optimal tanpa komplikasi. Hal ini sangat penting dalam mendukung pemulihan kesehatan ibu secara keseluruhan selama masa postpartum.

F. Bonding Attachment Ibu Dan Bayi

Bonding attachment adalah hubungan emosional yang terbentuk antara ibu dan bayi sejak awal kehidupan, yang menjadi dasar penting bagi perkembangan psikologis, emosional, dan sosial anak di masa depan. Ikatan ini tidak hanya berkaitan dengan kasih sayang, tetapi juga mencerminkan rasa aman, kepercayaan, serta kedekatan yang terjalin melalui interaksi yang konsisten antara ibu dan bayi.

Proses bonding attachment dimulai sejak masa kehamilan dan berlanjut secara intensif setelah bayi lahir. Pada periode postpartum, interaksi awal antara ibu dan bayi menjadi sangat krusial dalam membentuk hubungan ini. Bayi yang mendapatkan bonding yang baik cenderung memiliki perkembangan emosi yang lebih stabil, kemampuan sosial yang lebih baik, serta tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi di kemudian hari.

Salah satu cara efektif untuk memulai bonding attachment adalah melalui kontak kulit ke kulit (*skin to skin contact*) segera setelah bayi lahir. Kontak ini memberikan berbagai manfaat, seperti menstabilkan suhu tubuh bayi, meningkatkan denyut jantung dan pernapasan yang lebih teratur, serta merangsang produksi hormon oksitosin pada ibu yang berperan dalam meningkatkan kasih sayang dan refleks menyusui.

Menyusui juga merupakan bagian penting dari proses bonding attachment. Selain memberikan nutrisi optimal, kegiatan menyusui menciptakan momen kedekatan emosional antara ibu dan bayi melalui sentuhan, tatapan mata, serta komunikasi nonverbal. Interaksi ini membantu bayi merasa aman dan dicintai, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri ibu dalam merawat bayinya.

Selain itu, bonding attachment juga dapat diperkuat melalui interaksi verbal dan nonverbal, seperti berbicara lembut kepada bayi, menggendong, membelai, serta merespons tangisan bayi dengan cepat dan penuh perhatian. Respons yang konsisten terhadap kebutuhan bayi akan membantu membentuk rasa aman (*secure attachment*), yang sangat penting dalam perkembangan psikologis anak.

Lingkungan yang mendukung juga memegang peranan penting dalam keberhasilan bonding attachment. Suasana yang tenang, nyaman, dan minim gangguan memungkinkan ibu dan bayi untuk berinteraksi secara optimal. Dukungan dari keluarga, terutama pasangan, juga sangat dibutuhkan untuk membantu ibu merasa lebih rileks dan percaya diri dalam menjalani peran barunya.

Kondisi emosional ibu merupakan faktor lain yang sangat mempengaruhi proses bonding. Ibu yang mengalami stres, kelelahan, atau gangguan emosional seperti *postpartum blues* atau depresi postpartum dapat mengalami hambatan dalam membangun kedekatan dengan bayinya. Oleh karena itu, perhatian terhadap kesehatan mental ibu menjadi bagian penting dalam asuhan postpartum.

Perawat memiliki peran strategis dalam memfasilitasi dan mendukung terbentuknya bonding attachment. Peran tersebut meliputi memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga mengenai pentingnya bonding, mengajarkan teknik *skin to skin contact*, serta mendukung pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD). Perawat juga bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan perawatan yang kondusif, seperti membatasi pemisahan ibu dan bayi serta mendorong *rooming-in* (rawat gabung).

Selain itu, perawat perlu melakukan observasi terhadap interaksi ibu dan bayi untuk mengidentifikasi adanya hambatan dalam proses bonding. Jika ditemukan masalah, perawat dapat memberikan dukungan emosional, konseling, serta melibatkan keluarga dalam membantu meningkatkan kedekatan antara ibu dan bayi.

Dengan dukungan yang tepat dari tenaga kesehatan dan lingkungan sekitar, proses bonding attachment dapat terbentuk secara optimal. Hal ini akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi tumbuh kembang anak serta meningkatkan kualitas hubungan antara ibu dan anak. Oleh karena itu, bonding attachment harus menjadi salah satu fokus utama dalam asuhan keperawatan postpartum yang komprehensif dan berkelanjutan.

G. Peran perawat dalam asuhan postpartum dan laktasi

Perawat memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan asuhan keperawatan postpartum dan laktasi, karena masa nifas merupakan periode transisi yang krusial bagi ibu dan bayi. Pada fase ini, ibu tidak hanya mengalami pemulihan fisik setelah persalinan, tetapi juga menghadapi perubahan psikologis serta tuntutan peran baru sebagai seorang ibu. Oleh karena itu, perawat dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang komprehensif, berkesinambungan, dan berpusat pada kebutuhan ibu dan bayi.

Peran perawat dalam asuhan postpartum dan laktasi meliputi beberapa fungsi utama, yaitu sebagai *care provider*, edukator, konselor, advokat, serta kolaborator dengan tenaga kesehatan lainnya.

Sebagai pemberi asuhan (*care provider*), perawat bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan keperawatan secara langsung kepada ibu dan bayi. Tindakan yang dilakukan meliputi pemantauan tanda-tanda vital, observasi involusi uterus, penilaian perdarahan (*lochea*), perawatan luka perineum atau luka operasi, serta pemantauan kondisi bayi baru lahir. Selain itu, perawat juga membantu ibu dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti mobilisasi dini, nutrisi, istirahat, serta kenyamanan selama masa nifas.

Sebagai edukator, perawat berperan dalam memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu dan keluarga. Edukasi yang diberikan mencakup perawatan diri selama masa nifas, teknik menyusui yang benar, perawatan payudara, perawatan bayi baru lahir, serta tanda-tanda bahaya yang harus diwaspadai. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu sehingga mampu merawat dirinya dan bayinya secara mandiri setelah pulang dari fasilitas kesehatan.

Sebagai konselor, perawat memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada ibu. Masa postpartum seringkali disertai dengan perubahan suasana hati, kecemasan, bahkan risiko depresi. Perawat harus mampu mendengarkan keluhan ibu, memberikan empati, serta membantu ibu mengatasi stres dan kecemasan yang dialami. Dukungan ini sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan diri ibu dalam menjalankan perannya, termasuk dalam proses menyusui.

Sebagai advokat, perawat berperan dalam melindungi hak-hak ibu dan bayi serta memastikan bahwa mereka mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Perawat membantu ibu dalam mengambil keputusan terkait perawatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya. Selain itu, perawat juga memastikan bahwa intervensi yang diberikan tetap menghormati nilai, budaya, dan keyakinan yang dimiliki oleh ibu dan keluarga.

Sebagai kolaborator, perawat bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain seperti dokter, bidan, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan yang terpadu. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa ibu dan bayi mendapatkan penanganan yang komprehensif, terutama jika terdapat komplikasi atau kondisi khusus yang memerlukan penanganan multidisiplin.

Dalam praktiknya, perawat harus mampu menerapkan proses keperawatan secara sistematis yang meliputi pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Pengkajian dilakukan secara menyeluruh meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Data yang dikumpulkan digunakan untuk menentukan diagnosis keperawatan yang tepat sesuai dengan kondisi ibu dan bayi.

Selanjutnya, perawat menyusun rencana intervensi yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan klien. Implementasi dilakukan dengan mengutamakan keselamatan, kenyamanan, serta prinsip evidence-based practice. Setelah tindakan dilakukan, perawat melakukan evaluasi untuk menilai efektivitas asuhan yang diberikan serta melakukan modifikasi rencana jika diperlukan.

Pendekatan yang digunakan dalam asuhan keperawatan postpartum dan laktasi harus bersifat holistik, yaitu mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Selain itu, pendekatan harus berpusat pada ibu dan bayi (mother and baby centered care), dengan melibatkan keluarga sebagai sistem pendukung utama.

Selain memberikan asuhan langsung, perawat juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kemandirian ibu dan keluarga. Hal ini dilakukan melalui pemberdayaan, edukasi, dan pendampingan sehingga ibu mampu merawat dirinya, menyusui dengan baik, serta merawat bayinya secara mandiri di rumah. Kemandirian ini sangat penting untuk mencegah komplikasi, meningkatkan kualitas hidup ibu dan bayi, serta mendukung keberhasilan peran keluarga dalam menjaga kesehatan.

H. Penutup

Asuhan keperawatan postpartum dan laktasi merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Masa nifas adalah periode kritis yang memerlukan perhatian khusus dari tenaga kesehatan, terutama perawat.

Dengan pemahaman yang baik mengenai pemulihan nifas, perawatan perineum, involusi uterus, pencegahan infeksi, dukungan menyusui, serta bonding attachment, diharapkan perawat dapat memberikan asuhan yang optimal dan berkualitas. Keberhasilan asuhan keperawatan tidak hanya ditentukan oleh keterampilan klinis, tetapi juga oleh kemampuan dalam memberikan dukungan emosional dan edukasi kepada ibu dan keluarga. Oleh karena itu, perawat diharapkan mampu menjalankan perannya secara profesional dan holistik demi tercapainya kesehatan ibu dan bayi yang optimal.

Referensi

- Aires, K. V, Paula, A., Andrade, L. G. De, Boyer, A., Zamberlam, G., Portela, V. M., Antoniazzi, A. Q., & St-jean, G. (2025). *Postpartum Uterine Involution in Cows: Quantitative Assessment of Structural Remodeling and Immune Cell Infiltration*. 1–21.
- Amalia, N. R., Rahmawati, I., & Purwanti, R. (2023). *Perawatan luka jahitan perineum pada ibu nifas Di PMB Emy Lestari Purworejo*. 01.
- Fan, W. Q., Chan, C., Paterson, S., Foster, K., Morrow, M., Bourne, D., & Ashworth, J.

- (2023). *Weekly Proactive Telephone Breastfeeding Standard Care by Lactation Consultants in the First Month Postpartum Prolongs Breastfeeding for Up to 6 Months*.
- Frilasari, H., Saudah, N., Prameswari, V. E., & Azizah, Y. N. (2020). *Nutritional Pattern And Healing Of Perineum Wound On Postpartum Period*. 3(2), 172–180.
- Graziottin, A. (2024). *Maintaining vulvar , vaginal and perineal health: Clinical considerations*. <https://doi.org/10.1177/17455057231223716>
- Ismael, O., Britez, B., Santander, E. B., Saavedra, M. O., & Concepción, G. (2025). *Professional role during Nursing Care for the postpartum woman with a risk approach Rol profesional durante los Cuidados de Enfermería a la puerpera con enfoque de riesgo*. <https://doi.org/10.62486/sic2025213>
- Landau, R. (2021). *Deconstructing Current Postpartum Recovery Research — The Need to Contextualize Patient-Reported Outcome Measures*. 4(5), 27–29. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.11689>
- Martin, C., Ritonga, T., & Sofinia, H. (2022). *The Physiological Changes In The Postpartum Period After Childbirth*. 1(03), 105–118.
- Nagar, Y. (2024). *A Study to Assess the Knowledge of Staff Nurses Regarding Prevention and Management of Perineal Tear During Normal Delivery at Clean Labor Room (CLR) at Mahila Chikitsalaya of Jaipur*. 5(3), 792–795.
- Ningsih, R., & Palembang, P. K. (2021). *Analysis of Factors Affecting the Acceleration of Uterine Involution in the Postpartum*. 521(ICoHSST 2020), 224–229.
- Rosnani, R. (2022). *Overview of post-partum mother adaptation: A healthy lifestyle needs*. 1, 134–138.
- Sitta, R., Mariano, G., José, V., Santos, C., & Taira, A. R. (2023). *Characterization of uterine involution using B- mode ultrasonography , color Doppler and elastography (acoustic radiation force impulse) for assessing postpartum in Santa Inês ewes*. 20(2), 1–12.
- Wei, D., Wang, Z., Yue, J., Chen, Y., Meng, J., & Id, X. N. (2024). *Effect of low-intensity focused ultrasound therapy on postpartum uterine involution in puerperal women: A randomized controlled trial*. 1–12. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0301825>

BAB VI

KEGAWATDARURATAN OBSTETRI UNTUK PER AWAT (PERDARAHAN ANTEPARTUM/POSTPARTUM, PREEKLAMPSIA/EKLAMPSIA, SEPSIS, EMBOLI, SYOK, DAN RUJUKAN AMAN

A. Pendahuluan

Kegawatdaruratan obstetri merupakan kondisi kritis yang terjadi selama kehamilan, persalinan, maupun masa nifas yang dapat mengancam keselamatan ibu dan janin. Kondisi ini mencakup berbagai gangguan yang muncul secara tiba-tiba dan membutuhkan penanganan segera untuk mencegah komplikasi yang lebih berat hingga kematian (Horn et al., 2024). Dalam praktiknya, kegawatdaruratan obstetri sering kali terjadi tanpa dapat diprediksi secara pasti, sehingga kesiapsiagaan tenaga kesehatan menjadi faktor yang sangat menentukan dalam penyelamatan nyawa ibu dan bayi (Whaley et al., 2022).

Masalah kesehatan ibu masih menjadi perhatian global, terutama di negara berkembang, di mana angka kematian ibu (AKI) masih relatif tinggi. Faktor penyebab utama kematian ibu umumnya berkaitan dengan komplikasi selama kehamilan dan persalinan, seperti perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, serta keterlambatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai (Girum & Wasie, 2017). Kondisi ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor medis, tetapi juga oleh aspek sosial, ekonomi, dan akses terhadap fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dan terintegrasi untuk menanggulangi permasalahan tersebut (Sitaula et al., 2021).

Dalam sistem pelayanan kesehatan, perawat memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam penanganan kegawatdaruratan obstetri. Perawat sering kali menjadi tenaga kesehatan pertama yang berinteraksi langsung dengan pasien, baik di fasilitas kesehatan maupun di komunitas (Nishimwe et al., 2022). Peran ini menuntut perawat untuk memiliki kemampuan dalam melakukan deteksi dini terhadap tanda dan gejala kegawatdaruratan, memberikan tindakan awal yang tepat, serta melakukan pemantauan kondisi ibu secara berkesinambungan (Jose et al., 2023).

Selain itu, perawat juga berperan dalam edukasi kepada ibu dan keluarga mengenai tanda bahaya dalam kehamilan dan persalinan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap kondisi yang berisiko (Khatoon et al., 2025) Edukasi ini penting untuk mencegah keterlambatan dalam pengambilan keputusan untuk mencari pertolongan medis (Awaji et al., 2025) Dalam konteks yang lebih luas, perawat juga terlibat dalam koordinasi tim kesehatan dan memastikan sistem rujukan berjalan secara efektif dan efisien.

Salah satu aspek penting dalam penanganan kegawatdaruratan obstetri adalah sistem rujukan yang aman. Rujukan yang tidak tepat atau terlambat dapat memperburuk kondisi pasien dan meningkatkan risiko kematian (Daniels & Abuosi, 2020) Oleh karena itu, perawat harus mampu melakukan stabilisasi kondisi pasien sebelum dirujuk, melakukan komunikasi yang baik dengan fasilitas kesehatan tujuan, serta memastikan pasien mendapatkan pendampingan yang adekuat selama proses rujukan.

Bab ini akan membahas berbagai jenis kegawatdaruratan obstetri yang sering terjadi, meliputi perdarahan antepartum dan postpartum sebagai penyebab utama kematian ibu, preeklamsia dan eklamsia yang berkaitan dengan gangguan hipertensi dalam kehamilan, sepsis sebagai bentuk infeksi berat, emboli sebagai kondisi akut yang mengancam jiwa, serta syok yang merupakan manifestasi akhir dari berbagai kondisi kegawatdaruratan. Selain itu, akan dibahas pula prinsip-prinsip rujukan aman sebagai bagian penting dalam sistem pelayanan kesehatan ibu.

Dengan memahami konsep dan penanganan kegawatdaruratan obstetri secara komprehensif, diharapkan perawat dapat meningkatkan kompetensi dalam memberikan asuhan keperawatan yang cepat, tepat, dan berkualitas. Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat berkontribusi dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

B. Perdarahan Antepartum Dan Postpartum

1. Perdarahan Antepartum

Perdarahan antepartum adalah perdarahan yang terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu hingga sebelum persalinan. Kondisi ini merupakan salah satu kegawatdaruratan obstetri yang memerlukan penanganan segera karena berisiko tinggi menyebabkan morbiditas dan mortalitas pada ibu maupun janin (Gebrekidan et al., 2025) Perdarahan antepartum dapat terjadi secara tiba-tiba dengan jumlah yang bervariasi, mulai dari ringan hingga berat.

Penyebab utama perdarahan antepartum adalah plasenta previa dan solusio plasenta. Plasenta previa terjadi ketika plasenta menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir, sedangkan solusio plasenta adalah kondisi di mana plasenta terlepas

sebelum waktunya dari dinding rahim (Chen et al., 2025) Selain itu, penyebab lain yang lebih jarang meliputi ruptura uteri dan kelainan pembuluh darah.

Tanda dan Gejala:

- a. Perdarahan dari vagina (dapat berwarna merah terang pada plasenta previa)
- b. Nyeri perut atau nyeri tekan uterus (umumnya pada solusio plasenta)
- c. Uterus tegang atau keras
- d. Penurunan atau tidak adanya gerakan janin
- e. Tanda-tanda syok pada perdarahan berat (pucat, lemah, penurunan tekanan darah)

Penatalaksanaan Keperawatan:

- a. Melakukan observasi tanda vital secara berkala (tekanan darah, nadi, pernapasan)
- b. Mengkaji jumlah, warna, dan karakteristik perdarahan
- c. Menganjurkan ibu untuk tirah baring dengan posisi miring kiri guna meningkatkan perfusi uteroplacenta
- d. Tidak melakukan pemeriksaan dalam (vaginal toucher) tanpa indikasi medis
- e. Memasang jalur intravena untuk persiapan pemberian cairan
- f. Memberikan oksigen jika diperlukan
- g. Menyiapkan pasien untuk pemeriksaan lanjutan (USG atau laboratorium)
- h. Melakukan kolaborasi dengan tim medis untuk tindakan lebih lanjut
- i. Mempersiapkan rujukan segera ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap

2. Perdarahan Postpartum

Perdarahan postpartum adalah perdarahan yang terjadi setelah persalinan, baik dalam 24 jam pertama (postpartum primer) maupun setelah 24 jam hingga 6 minggu (postpartum sekunder). Kondisi ini merupakan penyebab utama kematian ibu di seluruh dunia, sehingga penanganan cepat dan tepat sangat diperlukan.

Perdarahan postpartum umumnya disebabkan oleh empat faktor utama yang dikenal dengan istilah **4T**, yaitu:

- a. Tone (atonia uteri): kegagalan uterus berkontraksi setelah persalinan
- b. Tissue (retensio plasenta): adanya sisa jaringan plasenta dalam rahim
- c. Trauma: robekan pada jalan lahir seperti serviks, vagina, atau perineum
- d. Thrombin: gangguan pembekuan darah

Tanda dan Gejala:

- a. Perdarahan pervaginam dalam jumlah banyak
- b. Uterus lembek dan tidak berkontraksi (pada atonia uteri)
- c. Tanda-tanda syok (takikardia, hipotensi, pucat, gelisah)
- d. Penurunan kesadaran pada kasus berat

- e. Produksi urin menurun

Penatalaksanaan Keperawatan:

- a. Melakukan masase uterus untuk merangsang kontraksi uterus
- b. Mengobservasi tinggi fundus uteri dan kekuatan kontraksi uterus
- c. Memantau jumlah dan jenis perdarahan secara berkala
- d. Memastikan kandung kemih kosong (kateterisasi jika diperlukan)
- e. Memberikan uterotonika seperti oksitosin sesuai indikasi medis
- f. Memasang jalur intravena dan memberikan cairan resusitasi
- g. Memberikan oksigen jika terdapat tanda hipoksia
- h. Memantau tanda-tanda vital secara ketat
- i. Menyiapkan transfusi darah jika diperlukan
- j. Melakukan kolaborasi dengan dokter untuk penanganan lanjutan
- k. Mempersiapkan rujukan segera jika kondisi tidak dapat ditangani di fasilitas saat ini

Penanganan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi oleh perawat sangat menentukan keberhasilan dalam mengatasi perdarahan antepartum maupun postpartum. Kemampuan dalam mengenali tanda bahaya serta melakukan tindakan awal yang efektif merupakan kunci utama dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu.

C. Preklamsia Dan Eklamsia

Preeklamsia adalah suatu kondisi hipertensi yang terjadi pada kehamilan setelah usia kehamilan 20 minggu yang disertai dengan proteinuria atau tanda gangguan organ lainnya. Kondisi ini merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas ibu serta janin (Erez et al., 2022) Apabila tidak ditangani dengan baik, preeklamsia dapat berkembang menjadi eklamsia, yaitu kondisi yang ditandai dengan terjadinya kejang pada ibu hamil yang tidak disebabkan oleh gangguan neurologis lainnya.

Preeklamsia terjadi akibat gangguan perfusi plasenta yang menyebabkan disfungsi endotel dan vasospasme pembuluh darah. Hal ini mengakibatkan peningkatan tekanan darah dan gangguan pada berbagai organ seperti ginjal, hati, dan otak. Eklamsia merupakan bentuk komplikasi paling berat dari preeklamsia yang dapat mengancam jiwa ibu dan janin secara langsung.

Klasifikasi Preeklamsia:

1. **Preeklamsia ringan:** tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg dengan proteinuria ringan
2. **Preeklamsia berat:** tekanan darah $\geq 160/110$ mmHg disertai gejala berat seperti nyeri epigastrium, gangguan penglihatan, dan penurunan fungsi organ

Tanda dan Gejala:

1. Tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg
2. Edema, terutama pada wajah dan ekstremitas
3. Proteinuria
4. Nyeri kepala hebat yang tidak hilang dengan istirahat
5. Gangguan penglihatan (pandangan kabur, melihat kilatan cahaya)
6. Nyeri epigastrium atau ulu hati
7. Mual dan muntah
8. Penurunan jumlah urin (oliguria)
9. Refleks meningkat (hiperrefleksia)
10. Kejang (pada eklamsia)
11. Penurunan kesadaran pada kasus berat

Komplikasi:

1. Eklamsia (kejang)
2. Sindrom HELLP (Hemolysis, Elevated Liver Enzyme, Low Platelet)
3. Gagal ginjal
4. Edema paru
5. Solusio plasenta
6. Kematian ibu dan janin

Penatalaksanaan Keperawatan:

1. Melakukan pemantauan tekanan darah secara berkala dan ketat
2. Mengobservasi tingkat kesadaran, refleks tendon dalam, dan tanda-tanda iritabilitas sistem saraf pusat
3. Memantau keseimbangan cairan (input-output) untuk mencegah overload cairan
4. Menciptakan lingkungan yang tenang, redup, dan minim rangsangan untuk mencegah kejang
5. Menganjurkan tirah baring dengan posisi miring kiri untuk meningkatkan aliran darah ke plasenta
6. Memberikan terapi oksigen bila diperlukan
7. Menyiapkan dan membantu pemberian magnesium sulfat sesuai instruksi medis sebagai pencegahan dan penanganan kejang
8. Mengobservasi efek samping magnesium sulfat seperti depresi pernapasan dan penurunan refleks
9. Menyiapkan antidotum (kalsium glukonat) jika terjadi toksisitas magnesium
10. Melakukan edukasi kepada keluarga mengenai kondisi pasien dan tanda bahaya
11. Mempersiapkan persalinan sesuai kondisi ibu dan janin sebagai terapi definitif
12. Melakukan kolaborasi dengan tim medis untuk penanganan lanjutan

13. Mempersiapkan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap apabila diperlukan

Penanganan preeklamsia dan eklamsia memerlukan ketepatan dalam pengkajian serta kecepatan dalam tindakan. Perawat memiliki peran penting dalam mencegah progresivitas penyakit melalui pemantauan yang ketat dan intervensi yang tepat, sehingga komplikasi dapat diminimalkan dan keselamatan ibu serta janin dapat terjaga.

D. Sepsis Obstetri

Sepsis obstetri merupakan kondisi infeksi berat yang terjadi selama kehamilan, persalinan, atau masa nifas yang dapat berkembang menjadi kegagalan organ dan mengancam jiwa ibu. Sepsis terjadi akibat respon tubuh yang berlebihan terhadap infeksi, sehingga menyebabkan disfungsi sistem organ secara menyeluruh (Acosta et al., 2016). Kondisi ini merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu, terutama di fasilitas kesehatan dengan keterbatasan sumber daya dan keterlambatan dalam penanganan.

Sumber infeksi pada sepsis obstetri dapat berasal dari berbagai tempat, seperti infeksi saluran genital (endometritis), infeksi luka persalinan, ketuban pecah dini yang tidak ditangani dengan baik, serta prosedur persalinan yang tidak aseptik. Faktor risiko lain meliputi anemia, malnutrisi, persalinan lama, serta tindakan invasif yang tidak steril.

Tanda dan Gejala:

1. Demam tinggi ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau hipotermia
2. Takikardia (denyut nadi cepat)
3. Takipnea (pernapasan cepat)
4. Nyeri abdomen atau nyeri panggul
5. Keputihan atau lochia berbau tidak sedap
6. Lemas, gelisah, atau penurunan kesadaran
7. Penurunan tekanan darah pada kondisi berat (syok sepsis)
8. Produksi urin menurun (oliguria)

Komplikasi:

1. Syok sepsis
2. Gagal organ multipel
3. Gangguan pembekuan darah (DIC)
4. Kematian ibu

Penatalaksanaan Keperawatan:

1. Melakukan pemantauan tanda vital secara ketat (tekanan darah, nadi, suhu, dan pernapasan)

2. Mengobservasi status kesadaran dan tanda-tanda perburukan kondisi
3. Memantau keseimbangan cairan (input-output) termasuk produksi urin
4. Memasang jalur intravena dan memberikan cairan resusitasi sesuai indikasi
5. Membantu pemberian antibiotik spektrum luas sesuai instruksi medis secara tepat waktu
6. Memberikan terapi oksigen bila diperlukan untuk meningkatkan oksigenasi jaringan
7. Menjaga prinsip kebersihan dan aseptis dalam setiap tindakan keperawatan
8. Melakukan perawatan luka atau sumber infeksi dengan teknik steril
9. Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai pentingnya kebersihan dan tanda bahaya
10. Melakukan kolaborasi dengan tim medis dalam penanganan lanjutan
11. Mempersiapkan rujukan segera ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap apabila kondisi memburuk

Penanganan sepsis obstetri memerlukan respons cepat dan terkoordinasi. Perawat memiliki peran penting dalam deteksi dini, pencegahan penyebaran infeksi, serta pelaksanaan intervensi awal yang tepat. Dengan penanganan yang optimal, risiko komplikasi dan kematian akibat sepsis obstetri dapat ditekan secara signifikan.

E. Emboli Dalam Kehamilan

Emboli merupakan kondisi terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah akibat adanya benda asing yang terbawa aliran darah, seperti bekuan darah (trombus), gelembung udara, atau cairan amnion (Andonotopo et al., 2025). Dalam konteks obstetri, emboli merupakan salah satu kegawatdaruratan yang sangat serius dan dapat menyebabkan kematian secara mendadak apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat.

Pada kehamilan dan masa nifas, risiko terjadinya emboli meningkat akibat perubahan fisiologis, seperti peningkatan faktor pembekuan darah dan penekanan pembuluh darah oleh uterus yang membesar. Dua jenis emboli yang paling sering terjadi dalam praktik obstetri adalah emboli paru dan emboli cairan amnion.

Jenis Emboli:

1. Emboli Paru

Emboli paru terjadi akibat sumbatan pada arteri pulmonalis oleh bekuan darah yang biasanya berasal dari vena dalam (deep vein thrombosis). Kondisi ini menghambat aliran darah ke paru-paru dan menyebabkan gangguan pertukaran oksigen.

2. Emboli Cairan Amnion

Emboli cairan amnion merupakan kondisi langka namun sangat fatal, yang terjadi ketika cairan amnion masuk ke dalam sirkulasi ibu melalui pembuluh darah. Hal ini dapat memicu reaksi inflamasi berat, gangguan pernapasan, hingga kolaps kardiovaskular.

Tanda dan Gejala:

- a. Sesak napas mendadak dan berat
- b. Nyeri dada, terutama saat bernapas
- c. Sianosis (kebiruan pada bibir dan ujung jari)
- d. Takikardia
- e. Penurunan tekanan darah
- f. Penurunan kesadaran atau kehilangan kesadaran
- g. Gelisah atau rasa cemas berlebihan
- h. Pada emboli cairan amnion dapat disertai perdarahan hebat akibat gangguan pembekuan

Komplikasi:

- a. Gagal napas akut
- b. Syok kardiogenik
- c. Henti jantung
- d. Gangguan pembekuan darah (DIC)
- e. Kematian mendadak

Penatalaksanaan Keperawatan:

- a. Segera mengenali tanda dan gejala emboli sebagai kondisi kegawatdaruratan
- b. Memberikan oksigen dengan konsentrasi tinggi untuk meningkatkan oksigenasi
- c. Memposisikan pasien dalam posisi semi-Fowler untuk mempermudah pernapasan
- d. Memantau tanda vital secara ketat (tekanan darah, nadi, pernapasan, saturasi oksigen)
- e. Memasang jalur intravena untuk pemberian cairan dan obat-obatan
- f. Menyiapkan alat dan tindakan resusitasi jika terjadi henti napas atau henti jantung
- g. Memberikan dukungan psikologis kepada pasien dan keluarga
- h. Melakukan kolaborasi dengan tim medis untuk penanganan lanjutan seperti pemberian antikoagulan atau tindakan intensif lainnya
- i. Mempersiapkan rujukan segera ke fasilitas kesehatan dengan layanan intensif (ICU)

Emboli dalam kehamilan merupakan kondisi yang membutuhkan respon cepat, ketepatan tindakan, serta kerja sama tim yang baik. Perawat memiliki peran penting dalam deteksi dini dan penanganan awal untuk mencegah terjadinya komplikasi yang lebih berat dan meningkatkan peluang keselamatan ibu.

F. Syok Pada Kegawatdaruratan Obstetri

Syok adalah kondisi kegagalan sistem sirkulasi yang menyebabkan perfusi jaringan tidak adekuat sehingga kebutuhan oksigen dan nutrisi sel tidak terpenuhi. Dalam bidang obstetri, syok merupakan salah satu kondisi yang sangat berbahaya dan dapat berkembang dengan cepat menjadi kegagalan organ hingga kematian apabila tidak segera ditangani.

Syok pada kegawatdaruratan obstetri umumnya disebabkan oleh beberapa faktor utama, seperti perdarahan hebat (syok hipovolemik), infeksi berat (syok septik), reaksi alergi (syok anafilaktik), atau gangguan jantung (syok kardiogenik) (Ayadi et al., 2016) Di antara penyebab tersebut, perdarahan postpartum merupakan penyebab paling sering terjadinya syok pada ibu.

Secara fisiologis, syok terjadi ketika volume darah yang beredar tidak mencukupi atau ketika jantung tidak mampu memompa darah secara efektif, sehingga suplai oksigen ke jaringan menurun. Kondisi ini akan memicu respon kompensasi tubuh, seperti peningkatan denyut jantung dan penyempitan pembuluh darah, namun jika tidak segera diatasi akan berujung pada dekompensasi dan kerusakan organ.

Tanda dan Gejala:

1. Tekanan darah menurun (hipotensi)
2. Nadi cepat dan lemah (takikardia)
3. Pernapasan cepat dan dangkal
4. Kulit dingin, pucat, dan lembap
5. Pengisian kapiler lambat
6. Penurunan kesadaran (gelisah hingga tidak sadar)
7. Produksi urin menurun (oliguria)
8. Rasa haus berlebihan
9. Pada kondisi berat dapat terjadi sianosis dan henti jantung
10. Klasifikasi Syok dalam Obstetri:
11. Syok hipovolemik: akibat kehilangan darah atau cairan dalam jumlah besar
12. Syok septik: akibat infeksi berat yang menyebar ke seluruh tubuh
13. Syok kardiogenik: akibat gangguan fungsi jantung
14. Syok anafilaktik: akibat reaksi alergi berat

Penatalaksanaan Keperawatan:

1. Segera mengenali tanda-tanda syok sebagai kondisi kegawatdaruratan
2. Memposisikan pasien dalam posisi Trendelenburg ringan atau kaki lebih tinggi untuk meningkatkan aliran darah ke organ vital
3. Memastikan jalan napas terbuka dan memberikan oksigen dengan aliran tinggi
4. Memasang jalur intravena dengan ukuran besar untuk pemberian cairan secara cepat
5. Memberikan cairan resusitasi (kristaloid/ koloid) sesuai instruksi medis
6. Memantau tanda vital secara ketat dan berkelanjutan (tekanan darah, nadi, pernapasan, saturasi oksigen)
7. Memantau keseimbangan cairan dan produksi urin sebagai indikator perfusi ginjal
8. Menghentikan sumber perdarahan jika memungkinkan
9. Menjaga suhu tubuh pasien agar tetap hangat
10. Menyiapkan transfusi darah jika diperlukan
11. Melakukan kolaborasi dengan tim medis untuk penanganan lanjutan sesuai penyebab syok
12. Mempersiapkan rujukan segera ke fasilitas kesehatan dengan layanan intensif

Penanganan syok dalam kegawatdaruratan obstetri harus dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Perawat memiliki peran kunci dalam deteksi dini, stabilisasi kondisi pasien, serta pemantauan yang ketat. Dengan intervensi yang cвоеbar dan adekuat, risiko komplikasi serius dan kematian dapat diminimalkan.

G. Rujukan Aman Dalam Kegawatdaruratan Obstetri

Rujukan aman merupakan proses pemindahan pasien dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama ke fasilitas yang memiliki kemampuan pelayanan yang lebih lengkap, dengan tetap menjaga kondisi pasien agar stabil selama proses tersebut (Daniels & Abuosi, 2020). Dalam konteks kegawatdaruratan obstetri, rujukan aman menjadi salah satu faktor kunci dalam menyelamatkan nyawa ibu dan bayi, terutama ketika fasilitas awal tidak mampu menangani komplikasi yang terjadi.

Keterlambatan dalam proses rujukan, baik dalam pengambilan keputusan, transportasi, maupun penanganan selama perjalanan, dapat meningkatkan risiko terjadinya komplikasi yang lebih berat bahkan kematian. Oleh karena itu, sistem rujukan harus dilakukan secara cepat, tepat, terkoordinasi, dan berkesinambungan.

Prinsip Rujukan Aman:**1. Stabilisasi kondisi pasien sebelum rujukan**

Pasien harus mendapatkan penanganan awal untuk menstabilkan kondisi, seperti mengatasi perdarahan, memberikan cairan intravena, oksigenasi, dan tindakan emergensi lainnya sebelum dipindahkan.

2. Komunikasi antar fasilitas kesehatan

Petugas kesehatan harus melakukan komunikasi dengan fasilitas tujuan untuk memastikan kesiapan penerimaan pasien dan memberikan informasi terkait kondisi pasien secara lengkap.

3. Dokumentasi lengkap

Semua tindakan yang telah dilakukan, hasil pemeriksaan, serta kondisi pasien harus didokumentasikan dengan baik dan disertakan saat rujukan sebagai bahan informasi bagi tenaga kesehatan di tempat tujuan.

4. Pendampingan tenaga kesehatan

Pasien harus didampingi oleh tenaga kesehatan yang kompeten selama proses rujukan untuk memantau kondisi dan melakukan tindakan jika terjadi perburukan.

5. Transportasi yang memadai

Penggunaan sarana transportasi yang sesuai, seperti ambulans yang dilengkapi peralatan medis dasar, sangat penting untuk menjamin keselamatan pasien selama perjalanan.

Peran Perawat dalam Rujukan:

1. Menilai kondisi pasien

Perawat melakukan pengkajian menyeluruh terhadap kondisi ibu, termasuk tanda vital, tingkat kesadaran, dan kondisi obstetri untuk menentukan kebutuhan rujukan.

2. Melakukan stabilisasi awal

Perawat bertanggung jawab dalam memberikan tindakan awal seperti pemasangan infus, pemberian oksigen, menghentikan perdarahan, dan tindakan lain sesuai kondisi pasien.

3. Memberikan edukasi kepada keluarga

Perawat menjelaskan kondisi pasien, alasan rujukan, serta prosedur yang akan dilakukan kepada keluarga agar mereka memahami dan dapat memberikan persetujuan dengan cepat.

4. Mendampingi pasien selama proses rujukan

Perawat memantau kondisi pasien selama perjalanan, mencatat perubahan kondisi, serta siap melakukan tindakan darurat jika diperlukan.

5. Melakukan komunikasi efektif

Perawat berperan dalam menyampaikan informasi penting kepada fasilitas rujukan, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi, sehingga kesinambungan pelayanan dapat terjaga.

6. Menyiapkan administrasi rujukan

Perawat membantu melengkapi dokumen rujukan, termasuk surat rujukan, catatan medis, dan hasil pemeriksaan penunjang.

Rujukan aman merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan ibu yang efektif. Peran aktif dan kompetensi perawat dalam proses ini sangat menentukan keberhasilan penanganan kegawatdaruratan obstetri. Dengan pelaksanaan rujukan yang tepat, diharapkan angka kesakitan dan kematian ibu dapat ditekan serta kualitas pelayanan kesehatan semakin meningkat.

H. Penutup

Kegawatdaruratan obstetri merupakan kondisi yang memerlukan penanganan cepat, tepat, dan terkoordinasi untuk menyelamatkan kehidupan ibu dan bayi. Berbagai kondisi seperti perdarahan, preeklamsia/eklamsia, sepsis, emboli, dan syok merupakan penyebab utama tingginya angka kesakitan dan kematian ibu, sehingga membutuhkan kewaspadaan tinggi dari seluruh tenaga kesehatan.

Perawat memiliki peran yang sangat penting dalam setiap tahapan penanganan kegawatdaruratan obstetri. Peran tersebut meliputi kemampuan dalam melakukan deteksi dini terhadap tanda dan gejala bahaya, memberikan penatalaksanaan awal yang tepat, serta melakukan pemantauan kondisi pasien secara berkesinambungan. Selain itu, perawat juga berperan dalam memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga, sehingga dapat meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya mencari pertolongan medis secara cepat.

Koordinasi dalam sistem rujukan yang aman juga menjadi tanggung jawab penting bagi perawat. Ketepatan dalam mengambil keputusan rujukan, kemampuan dalam menstabilkan kondisi pasien sebelum dirujuk, serta komunikasi yang efektif dengan fasilitas kesehatan tujuan merupakan faktor penentu keberhasilan dalam penanganan kasus kegawatdaruratan.

Peningkatan kompetensi perawat melalui pendidikan, pelatihan, serta pengalaman klinis sangat diperlukan agar mampu menghadapi berbagai situasi kegawatdaruratan secara profesional. Dengan keterampilan dan pengetahuan yang memadai, perawat dapat memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas, cepat, dan tepat sasaran.

Referensi

- Acosta, C. D., Harrison, D. A., Rowan, K., Lucas, D. N., Kurinczuk, J. J., & Knight, M. (2016). *Maternal morbidity and mortality from severe sepsis: a national cohort study*. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-012323>
- Andonotopo, W., Bachnas, M. A., Dewantiningrum, J., Besari, M., Pramono, A., Setiawan, C., Sulistyowati, S., & Stanojevic, M. (2025). Amniotic Fluid Embolism: a comprehensive review of diagnosis and management. *Journal of Perinatal Medicine*, 1–15. <https://doi.org/10.1515/jpm-2025-0161>
- Awaji, H. Q., Knadiry, A. N., & Alomran, S. I. (2025). *Saudi Journal of Medicine and Public Health*. 2(2), 583–595.
- Ayadi, A. M. El, Nathan, H. L., Seed, P. T., Butrick, E. A., Hezelgrave, L., Shennan, A. H., & Miller, S. (2016). *Vital Sign Prediction of Adverse Maternal Outcomes in Women with Hypovolemic Shock: The Role of Shock Index*. 1–12. <https://doi.org/10.7272/Q6MS3QNX>
- Chen, D., Gao, X., Yang, T., Xin, X., Wang, G., Wang, H., He, R., & Liu, M. (2025). *Independent risk factors for placental abruption: a systematic review and meta-analysis*.
- Daniels, A. A., & Abuosi, A. (2020). *Improving emergency obstetric referral systems in low and middle income countries: a qualitative study in a tertiary health facility in Ghana*. 3, 1–10.
- Erez, O., Romero, R., Jung, E., & Chaemsaithong, P. (2022). Expert Review Preeclampsia and eclampsia: the conceptual evolution of a syndrome. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 226(2), S786–S803. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2021.12.001>
- Gebrekidan, M. G., Fisseha, M. A., & Belay, A. G. (2025). *Effects of antepartum hemorrhage on maternal and perinatal adverse outcomes in Northern Ethiopia: a retrospective cohort study*. 0.
- Girum, T., & Wasie, A. (2017). *Correlates of maternal mortality in developing countries: an ecological study in 82 countries*. 1–6. <https://doi.org/10.1186/s40748-017-0059-8>
- Horn, C., Bam, N. E., & Matsipane, M. J. (2024). *Exploring disaster preparedness in an obstetric unit in a district hospital in the Western Cape Province*. 1–12.
- Jose, J., Nirmal, R., Elsy, N. P., Litt, K. I., & Joseph, L. (2023). *Obstetrical Emergencies:*

Bridging The Knowledge Gap- Educating Future Nurses. 7(3), 1–9.

Khatoon, M., Kanwal, S., & Ashraf, S. (2025). *Evaluation of the Role of Nurses in Maternal Health Education Programs on Reducing Obstetric Complications in Resource-Limited Settings. 6(8), 20–24.*

Nishimwe, A., Conco, D. N., Nyssen, M., & Ibisomi, L. (2022). *Context specific realities and experiences of nurses and midwives in basic emergency obstetric and newborn care services in two district hospitals in Rwanda : a qualitative study. 1–16.*

Sitaula, S., Basnet, T., Agrawal, A., Manandhar, T., Das, D., & Shrestha, P. (2021). Prevalence and risk factors for maternal mortality at a tertiary care centre in Eastern Nepal - retrospective cross sectional study. *BMC Pregnancy and Childbirth, 1–8.* <https://doi.org/10.1186/s12884-021-03920-4>

Whaley, B., Butrick, E., Sales, J. M., Wanyoro, A., Waiswa, P., Walker, D., & Cranmer, J. N. (2022). *Using clinical cascades to measure health facilities ' obstetric emergency readiness : testing the cascade model sectional facility data in using cross- - East Africa.* <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-057954>

BAB VII

ASUHAN KEPERAWATAN NEONATUS DASAR TERKAIT MATERNITAS

A. Pendahuluan

Masa kehidupan bayi setelah lahir merupakan periode awal yang tidak menyenangkan bagi bayi. Hal itu disebabkan karena lingkungan kehidupan sebelumnya (intrauterin) dengan lingkungan kehidupan yang sekarang (ekstra uteri) sangat jauh berbeda. Di dalam uterus janin hidup dan tumbuh dengan segala kenyamanan karena ia tumbuh dan hidup bergantung penuh pada ibunya. Sedangkan, pada waktu kelahiran, setiap bayi baru lahir akan mengalami adaptasi atau proses penyesuaian fungsi-fungsi vital dari kehidupan di dalam uterus ke kehidupan di luar uterus.

Adaptasi neonatus adalah proses penyesuaian fungsi neonatus dari kehidupan di dalam uterus. Fisiologi neonatus merupakan ilmu yang mempelajari fungsi dan proses vital neonatus. Kemampuan adaptasi fungsional neonatus dari kehidupan di dalam uterus ke kehidupan di luar uterus. Kemampuan adaptasi fisiologis ini disebut juga homeostasis. Bila terdapat gangguan adaptasi maka bayi akan sakit.

Banyak perubahan yang akan dialami oleh bayi yang semula berada dalam lingkungan interna (dalam kandungan ibu) yang hangat dan segala kebutuhannya terpenuhi (oksigen dan nutrisi) ke lingkungan eksternal (diluar kandungan ibu) yang dingin dan segala kebutuhannya memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhinya.

Masa neonatus merupakan periode awal kehidupan manusia yang dimulai sejak bayi lahir hingga usia 28 hari. Periode ini dikenal sebagai fase kritis karena terjadi berbagai proses adaptasi fisiologis dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin. Bayi harus mampu menyesuaikan fungsi organ tubuhnya secara mandiri, termasuk sistem pernapasan, kardiovaskular, termoregulasi, dan metabolisme. Ketidakmampuan beradaptasi secara optimal dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang berpotensi meningkatkan angka kesakitan dan kematian neonatal.

Kehidupan sebagai janin sangat berbeda dengan kehidupan setelah lahir. Periode neonatal merupakan periode perubahan fisiologis yang dramatis dan cepat. Sekitar 10% dari seluruh bayi baru lahir memerlukan dukungan untuk memfasilitasi

keberhasilan transisi setelah melahirkan. Dokter dan tenaga kesehatan harus memahami proses fisiologis dan memperhatikan transisi kardiopulmoner bayi baru lahir dengan saksama untuk memberikan perawatan dan terapi yang tepat sesuai kebutuhan.

Secara global, angka kematian neonatal masih menjadi perhatian utama dalam bidang kesehatan ibu dan anak. Sebagian besar kematian neonatal disebabkan oleh kondisi yang sebenarnya dapat dicegah, seperti asfiksia, infeksi, prematuritas, dan hipotermia. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang tepat sejak awal kehidupan bayi, termasuk melalui asuhan keperawatan yang komprehensif, sistematis, dan berbasis bukti.

Asuhan keperawatan neonatus tidak hanya berfokus pada tindakan kuratif, tetapi juga mencakup upaya promotif dan preventif. Perawatan bayi baru lahir yang tepat, pelaksanaan inisiasi menyusui dini (IMD), pencegahan hipotermia, serta skrining awal merupakan komponen penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan bayi. Selain itu, edukasi kepada orang tua mengenai perawatan bayi di rumah menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlangsungan kesehatan neonatus setelah keluar dari fasilitas pelayanan kesehatan.

Perawat sebagai bagian dari tenaga kesehatan memiliki peran strategis dalam memberikan asuhan tersebut. Perawat tidak hanya bertugas melakukan pengkajian dan intervensi, tetapi juga berperan sebagai edukator, konselor, dan advokat bagi ibu dan keluarga. Dengan kompetensi yang memadai, perawat diharapkan mampu mendukung proses adaptasi bayi secara optimal serta mencegah terjadinya komplikasi.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu sumber referensi yang dapat menjadi panduan dalam memahami dan menerapkan asuhan keperawatan neonatus secara menyeluruh. Buku ini disusun untuk memberikan gambaran yang sistematis dan aplikatif mengenai perawatan bayi baru lahir, pelaksanaan IMD, pencegahan hipotermia, skrining awal, serta edukasi perawatan bayi di rumah.

B. Perawatan Bayi Baru Lahir

Bayi baru lahir (neonatus) adalah bayi usia 0–28 hari yang sedang mengalami adaptasi dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin. Perawatan yang tepat sangat penting untuk mencegah komplikasi dan meningkatkan kelangsungan hidup. Bayi baru lahir (neonatus) merupakan individu yang berada pada fase transisi kritis dari kehidupan intrauterin ke kehidupan ekstrauterin. Pada periode ini, bayi harus mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan fisiologis, seperti sistem pernapasan, sirkulasi, termoregulasi, dan metabolisme. Proses adaptasi ini sangat

menentukan kelangsungan hidup dan kualitas kesehatan bayi di masa selanjutnya (WHO, 2022).

Pelayanan kesehatan pada bayi perlu dilakukan secara baik dan teratur melalui pencegahan, pemeliharaan, dan perawatan bayi secara menyeluruh sehingga tercapainya tujuan peningkatan derajat kesehatan. Salah satu faktor agar tujuan tersebut dapat tercapai adalah pentingnya perawatan bayi sehari-hari yang wajib diketahui oleh ibu setelah melahirkan. Berbagai macam perawatan bayi baru lahir harus dilakukan untuk menjaga bayi dari hal yang tidak diinginkan serta agar bayi dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat sehingga menjadi generasi yang cerdas. Perawatan bayi baru lahir seperti perawatan tali pusat, perawatan kebersihan fisik, penjagaan suhu tubuh bayi, pemberian ASI Eksklusif dan deteksi adanya tanda-tanda infeksi harus dilakukan oleh ibu dalam merawat bayi baru lahir. Selain itu kedekatan ibu terhadap bayi juga diperlukan dalam perawatan bayi baru lahir (Nuzura, 2018)

Bayi membutuhkan perawatan yang menyeluruh guna memastikan bayi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta menghindarkan bayi dari resiko kesakitan yang dapat memicu terjadinya kematian bayi. Permasalahan yang terdapat pada bayi baru lahir tidak terlepas dari infeksi yang rentan terjadi pada bayi baru lahir. Penanganan dan perawatan yang tepat diperlukan oleh ibu yang akan melakukan perawatan bayi baru lahir di rumah. Apabila bayi mendapatkan perawatan yang kurang baik maka dapat menimbulkan resiko pada bayi yang pada akhirnya memicu munculnya permasalahan pada bayi baru lahir (Grenny, 2025).

Pengkajian pada bayi baru lahir dilakukan secara komprehensif meliputi identitas bayi, riwayat kehamilan dan persalinan, serta pemeriksaan fisik menyeluruh. Pemeriksaan fisik mencakup penilaian tanda vital, refleks primitif, kondisi kulit, sistem pernapasan, dan sistem kardiovaskular. Selain itu, dilakukan penilaian awal menggunakan skor Apgar untuk mengetahui adaptasi bayi terhadap lingkungan ekstrauterin (American Academy of Pediatrics, 2019).

Pengkajian juga mencakup aspek kebutuhan dasar bayi seperti pola napas, kemampuan menyusu, eliminasi, serta suhu tubuh. Identifikasi faktor risiko seperti prematuritas, berat badan lahir rendah, atau komplikasi persalinan sangat penting untuk menentukan prioritas asuhan keperawatan (WHO, 2022).

C. Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Inisiasi Menyusu Dini adalah proses bayi mulai menyusu dalam satu jam pertama setelah lahir melalui kontak kulit dengan ibu. IMD terbukti dapat meningkatkan keberhasilan pemberian ASI eksklusif, memperkuat ikatan emosional ibu dan bayi, serta membantu stabilisasi suhu tubuh bayi. Selain itu, Inisiasi Menyusu

Dini (IMD) berkontribusi dalam menurunkan angka kematian neonatal secara signifikan (United Nations Children's Fund, 2021).

Menurut United Nations Children's Fund, Inisiasi Menyusu Dini (IMD) merupakan intervensi penting dalam menurunkan mortalitas bayi baru lahir. Inisiasi Menyusu Dini (IMD) terbukti mampu menurunkan angka kematian neonatal. Tim kesehatan dapat memberikan nasehat kepada ibu hamil mengenai IMD, salah satunya adalah mencegah kehilangan panas dan IMD pada 1 jam pertama setelah melahirkan. Inisiasi Menyusu Dini (IMD) disebut dengan persalinan kala empat, dimana setelah 1 jam persalinan, bayi baru lahir dibaringkan tengkurap setelah tubuhnya dikeringkan. Bayi juga tidak langsung dibedong di dada ibu setelah melahirkan, dan pastikan bayi bersentuhan langsung dengan kulit ibu, menemukan puting susu, dan mendapat ASI pertama (Yunura, NR, & Ernita, 2023).

Tindakan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) ini dapat memperkuat reflek menghisap bayi yang kemudian dapat merangsang hormon prolaktin dan meningkatkan produksi ASI. Pada jam pertama setelah bayi lahir, bayi menyusu lebih lama dan reflek hisap ini yang paling kuat. Oleh karena itu Inisiasi Menyusu Dini (IMD) sangat bermanfaat untuk persiapan menyusu ke depannya (Mawaddah, 2018).

Selain itu, Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dapat memperlancar keluarnya ASI pada ibu nifas. Saat bayi mendekat dan menghisap puting susu, maka bayi akan mendapatkan kolostrum dari ibu yang sudah ia konsumsi sejak lahir. Hisapan bayi akan memudahkan keluarnya ASI dari puting ibu. Begitu pula sebaliknya jika terjadi gangguan pada pelaksanaan IMD maka akan mempengaruhi proses keluarnya ASI dari puting susu ibu (Yanti, Fernando, Rahayuningrum, & Wartinis, 2021).

Manfaat Inisiasi Menyusu Dini (IMD) bayi dan ibu menjadi lebih tenang, tidak stres, pernafasan dan detak jantung lebih stabil, dikarenakan oleh kontak antara kulit ibu dan bayi. Sentuhan, emutan dan jilatan bayi pada puting susu ibu akan merangsang pengeluaran hormon oxytosin yang menyebabkan rahim berkontraksi sehingga mengurangi perdarahan ibu dan membantu pelepasan plasenta. Bayi juga akan terlatih motoriknya saat menyusu, sehingga mengurangi kesulitan posisi menyusu dan mempererat hubungan ikatan ibu dan anak. (Rismawati & Ohorella, 2021).

D. Pencegahan Hipotermia

Bayi baru lahir memiliki rasio luas permukaan tubuh yang besar dibandingkan berat badan, sehingga mereka rentan kehilangan panas. Mereka tidak bisa menggigil atau menggunakan vasokonstriksi untuk menghangatkan diri. Sebagai gantinya, mereka memiliki lemak coklat yang dapat menghasilkan panas tanpa menggigil, meskipun proses ini menghabiskan oksigen. Oleh karena itu, penting

untuk menjaga suhu tubuh bayi agar tidak mengalami hipotermia, yang dapat memicu respons stres, meningkatkan kebutuhan oksigen, dan menyebabkan komplikasi serius seperti asidosis dan hipoksia (Doherty et al., 2025).

Menjaga suhu tubuh sangat penting untuk fisiologis bayi baru lahir. Penyimpangan rentang suhu tubuh dari batas normal dapat menyebabkan hipotermia dan hipertemia yang mengganggu fungsi organ dan meningkatkan risiko kematian pada neonatus (Ryan, 2024).

Suhu lingkungan netral yang direkomendasikan berada pada rentang 22°C - 26°C. suhu bayi harus dipertahankan dalam batas normal. Jika suhu lingkungan turun di bawah suhu lingkungan netral, metabolisme akan meningkat dan terjadi peningkatan konsumsi oksigen. Jika kondisi ini tidak ditangani dan terus berlanjut, dapat menyebabkan penurunan suhu bayi dan hipotermia.

Hipotermia adalah kondisi suhu tubuh di bawah 36,5°C (97,7°F), merupakan masalah umum pada bayi baru lahir, terutama bayi prematur dan bayi yang lahir di lingkungan dengan sumber daya terbatas. Hipotermia dapat mengganggu proses metabolisme, mengganggu fungsi pernapasan, dan membuat bayi rentan terhadap infeksi (Ryan, 2024).

Kerentanan terhadap penurunan suhu tubuh yang drastis menjadi ancaman serius bagi bayi baru lahir pada 12 jam awal persalinan, dengan risiko lebih tinggi ditemukan pada bayi prematur maupun yang mengalami gangguan pertumbuhan. Kondisi ini dipicu oleh pelepasan panas tubuh secara masif yang berlangsung cepat sesaat setelah kelahiran. Oleh karena itu, menjaga stabilitas suhu bayi sangatlah krusial mengingat sistem regulasi internal mereka yang belum sempurna dalam menghadapi lingkungan luar yang dingin (Laptook, 2024; Koop & Tadi, 2023).

Tanda dan gejala hipotermia pada bayi baru lahir dapat meliputi bayi tidak mau minum dan menghisap, bayi terlihat lesu dan gelisah, tubuh bayi terasa dingin, mulut dan ujung jari bayi pucat hingga tampak membiru, pernapasan bayi tidak teratur, denyut jantung bayi teraba lambat (Subekti, Karyuni and Meilya, 2019).

Pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah hipotermia pada bayi baru lahir yaitu, tutupi bagian kepala menggunakan topi, gunakan pakaian yang tidak basah, selimuti bayi, menjaga kehangatan ruangan (22°C -26°C), bayi harus selalu kering, jangan letakkan bayi ke arah angin, pakaian, handuk serta air hangat harus disiapkan sebelum bayi mandi, setelah mandi bayi harus secepat mungkin dikeringkan dengan handuk serta langsung memakai pakaian (IDAI, 2016 dalam Setiyani et al., 2016)

E. Skrining Awal

Fase 28 hari awal pasca-persalinan, yang dikenal sebagai periode neonatal, merupakan tahapan kehidupan yang sangat rentan mengingat tingginya statistik fatalitas bayi bila dibandingkan dengan rentang usia lainnya. Sebagian besar kasus kematian terjadi pada kurun waktu 24 jam pertama, yang dipicu oleh komplikasi medis seperti kegagalan napas spontan, kelahiran prematur, serta paparan infeksi. Mengingat urgensi tersebut, evaluasi klinis pada neonatus menjadi instrumen krusial dalam menjamin transisi fisiologis dari lingkungan rahim ke dunia luar berjalan dengan sempurna. Para praktisi medis dituntut untuk menyelenggarakan pemeriksaan yang komprehensif, cepat, dan terorganisir demi mengidentifikasi kebutuhan resusitasi darurat serta mendeteksi adanya anomali kongenital sedini mungkin. Implementasi penilaian awal yang dilakukan berdasarkan standar prosedur operasional secara signifikan mampu menekan angka kesakitan serta meminimalisir probabilitas kematian pada bayi baru lahir (WHO, 2017; Kemenkes RI, 2020).

Tujuan penilaian awal neonatus adalah, menentukan kondisi umum bayi setelah lahir, menilai fungsi pernapasan dan sirkulasi, menentukan kebutuhan resusitasi atau intervensi medis segera, mengidentifikasi kelainan bawaan atau trauma lahir, menentukan rencana perawatan dan pemantauan lanjutan.

Penilaian awal neonatus adalah proses pemeriksaan segera terhadap bayi baru lahir, dilakukan dalam menit pertama kehidupan, untuk menilai fungsi vital, mendeteksi kelainan, dan menentukan tindakan medis yang diperlukan. Penilaian ini meliputi evaluasi pernapasan, sirkulasi, tonus otot, refleks, warna kulit, serta pemeriksaan fisik cepat dan menyeluruh (Apgar, 1953; WHO, 2017).

F. Edukasi Perawatan Bayi di Rumah

Permasalahan yang terdapat pada bayi baru lahir tidak terlepas dari infeksi yang rentan terjadi pada bayi baru lahir. Penanganan dan perawatan yang tepat diperlukan oleh ibu yang akan melakukan perawatan bayi baru lahir di rumah. Apabila bayi mendapatkan perawatan yang kurang baik maka dapat menimbulkan resiko pada bayi yang pada akhirnya memicu munculnya permasalahan pada bayi baru lahir (Wasiah & Artamevia, 2021).

Seorang ibu juga diharapkan mengerti bagaimana perawatan bayi di rumah mulai dari perawatan kebersihan, nutrisi bagi bayi, dan bagaimana perawatan bayi saat sakit (Wasiah dan Artamevia, 2021). Perawatan bayi baru lahir yang penting untuk dilakukan di rumah yaitu pemberian ASI yang tepat, perawatan tali pusat, dan memandikan bayi yang tepat (Kartika & Lestari, 2021).

Penanganan tali pusat yang benar serta pengetahuan yang memadai sangat krusial untuk mencegah infeksi dan risiko tetanus. Dengan perawatan yang tepat, tali pusat umumnya dapat terlepas secara aman tanpa komplikasi dalam kurun waktu 5-7 hari. Perawatan tali pusat yang tepat juga dapat mencegah penyakit tetanus kedalam tubuh melalui tali pusat (Tim Riskesdas, 2018).

Selain perawatan tali pusat, memandikan bayi merupakan aspek krusial dalam perawatan bayi baru lahir. Langkah ini bertujuan untuk melindungi bayi dari kotoran, mencegah risiko infeksi, serta menjaga kebersihan dan kesegaran tubuhnya. Dalam pelaksanaannya, prinsip utama yang harus dipegang adalah mencegah hipotermia dan memastikan air tidak masuk ke telinga, hidung, maupun mulut. Pengabaian prinsip tersebut sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan bayi mengalami gangguan pernapasan atau aspirasi serta penurunan suhu tubuh yang sangat drastis. Selain itu, lapisan lemak putih pada tubuh bayi perlu dipertahankan guna menjaga kestabilan suhu tubuh (Delima & Andriani, 2019).

Fokus utama lainnya dalam perawatan bayi baru lahir adalah upaya pemberian ASI. Keberhasilan proses menyusui ke depannya sangat bergantung pada pemahaman ibu mengenai teknik menyusui yang benar. Saat menyusui pastikan posisi ibu tepat, karena bisa mengoptimalkan pemberian ASI dan menghindari puting lecet. Perbaiki posisi menyusui dengan memastikan kepala dan mulut bayi melekat pas pada payudara (Priscilla, 2016).

G. Penutup

Masa neonatal, yang dimulai sejak bayi lahir hingga usia 28 hari, merupakan periode transisi yang paling dramatis dan krusial dalam siklus kehidupan manusia. Perubahan dari lingkungan intrauterin yang hangat dan bergantung sepenuhnya pada ibu menuju lingkungan ekstrauterin menuntut bayi untuk segera melakukan adaptasi fungsional pada sistem vital seperti pernapasan, kardiopulmoner, hingga metabolisme mandiri. Ketidakmampuan dalam mencapai homeostasis pada fase kritis ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius, mengingat periode ini memiliki angka fatalitas yang tinggi dibandingkan rentang usia lainnya, dengan risiko terbesar terjadi pada 24 jam pertama kelahiran.

Keberhasilan transisi ini sangat didukung oleh intervensi klinis yang tepat dan segera. Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada satu jam pertama kelahiran terbukti secara signifikan menurunkan mortalitas neonatal, membantu stabilisasi detak jantung, serta merangsang hormon oksitosin untuk kesehatan ibu. Sejalan dengan itu, pencegahan hipotermia menjadi aspek yang tidak boleh terabaikan; stabilitas suhu tubuh bayi harus dijaga secara ketat melalui lingkungan yang hangat dan

penggunaan pelindung kepala guna mencegah stres metabolik dan kegagalan fungsi organ.

Melalui pelaksanaan skrining awal yang sistematis berdasarkan standar operasional, tenaga kesehatan dapat melakukan penilaian komprehensif terhadap fungsi vital dan mendeteksi anomali kongenital secara dini. Namun, pengawasan ini tidak berakhir di rumah sakit; edukasi kepada orang tua mengenai perawatan bayi di rumah seperti teknik menyusui yang benar, perawatan tali pusat yang bersih untuk mencegah infeksi, serta prosedur memandikan bayi yang aman menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlangsungan kesehatan neonatus.

Sinergi antara kompetensi klinis perawat dalam melakukan pengkajian yang cepat dan tepat, serta kemampuan dalam memberdayakan keluarga melalui edukasi yang aplikatif, adalah fondasi utama dalam menjamin keberhasilan adaptasi bayi. Dengan pemahaman yang menyeluruh terhadap setiap aspek perawatan, diharapkan para praktisi kesehatan dapat memberikan layanan yang komprehensif, promotif, dan preventif demi mewujudkan kualitas hidup bayi baru lahir yang optimal di masa depan.

Oleh karena itu, buku referensi ini hadir sebagai panduan aplikatif bagi para tenaga kesehatan dan akademisi untuk memahami bahwa setiap detik di awal kehidupan neonatus adalah waktu yang sangat berharga. Melalui penerapan asuhan keperawatan yang sistematis, berbasis bukti, dan berorientasi pada keselamatan pasien, tantangan global terkait angka kematian bayi dapat ditekan secara signifikan. Besar harapan agar seluruh materi yang tertuang dalam buku ini mampu menjadi referensi yang memperkaya wawasan sekaligus meningkatkan standar kualitas pelayanan keperawatan neonatus di berbagai fasilitas kesehatan.

Referensi

- Apgar, V. (1953). A proposal for a new method of evaluation of the newborn infant. *Anesthesia & Analgesia*, 32(4), 260-267.
- Asyaul Wasiah, Salsabila Artamevia, (2021). Pelatihan Perawatan Bayi Baru Lahir. *Journal of Community Engagement In Health*, 4(2), pp. 337-343.
- Delima, M., & Andriani, Y. (2019). Memandikan bayi dan perawatan tali pusat bayi baru lahir di RSI Ibnu Sina Yarsi Bukittinggi. *Jurnal Abdimas Kesehatan Perintis*, 1(1), 26–30.
- Kartika, K., & Lestari, H. E. P. (2021). Pemberian Edukasi Perawatan Bayi Baru Lahir Pada Kelas Ibu Hamil. *Jurnal Bhakti Civitas Akademika*, 4(1), 38–44.

- Kementerian Kesehatan RI. (2020). Pedoman Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial. Jakarta: Kemenkes RI.
- Koop, L.K & Tadi, P. (2023). Physiology, Heat Loss. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK541107/>
- Laptook, A.R. (2024). Neonatal thermoregulation: A cornerstone of care or forgotten principles?. *Pediatr Res* 95, 139831399 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41390-023-03009-y>
- Mawaddah, S. (2018). Hubungan Inisiasi Menyusu Dini. *Info Kesehatan*, 16(02), pp. 214-225.
- Nuzura, A.A. & Lee, K. (2018). Malaysian Primipara's Knowledge And Practice On Newborn Care During The Postnatal Period. *International Journal of Public Health and Clinical Sciences*. 1(2). 132-143
- Pricilia, V. (2016). Perawatan Bayi Baru Lahir dengan Pendekatan Model Mother-Baby Care (M-BC) Sebagai Inovasi dalam Upaya Memandirikan Ibu Postpartum. *NER'S Jurnal Keperawatan*, 9(1), 39. Halaman | 44 <https://doi.org/10.25077/njk.9.1.39-44.2013>
- Rohani Siregar. (2022). Pelatihan dan pendampingan Kader Tentang Perawatan Payudara Pada Ibu Hamil Trimester III Dalam Persiapan Menyusu Dini dan Pemberian Kolostrum di Desa Karangraharja Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. SELAPARANG: *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(4), 2082–2087.
- Rohani Siregar. (2023). Factors Associated with Knowledge of Third Trimester Pregnant Women About Benefits of Giving Colostrum to Newborns Baby. 15(01), 51– 61
- Ryan, F. (2024). Nurturing Neonatal Comfort: Understanding and Managing Thermoregulation in Newborns. *J. Neo. Stud.* 7(2), 194-196. DOI: 10.37532/JNS.2024.7(2).194-196
- Setiyani, A., Pen, S. A. P. and Asyuananik. (2016). Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Prasekolah. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Subekti, N. B., Karyuni, P. E. and Meilya, E. (2019). Buku Saku Manajemen Masalah Bayi Baru Lahir Panduan untuk Dokter, Perawat dan Bidan. Jakarta: EGC.
- Tim Riskesdas 2018. (2018). Laporan Provinsi Jawa Timur RISKESDAS 2018. In Kementerian Kesehatan RI.

<https://drive.google.com/drive/folders/1XYHFQuKucZIwmCADX5ff1aDhfJgqzI-I%0A>

Wasiah, A., & Artamevia, S. (2021). Pelatihan Perawatan Bayi Baru Lahir. *Journal of Community Engagement in Health*, 4(2), 337–343.
<https://doi.org/10.30994/jceh.v4i2.167>

World Health Organization. (2017). WHO recommendations on newborn health. *Geneva: WHO*.

Yunura, I., NR, PH, & Ernita, L. (2023). Pengaruh Inisiasi Menyusui Dini (Imd) Terhadap Suhu Tubuh Bayi Baru Lahir Di Pmb Hj Hendriwati, S.St Tahun 2022. *Jurnal Ners*, 7(1), 599-604.

PROFIL PENULIS



Ernawati, S. Kep., Ns., M. Kes., M. Kep. Lahir di Labuaja pada 29 Juli 1992, menempuh Pendidikan S1 Keperawatan selesai tahun 2015 dan Profesi Ners selesai tahun 2017 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK Makassar) dan melanjutkan pendidikan S2 kesehatan masyarakat program studi kesehatan reproduksi di kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) selesai tahun 2019. Selanjutnya melanjutkan pendidikan S2 keperawatan program studi keperawatan maternitas di kampus Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi (UNJANI) selesai pada tahun 2024.

Pertama kali bekerja sebagai dosen ilmu keperawatan di STIKes Widya Nusantara Palu pada tahun 2019 dan saat ini bekerja di Universitas Famika Makassar (UNF) dari tahun 2023 hingga sekarang sebagai dosen keperawatan. Selain mengabdikan diri sebagai seorang akademisi penulis juga aktif sebagai seorang praktisi keperawatan sejak 2018 membuka praktek mandiri keperawatan Assyauqie Medikal Centre sampai sekarang. Penulis juga aktif dibidang kediklatan sebagai fasilitator pelatihan di Pro Emergency. Selain itu penulis juga aktif di organisasi profesi dan badan kelengkapan (BAPENA) kota makassar. Hingga kini tetap berdedikasi untuk mengembangkan dunia keperawatan, baik di lingkup akademis maupun praktisi, khususnya di Indonesia Timur.

Penulis dapat dihubungi melalui email andiernamuhtar92@gmail.com

Motto: "Hidup adalah ibadah, setiap langkah harus bernilai kebaikan"



Handayani, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat. Lahir di Yogyakarta, 5 Juni 1974. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia lulus tahun 1997. Kemudian melanjutkan pendidikan Spesialis Keperawatan Maternitas pada Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2005. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1997 di Akper Sismadi Jakarta, tahun 1999 di Akper Husda Karya Jaya Jakarta dan tahun 2000 di Akper Bani Saleh Bekasi. Saat ini penulis bekerja di Universitas Binawan dari tahun 2005 mengampu mata kuliah Keperawatan Maternitas di Program Profesi

Ners, mata kuliah Maternity Nursing dan mata kuliah Women Reproductive Health in Nursing. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail handayani@binawan.ac.id



Dr. Ns. Sri Djuwitaningsih, S.Kp, M.Kes, Sp.Mat. adalah seorang akademisi dan praktisi di bidang keperawatan, khususnya keperawatan maternitas. Pendidikan yang dilalui mulai dari D.III Keperawatan di Akper Dep.Kes.RI.Jakarta lulus pada tahun 1986, S1 di PSIK-FKUI pada tahun 1995, selanjutna S2, Spesialis Kep.Maternitas, dan S3 di Fakultas ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, lulus berturut-turut pada tahun 2004, 2005 dan 2020.

Sejak tahun 1986 sampai dengan saat ini mengemban tugas di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta III, sebagai dosen di Jurusan Keperawatan, di Departemen Keperawatan Maternitas. Telah menghasilkan Karya dalam bidang tridarma perguruan tinggi dengan fokus pada pengembangan ilmu keperawatan, khususnya Keperawatan Maternitas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: djuwitaningsih.sri@gmail.com



Megayana Yessy Maretta, SST., M.Keb. lahir di Surakarta, 19 Maret 1991. Penulis menyelesaikan pendidikan D IV Bidan Pendidik di Universitas Sebelas Maret Surakarta dan lulus pada tahun 2014. Penulis lalu melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan di Universitas Padjadjaran Bandung dan lulus pada tahun 2018. Penulis merupakan dosen tetap di Universitas Kusuma Husada Surakarta yang bekerja sejak tahun 2014-sekarang. Saat ini penulis memiliki homebased di Prodi Pendidikan Profesi Bidan Universitas Kusuma Husada Surakarta 2018-sekarang. Penulis pernah mendapatkan hibah pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh Kemendikbudristek pada tahun 2022, selain itu penulis juga memiliki beberapa produk HKI hasil dari penelitian dalam bidang pranikah prakonsepsi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: megapastibisa@gmail.com.

Motto: "Lakukanlah suatu kebaikan walaupun itu melelahkan, karena lelahnya akan hilang tapi kebbaikannya akan tetap bertahan"



Regina Ona Adesta, S.Kep., Ns., M.Kep. Lahir di Kloanggelot, Kabupaten Sikka, NTT, pada tanggal 15 Mei 1986. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis diawali dari jenjang Diploma III Keperawatan pada Program Studi Diploma III Keperawatan, Universitas Nusa Nipa, lulus tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan S1 pada Program Studi S1 Ilmu Keperawatan pada Universitas Nusa Nipa, lulus tahun 2013. Penulis kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan Magister Keperawatan di Universitas Gadjah Mada tahun 2015-20217. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2010 sebagai asisten dosen. Kemudian diangkat menjadi Dosen Tetap di Universitas Nusa Nipa pada tahun 2017 – sekarang, sebagai dosen pengampu Mata Kuliah Keperawatan Maternitas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, serta sebagai penulis buku, peneliti, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: reginadianto@gmail.com



Asmarita Jasda, S.Kep,M.Si.Med. Lahir di Bangkinang, 01 Juni 1980. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 Keperawatan pada Universitas Pahlawan lulus Tahun 2001. Jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 ke program megister Ilmu Biomedik peminatan Ilmu Kesehatan Reproduksi di Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2012 dan lulus tahun pada tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2001 Tenaga Perawat Pelaksana Di RSUD Bangkinang, tahun 2003 sebagai ASN Tendik laboratorium di Poltekkes Kemenkes Riau Kelas Jauh Keperawatan Tanjungpinang. Pada tahun 2006 menjadi Dosen di Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang Hingga saat ini. Saat ini penulis mengampu mata kuliah yaitu Ilmu Biomedik Dasar, Farmakologi Keperawatan, Keperawatan Anak, Keperawatan Maternitas dan Metodologi Penelitian. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: asmarita.jasda@poltekkes-tanjungpinang.ac.id

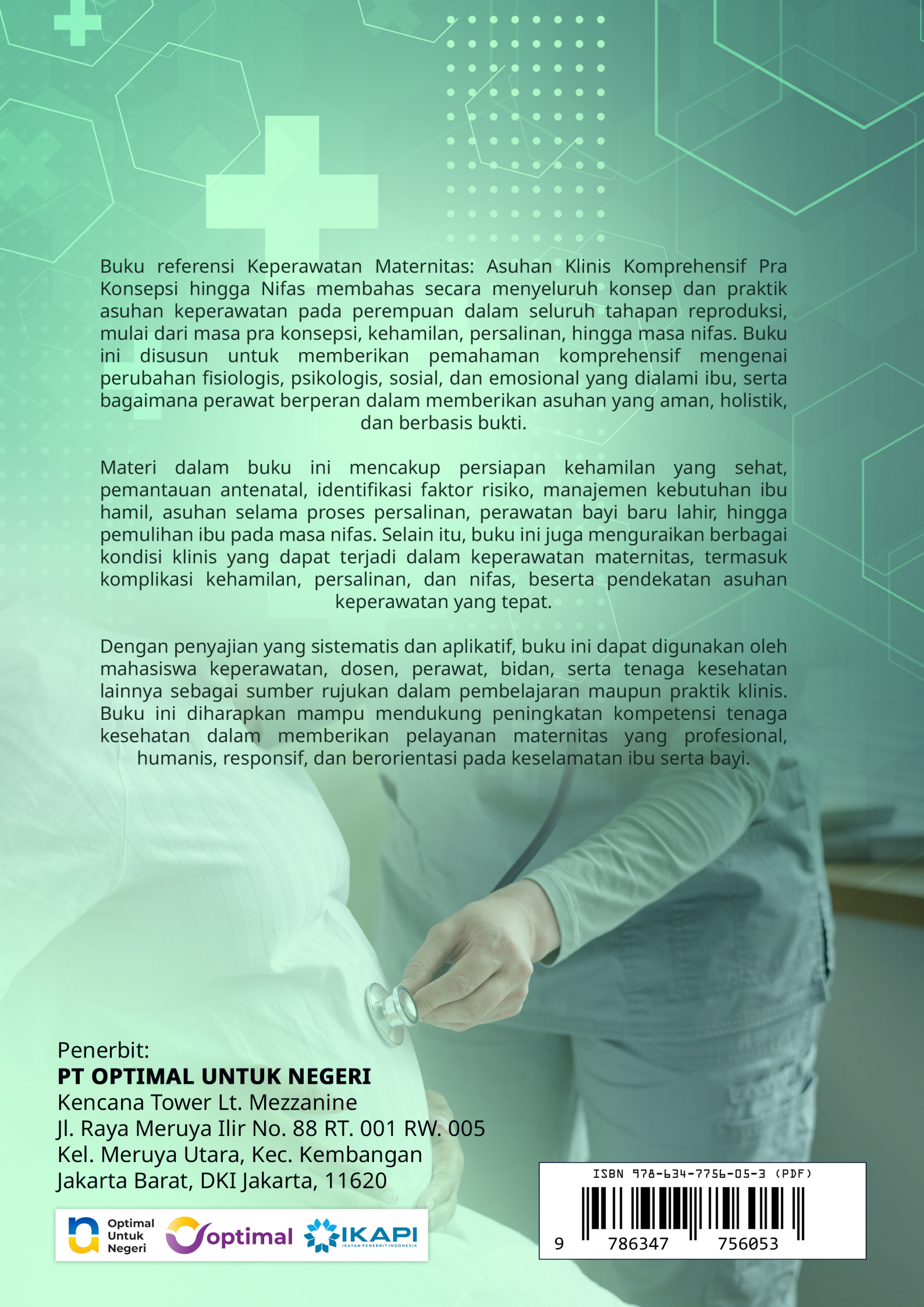
Motto: "Mendidik dengan ilmu, membimbing dengan hati."

Sinopsis

Buku referensi Keperawatan Maternitas: Asuhan Klinis Komprehensif Pra Konsepsi hingga Nifas membahas secara menyeluruh konsep dan praktik asuhan keperawatan pada perempuan dalam seluruh tahapan reproduksi, mulai dari masa pra konsepsi, kehamilan, persalinan, hingga masa nifas. Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai perubahan fisiologis, psikologis, sosial, dan emosional yang dialami ibu, serta bagaimana perawat berperan dalam memberikan asuhan yang aman, holistik, dan berbasis bukti.

Materi dalam buku ini mencakup persiapan kehamilan yang sehat, pemantauan antenatal, identifikasi faktor risiko, manajemen kebutuhan ibu hamil, asuhan selama proses persalinan, perawatan bayi baru lahir, hingga pemulihan ibu pada masa nifas. Selain itu, buku ini juga menguraikan berbagai kondisi klinis yang dapat terjadi dalam keperawatan maternitas, termasuk komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas, beserta pendekatan asuhan keperawatan yang tepat.

Dengan penyajian yang sistematis dan aplikatif, buku ini dapat digunakan oleh mahasiswa keperawatan, dosen, perawat, bidan, serta tenaga kesehatan lainnya sebagai sumber rujukan dalam pembelajaran maupun praktik klinis. Buku ini diharapkan mampu mendukung peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan maternitas yang profesional, humanis, responsif, dan berorientasi pada keselamatan ibu serta bayi.



Buku referensi Keperawatan Maternitas: Asuhan Klinis Komprehensif Pra Konsepsi hingga Nifas membahas secara menyeluruh konsep dan praktik asuhan keperawatan pada perempuan dalam seluruh tahapan reproduksi, mulai dari masa pra konsepsi, kehamilan, persalinan, hingga masa nifas. Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai perubahan fisiologis, psikologis, sosial, dan emosional yang dialami ibu, serta bagaimana perawat berperan dalam memberikan asuhan yang aman, holistik, dan berbasis bukti.

Materi dalam buku ini mencakup persiapan kehamilan yang sehat, pemantauan antenatal, identifikasi faktor risiko, manajemen kebutuhan ibu hamil, asuhan selama proses persalinan, perawatan bayi baru lahir, hingga pemulihan ibu pada masa nifas. Selain itu, buku ini juga menguraikan berbagai kondisi klinis yang dapat terjadi dalam keperawatan maternitas, termasuk komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas, beserta pendekatan asuhan keperawatan yang tepat.

Dengan penyajian yang sistematis dan aplikatif, buku ini dapat digunakan oleh mahasiswa keperawatan, dosen, perawat, bidan, serta tenaga kesehatan lainnya sebagai sumber rujukan dalam pembelajaran maupun praktik klinis. Buku ini diharapkan mampu mendukung peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan maternitas yang profesional, humanis, responsif, dan berorientasi pada keselamatan ibu serta bayi.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7756-05-3 (PDF)



9

786347

756053

